

Orientaciones Técnicas Programa Planes de Promoción de la Salud para Municipios Comunas y Comunidades Saludables 2025-2028

PLANES DE PROMOCIÓN DE SALUD

DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DIPOL/MINSAL

EDITORES:

Patricia Zamora, Carolina Cobos, Alejandro Aguayo, Juan Carlos Molina, Carmen Gloria González, Matías Portela, Romina Galdames, Geraldine Torrens y Tatiana Puebla.

Santiago, Chile 2025.

Contenido

INTRODUCCIÓN..... 3

ANTECEDENTES 4

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 8

PLANES COMUNALES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD 2025-2028 16

 DIMENSIONES 18

 COMPONENTES 27

 ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN 31

 EVALUACIÓN..... 51

REFERENCIAS 52

ANEXOS 55

 ANEXO N° 1 Pauta de validación de Planes de Promoción de la Salud para Municipios, Comunas y Comunidades Saludables 55

 ANEXO 2 Pauta para evaluar la incorporación de enfoque de Género en los Planes de Promoción de la Salud para Municipios, Comunas y Comunidades Saludables..... 60

 ANEXO N° 3 Pauta de evaluación de coherencia de Planes de Promoción de la Salud para Municipios, Comunas y Comunidades Saludables..... 69

 ANEXO N° 4 Instructivo cuestionario de evaluación de efectividad y calidad de actividades de Planes de Promoción de la Salud para Municipios, Comunas y Comunidades Saludables 70

 ANEXO N° 5 Análisis de contexto para los Planes de Promoción de la Salud para Municipios, Comunas y Comunidades Saludables..... 74

 ANEXO N° 6 Indicadores..... 80

 ANEXO N°7 Matriz de actividades de Planes de Promoción de la salud para Municipios, Comunas y Comunidades saludables..... 83

 ANEXO N° 8 Formato de convenio de Planes de Promoción de la Salud para Municipios, Comunas y Comunidades saludables..... 103

INTRODUCCIÓN

Chile enfrenta el desafío de construir entornos que promuevan la salud, el bienestar y la sostenibilidad para toda la población, con énfasis en reducir las brechas de acceso a la actividad física, la salud mental y estilos de vida saludables. Este compromiso está alineado con el Programa de Gobierno del presidente Gabriel Boric Font, que prioriza el pilar de Bienestar y Cultura de Vida Sana y busca avanzar hacia "Una sociedad activa", fomentando actividades físicas integradas en las rutinas comunitarias, potenciando la movilidad urbana activa y promoviendo una cultura que valore la salud mental como parte esencial del bienestar integral. A su vez dentro de las primeras medidas consideradas en el programa de gobierno en materia de salud se encuentra la de "generar condiciones de vida que protejan a las personas", lo cual se plantea desde la perspectiva de un "derecho a vivir en un entorno que no enferme".

En este marco, las políticas públicas se proponen generar dichas condiciones de vida, entendiendo la salud como un derecho fundamental. Este enfoque reconoce que un entorno saludable no solo previene enfermedades físicas, sino que también protege y fortalece la salud mental de la población, elementos claves para el bienestar colectivo.

El Programa Planes de Promoción de la Salud para Municipios, Comunas y Comunidades Saludables busca abordar el déficit de acceso a entornos saludables, entendidos como aquellos que promueven el consumo de agua, alimentación saludable, actividad física regular, asociatividad y participación comunitaria.

Este enfoque es crucial ante el creciente problema de la inactividad física y los desafíos de salud mental en niños, niñas y adolescentes (NNA), que representan un problema de salud pública crítico en Chile. Basándose en recomendaciones de la OMS y la OPS, se resalta la importancia de hábitos saludables que incluyan no solo la alimentación y la actividad física, sino también el cuidado de la salud mental, el manejo del estrés y un sueño de calidad como pilares esenciales para el bienestar integral y el desarrollo humano.

Complementando estas acciones, el programa también impulsa el acceso a alimentos frescos y de alto valor nutricional, promoviendo dietas equilibradas que contribuyan al bienestar físico y psicológico. Para ello, se priorizan políticas que garanticen la disponibilidad de alimentos saludables y sostenibles a precios accesibles. Asimismo, se promueven cambios estructurales en el medio ambiente, diseñando espacios que favorezcan estilos de vida activos y entornos que apoyen la convivencia y el ejercicio. En paralelo, se fomenta la salud mental dentro de la comunidad, fortaleciendo la asociatividad y promoviendo actividades que impulsen la cohesión social, el ocio, el descanso y el desarrollo de un sentido de pertenencia, esenciales para mejorar la calidad de vida y construir comunidades resilientes.

En este contexto, el Programa Planes de Promoción de la Salud para Municipios, Comunas y Comunidades Saludables, desempeña un rol clave. Este programa fortalece el papel de los municipios como actores estratégicos en la promoción de la salud integral, permitiendo acciones con pertinencia territorial, que abarcan mejoras en espacios públicos, acceso a alimentación saludable, promoción de actividad física, fortalecimiento del apoyo comunitario y creación de políticas locales que fomenten entornos saludables y emocionalmente seguros.

Con estas orientaciones técnicas para los Planes de promoción de la Salud para Municipios, Comunas y Comunidades Saludables 2025-2028, Chile renueva su compromiso con la creación de ciudades y comunidades más saludables, integrando estrategias que promuevan la salud mental, el bienestar integral y la sostenibilidad como derechos fundamentales y ejes de desarrollo integral para toda la población.

ANTECEDENTES

Basándose en el compromiso mundial con la promoción de la salud establecido en la Declaración de Alma-Ata (1978) y la Carta de Ottawa (1986), las conferencias mundiales de promoción de la salud organizadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) han instado a la formulación de políticas públicas saludables, la creación de entornos que favorezcan la salud y el fortalecimiento de la capacidad para abordar los determinantes sociales de la salud a través de un enfoque de promoción de la salud (OPS/OMS, 2022). (*Estrategia Y Plan De Acción Sobre La Promoción De La Salud En El Contexto De Los Objetivos De Desarrollo Sostenible 2019-2030, OPS, 2019*).

Entendiendo la Promoción de la Salud como un proceso político y social global que abarca acciones dirigidas a fortalecer las habilidades y capacidades de los individuos y de las comunidades, aún más importante, acciones dirigidas a modificar las condiciones sociales, ambientales y económicas, con el fin de favorecer su impacto positivo en la salud individual y colectiva (OPS/OMS, s.f.).

Para promover la salud, es indispensable que el Gobierno y la sociedad propongan un enfoque que genere soluciones colectivas para mejorar la salud como parte integrante del bienestar y del desarrollo económico y social. Esta concepción de la promoción de la salud está intrínsecamente vinculada con los determinantes sociales de la salud, entendidos como fuerzas y sistemas incluyen políticas y sistemas económicos, programas de desarrollo, normas y políticas sociales y sistemas políticos.

Promoción de la Salud para Municipios, Comunas y Comunidades Saludables

En la Región de las Américas el Movimiento de Municipios, Comunas y Comunidades Saludables (MCCS) es una plataforma que ha sido impulsado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), de municipios que fomenta la cooperación estratégica entre ellos para la mejora de la salud y el bienestar de sus poblaciones en torno a una visión regional común. El Movimiento MCCS comenzó en 1991 a raíz de la iniciativa Red Europea de Ciudades Saludables de la OMS, con el objetivo de posicionar la salud en un lugar destacado de la sociedad y de la agenda política de las ciudades mediante la promoción de la salud, la equidad y el desarrollo sostenible a través de innovación y cambio multisectorial.

Un MCCS es aquel que se compromete con la promoción de la salud, el bienestar y la equidad a través de la implementación de políticas públicas saludables, intersectoriales y participativas. Cada

municipio saludable debe basar sus políticas en el derecho humano a la salud y en los valores de justicia social, igualdad de género, solidaridad, inclusión y desarrollo sostenible (OPS/OMS, 2024).

En Chile el Programa de Planes Comunales de Promoción de la salud, fue creado el año 1998, pasando por diferentes evaluaciones y reformulaciones que dan forma a su expresión actual desde 2016. En las secciones de modelo de gestión y estrategia de intervención se entregan más detalles acerca del programa.

Rol de las Municipalidades en Promoción de la Salud

Según la Estrategia Regional de promoción de la Salud al 2030 de OPS-OMS “la gobernanza implica, entre otras cosas, que los gobiernos tienen la responsabilidad fundamental a nivel local, nacional y mundial de formular políticas de salud y justicia social por medio de procesos democráticos que benefician a toda la sociedad y, al mismo tiempo, de abordar los efectos perjudiciales de la producción y el consumo insostenibles y las prácticas empresariales negativas” (OPS/OMS, 2022)

De acuerdo con los criterios regionales para MCCS de la OPS-OMS en los últimos años, los gobiernos locales urbanos y rurales han ido asumiendo desafíos crecientes para alcanzar más y mejor salud, bienestar y equidad. Para ello, han implementado políticas públicas participativas e intersectoriales que han permitido actuar sobre los determinantes sociales de la salud.

La importancia de la gobernanza por la salud y el bienestar se centra en la responsabilidad fundamental que tienen los gobiernos de formular políticas públicas saludables y equitativas que contribuyan al bienestar de la población. Se resalta el papel clave de los gobiernos locales en promover la salud a través de la acción intersectorial, la participación social y la construcción del desarrollo social (OPS/OMS, 2024).

En Chile los municipios tienen un rol importante en la salud pública, no sólo por el rol que tienen en las condiciones de vida de la población, sino que también por su responsabilidad de administrar y operar gran parte de los establecimientos de atención primaria, velando por su buen funcionamiento y por el cumplimiento de los objetivos del Ministerio de Salud.

Además, el municipio es un actor estratégico en mejorar los resultados en salud, y requiere de un liderazgo que tenga en cuenta no solamente los puntos críticos del territorio, sino también sus riquezas y potencialidades para que puedan ser utilizadas localmente al servicio de la comunidad. En este sentido, se hace necesario que las autoridades municipales estén convencidas del potencial transformador del binomio promoción de la salud/ desarrollo local que la estrategia propone. Las autoridades municipales deben procurar construir alianzas estratégicas intersectoriales para mejorar las condiciones sociales y sanitarias en los espacios donde viven las personas. Las decisiones políticas deben contemplar planes, programas, acuerdos y acciones a implementarse a través de legislación, normas y reglamentos de carácter local.

El municipio dispone de toda su estructura para el logro de los objetivos que implican el mejoramiento de la calidad de vida de la población, desde las distintas áreas de su quehacer.

Para lograr dicho objetivo es fundamental levantar procesos de formación con tomadores de decisión de diversas áreas de los municipios tales como SECPLA, DIDECO, DAEM, del rol protagónico de las autoridades, incentivando la participación de todas las áreas involucradas.

A continuación, se presentan ejemplos de estrategias que han impulsado diversos municipios en Chile en el marco de la estrategia Municipios Comunas y Comunidades Saludables.

Ejemplos de estrategias que han impulsado diversos municipios en Chile en el marco de la estrategia Municipios Comunas y Comunidades Saludables.

Dependencia municipal	Estrategias
Alcaldía	Adhesión al movimiento Municipios, Ciudades y Comunidades Saludables (MCCS-OPS)
SECPLAN	Aumentar número y calidad puntos de venta de alimentos frescos (frutas, verduras, pescados, etc) tales como ferias libres, mercados campesinos, u otros.
DIDECO	Revisión nutricional de canastas familiares
Salud	Modelo de atención integral de salud familiar y comunitaria
Educación	Desayuno a primera hora, transporte activo escolar.
Fiscalización	Ordenanza de Prohibición de venta de “alimentos altos en” el perímetro de Establecimientos educacionales y/o abstención de otorgar permisos de venta de éstos.
Medio Ambiente	Huertos Comunitarios -Reciclaje-Compostaje-SCAM
Tránsito	Seguridad vial-Ciclovías. Calles de uso exclusivo de bicicletas en fines de semana.
Rentas	Patentes: Sobrecargo por publicidad alcohol y alimentos no saludables en vía pública. Ordenanza que establece monto diferenciado de patentes para instalaciones de ventas menores en las que más del 50% de sus productos son saludables.
Obras	Implementación de infraestructura actividad física, bebederos de agua, ordenanzas conjuntos habitacionales que cuenten con espacios para la actividad física.

Fuente: Elaboración propia Departamento de Promoción de la Salud y Participación Ciudadana.

Cada municipio debe tener en cuenta sus propias prioridades, problemas sociales y estructuras de gobierno al seleccionar las medidas de acción. Entre las consideraciones clave para elaborar una visión estratégica y un plan de ejecución se incluyen la detección de las necesidades y las dificultades, la comprensión de qué poblaciones o áreas geográficas se ven afectadas (OMS, 2020).

Los Determinantes Sociales de la Salud que plantean que “la desigualdad de las condiciones de vida está determinada por estructuras y procesos sociales más profundos. Las desigualdades son sistemáticas y son el resultado de normas, políticas y prácticas sociales que toleran o incluso favorecen

una distribución injusta del poder, la riqueza y otros recursos sociales necesarios, y del acceso a estos” (OMS, 2008).

Tanto en MCCA como en los Planes de Promoción de la Salud, los equipos locales municipales deben ser capaces de reflexionar sobre el territorio, los determinantes sociales de la salud y la calidad de vida, además de analizar las causas de las causas del aumento de conductas no saludables (como bajo consumo agua, bajo consumo de frutas y verduras, bajo consumo de pescados y mariscos, bajo consumo de legumbres, alto consumo de alimentos altos en nutrientes críticos, inactividad física), y de planificar una intervención a mediano plazo costo-eficaz y basada en la evidencia.

Esta estrategia mantiene un trabajo coordinado con la atención primaria salud, insertándose en los modelos de atención como el Modelo de Atención Integral De Salud (MAIS) y la Estrategia de Cuidado Integral Centrado en las Personas (ECICEP), en este modelo, una de sus líneas estratégicas es la promoción y la prevención con acciones tales como:

- Controlar y disminuir factores de riesgo de malnutrición, sedentarismo, tabaco y alcohol.
- Promover espacios de trabajo y educacionales saludables.
- Detección precoz de factores asociados a enfermedades crónicas.
- Favorecer el envejecimiento positivo y cuidados del cuidador.
- Coordinación intersectorial.
- Promover la participación comunitaria.

En la Declaración de Astaná del 2018 de la Conferencia Global de Atención Primaria se reconoce la promoción de la salud y la atención primaria de salud como estrategias complementarias para fortalecer los sistemas de salud a fin de obtener resultados equitativos (OPS/OMS, 2022).

El sector de la salud debe lograr que la promoción de la salud sea más pertinente y concreta, y colaborar con las comunidades para crear condiciones de vida saludables, sobre la base de la atención primaria de salud. Debe desarrollar además competencias en todo el personal de salud para que trascienda a su responsabilidad de prestar servicios clínicos y curativos.

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

El presente diagnóstico situacional se erige como un instrumento esencial para la comprensión profunda y multifacética de los factores que convergen en la salud y el bienestar de las personas y comunidades. A través de una metodología rigurosa y un enfoque holístico, capítulo se propone desentrañar la intrincada red de determinantes que moldean la calidad de vida de la población, trascendiendo la mera identificación de problemáticas para develar las dinámicas subyacentes que perpetúan las inequidades y obstaculizan el pleno desarrollo humano.

Este análisis se fundamenta en la concepción de la salud como un constructo multidimensional, que va más allá de la ausencia de enfermedad y abarca el completo bienestar físico, mental y social. En este sentido, se reconoce la intrínseca relación entre la salud individual y los contextos sociales, económicos, culturales y ambientales en los que se desenvuelven las personas.

El diagnóstico situacional analizará los determinantes sociales de la salud. Se explorará la cohesión social como elemento clave para la construcción de comunidades resilientes y solidarias, así como la equidad, la diversidad y la inclusión como principios rectores para garantizar que todas las personas, sin importar su origen, género, orientación sexual, capacidad o cualquier otra característica, tengan acceso a las mismas oportunidades de salud y bienestar. La participación ciudadana será considerada como pilar fundamental para la promoción de la salud. La salud mental será abordada como un componente esencial del bienestar, reconociendo su impacto en la calidad de vida y su estrecha relación con los demás determinantes sociales. Finalmente, se explorará la diversidad cultural como una fuente de riqueza y fortaleza, promoviendo la interculturalidad como un enfoque que valora y respeta las diferentes cosmovisiones y prácticas en torno a la salud.

Este diagnóstico situacional no se limita a la mera descripción de la realidad, sino que busca generar un conocimiento transformador que sirva de base para la acción. A partir de la comprensión profunda de los factores que influyen en la salud de la población, se podrán diseñar e implementar políticas, programas e intervenciones que promuevan la salud y el bienestar de manera integral, equitativa y sostenible, contribuyendo así a la construcción de una sociedad más justa y saludable para todos.

DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD

Los determinantes sociales de la salud son los factores no médicos que influyen en los resultados de salud. De acuerdo con la OMS “son las condiciones en las que las personas nacen, crecen, trabajan, viven y envejecen, y el conjunto más amplio de fuerzas y sistemas que dan forma a las condiciones de la vida cotidiana” (OPS/OMS, s.f.). Estas fuerzas y sistemas incluyen políticas y sistemas económicos, agendas de desarrollo, normas sociales, políticas sociales y sistemas políticos. Es decir, tienen una influencia importante en las desigualdades en materia de salud

Aquí algunos datos estadísticos de la población en Chile para comprender como a través de estos se pueden ir asociando a los determinantes sociales de la salud. El territorio nacional tiene una superficie de 756.102,4 kms². La región de mayor extensión es la de Magallanes (132.297,2 kms²) y la que cuenta con menor superficie corresponde a la Metropolitana (15.403,2 kms²).

La población proyectada para el año 2025 asciende a 20.206.953 personas, concentrándose el 40,3% de ellas en la Región Metropolitana (Instituto Nacional de Estadísticas, 2022).

Al relacionar la superficie con la población proyectada, se estima para el año 2025 una densidad de 26,51 Hab/km². La mayor densidad se registra en la Región Metropolitana (543,4 Hab/km²) y la menor corresponde a la Región de Aysén (1,0 Hab/km²). El 50,6% de la población es mujer, con un índice de masculinidad de 98 hombres por cada 100 mujeres.

De acuerdo con las proyecciones de población, al año 2025 un 11,3 % de las personas reside en zonas rurales. Por su parte, de acuerdo con la encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) del año 2022, la población que declara pertenecer a algún pueblo originario llega a un 12,8%, siendo la etnia de mayor magnitud, la Mapuche. Por otro lado, el porcentaje estimado de personas extranjeras residentes habituales en Chile al 31 de diciembre de 2021 es del 7,53 %.

La Pobreza Multidimensional ha sido entendida por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y localmente por la encuesta CASEN 2022, como un concepto más allá de la falta de ingresos para la satisfacción de necesidades, sino más bien como personas que sufren carencias en las dimensiones: educación, salud, trabajo, seguridad social, vivienda y nivel de vida en general.

Existe una clara relación bidireccional entre la pobreza multidimensional y los DSS. La pobreza limita el acceso a recursos y oportunidades que son cruciales para la salud, como una educación de calidad, vivienda adecuada, empleo digno y servicios de salud accesibles. A su vez, una salud deficiente puede perpetuar la pobreza al limitar la capacidad de las personas para trabajar, estudiar y participar plenamente en la sociedad.

A continuación, se presentan datos regionales sobre los Determinantes Sociales de la Salud (Ministerio de Salud, 2024)

Determinantes estructurales							
Unidad territorial	Porcentaje población originaria	Tasa neta de migración internacional	Porcentaje total personas pobres	Relación 20/20 de ingreso monetario	Promedio de años de escolaridad en personas de 25 y más años	Porcentaje participación laboral	Porcentaje personas desocupadas
Chile - total	11,87	0,62	6,50	8,24	11,90	62,30	8,60
Región de Tarapacá	23,4	1,30	11,00	6,11	11,98	64,30	9,40
Región de Antofagasta	13,21	1,53	7,60	7,27	12,15	62,50	9,30
Región de Atacama	18,19	0,39	8,20	6,51	11,50	59,90	8,80
Región de Coquimbo	8,19	0,26	7,90	8,36	11,35	57,30	9,10
Región de Valparaíso	6,35	0,25	6,60	6,46	11,95	60,30	9,80
Región de O'Higgins	6,00	0,19	7,00	6,36	10,84	59,30	9,10
Región del Maule	4,49	0,13	8,70	5,33	10,49	57,90	8,40
Región del Biobío	10,22	0,10	7,50	6,96	11,53	55,70	9,50
Región de La Araucanía	32,3	0,09	11,60	6,79	10,77	54,50	10,40
Región de Los Lagos	26,29	0,11	7,00	6,65	10,53	58,60	6,90
Región de Aysén	27,59	0,00	4,00	6,77	11,24	67,80	5,30
Región de Magallanes	22,06	0,31	3,40	6,28	12,00	64,10	3,80
Región Metropolitana	9,26	1,05	4,40	8,75	12,76	67,70	8,20
Región de Los Ríos	24,17	0,09	5,90	6,24	10,92	59,30	7,90
Región de Arica y Parinacota	33,27	0,62	9,20	5,57	12,16	61,70	9,40
Región de Ñuble	4,46	0,10	12,10	5,99	10,41	51,60	9,70

Los datos presentados en la tabla evidencian la existencia de importantes desigualdades entre las regiones de Chile. Estas desigualdades se manifiestan en diferentes ámbitos, como la pobreza, la educación, el ingreso, el empleo y la participación de los pueblos originarios. Abordar estos determinantes es fundamental para promover la salud y el bienestar de la población de manera equitativa y sostenible.

A continuación, la siguiente tabla proporciona información sobre elementos psicosociales y su relación con la salud y el bienestar en diferentes regiones de Chile (Ministerio de Salud, 2024).

Unidad territorial	Porcentaje personas disponible de redes de apoyo	Porcentaje personas que participa en organizaciones	Porcentaje hogares victimizado	Tasa de denuncia de violencia intrafamiliar	Población adulta (18 años y más) en situación de dependencia	Media nota satisfacción con la vida	Porcentaje que evalúa su salud como muy buena o buena
Chile - total	81,20	47,70	16,90	621,65	9,80	7,63	57,75
Región de Tarapacá	80,54	52,04	30,10	1.103,61	6,20	8,27	61,13
Región de Antofagasta	95,91	55,98	16,60	638,64	4,50	8,26	69,47
Región de Atacama	74,31	61,21	10,90	643,07	9,70	8,71	49,53
Región de Coquimbo	80,67	45,28	13,70	678,30	5,90	7,77	59,33
Región de Valparaíso	85,09	45,03	15,00	589,11	9,00	7,70	57,10
Región de O'Higgins	79,17	46,47	15,00	737,55	9,40	7,78	56,96
Región del Maule	78,86	36,97	10,90	750,71	7,30	7,27	53,95
Región del Biobío	82,60	65,20	12,80	694,34	9,90	7,93	54,58
Región de La Araucanía	82,59	54,51	12,80	728,59	11,50	7,45	54,25
Región de Los Lagos	87,68	57,52	7,90	927,97	9,80	7,73	55,70
Región de Aysén	66,65	51,16	3,90	614,55	10,30	6,45	60,97
Región de Magallanes	85,87	51,43	3,20	578,55	4,60	8,19	64,33
Región Metropolitana	78,58	41,12	20,80	485,66	11,00	7,43	59,22
Región de Los Ríos	84,18	59,88	13,80	703,20	11,60	7,89	57,71
Región de Arica y Parinacota	79,77	46,57	29,40	1.099,25	7,70	7,56	51,86
Región de Ñuble	NA	NA	13,80	647,31	13,10	NA	NA

- La cohesión social y la participación comunitaria son factores importantes para la salud y el bienestar. Las regiones con mayor participación en organizaciones tienden a mostrar mejores indicadores de salud percibida y satisfacción con la vida.
- La violencia intrafamiliar es un problema que afecta a todas las regiones, pero con mayor incidencia en algunas zonas. Es necesario fortalecer las políticas de prevención y atención a las víctimas.
- La situación de dependencia en la población adulta es un desafío importante, especialmente en la Región Metropolitana. Se requieren políticas y programas que brinden apoyo y atención a las personas mayores y con discapacidad.
- Existen desigualdades regionales en la salud y el bienestar. Es necesario implementar políticas públicas que aborden estos determinantes psicosociales de manera integral y contextualizada, considerando las particularidades de cada región.

Abordar las desigualdades regionales en salud y bienestar a través de políticas públicas que consideren los determinantes sociales y promuevan la equidad.

Actualmente en todo el país se encuentran los niveles bajos de actividad física, esto es motivo de especial preocupación para los Planes de Promoción de la Salud; ser físicamente activo puede mejorar

la función cognitiva, el desempeño académico y la salud mental, y también puede reducir los síntomas de depresión y ansiedad.

Por el contrario, dedicar mucho tiempo a conductas sedentarias puede ser dañino para la salud, ya que aumenta el riesgo de obesidad, empeorar la capacidad física y salud cardio metabólica, y puede afectar la duración del sueño.

EQUIDAD DE GÉNERO

El género es un determinante social de la salud, concretamente corresponde a la construcción social de la diferencia sexual. Se refiere a los roles, las características y oportunidades definidos por la sociedad que se consideran apropiados para los hombres, las mujeres, los niños, las niñas y las personas con identidades no binarias. El género es también producto de las relaciones entre las personas y puede reflejar la distribución de poder entre ellas. No es un concepto estático, sino que cambia con el tiempo y del lugar (OMS, 2018).

Expertos como Mora, Fritz y Valdés, indican que “La equidad de género involucra la tensión entre la igualdad y la diferencia, así como la complementariedad de la justicia social con la justicia cultural. Es decir, la justicia de género tiene connotaciones culturales y económicas, aspectos que requieren políticas de reconocimiento de las diferencias y aspectos que tienen que ver con políticas de redistribución, en el sentido de igual participación de los beneficios entre hombres y mujeres” (UNFPA, 2006).

En esta materia se han conseguido algunos avances durante las últimas décadas, pero el mundo está lejos de alcanzar la igualdad de género para 2030.

La medición del Bienestar Social en Chile 2023 (EBS) (Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 2023) muestra que existe una marcada brecha de género en el uso del tiempo las mujeres dedican en promedio 3,2 horas más que los hombres a deberes relacionados al hogar.

Junto a las diferencias por sexo, también existen diferencias socioeconómicas marcadas, especialmente en el tiempo dedicado al trabajo remunerado, que se incrementa al aumentar los ingresos, y en el tiempo dedicado al trabajo no remunerado en el hogar, que disminuye al aumentar los ingresos (Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 2020).

DIVERSIDAD E INCLUSIÓN

La diversidad e inclusión son valores fundamentales que contribuyen a construir sociedades más justas y equitativas. Estos conceptos son esenciales en una sociedad democrática y tienen un papel importante en el progreso.

La diversidad en Chile se refiere a la coexistencia de diferentes grupos sociales, étnicos, culturales, religiosos y de género, lo cual refleja la pluralidad en las identidades que conforman el país. Chile ha experimentado cambios importantes en su composición demográfica, principalmente a raíz de procesos migratorios recientes, el reconocimiento de los pueblos indígenas y el avance de los movimientos por los derechos de género y diversidad sexual.

La inclusión, entendida como la capacidad de una sociedad para integrar a todos sus miembros de manera equitativa, ha sido un desafío histórico en Chile. Pese a los avances legislativos y las políticas públicas que han buscado disminuir las brechas sociales, económicas y culturales, importantes sectores de la población aún enfrentan dificultades para acceder a los mismos derechos y oportunidades. Estas orientaciones técnicas buscan analizar el estado actual de la inclusión en Chile a través de indicadores clave, identificando las barreras que persisten y sugiriendo áreas de mejora para lograr una sociedad más justa.

La definición de inclusión en el contexto chileno implica garantizar que todos los ciudadanos, sin distinción de etnia, género, orientación sexual, discapacidad o situación socioeconómica, tengan acceso equitativo a servicios básicos como educación, salud, empleo y participación en la vida pública. Se trata de generar un entorno donde las diferencias sean reconocidas y valoradas, y donde cada individuo pueda ejercer plenamente sus derechos y contribuir al desarrollo del país sin enfrentar discriminación o exclusión. (Banco Mundial, 2023)

A pesar de los importantes avances legislativos y de políticas públicas para fomentar la inclusión en Chile, la realidad sigue estando marcada por desigualdades estructurales que impiden que ciertos grupos vulnerables participen plenamente en la sociedad. La inclusión de personas con discapacidad, inmigrantes, pueblos indígenas, mujeres y la comunidad LGBTI+ se ve obstaculizada por factores como la discriminación, la falta de acceso a servicios de calidad, y la desigualdad económica. Estos problemas exigen no solo un fortalecimiento de las políticas públicas, sino también un cambio cultural que permita transformar las estructuras sociales que perpetúan estas exclusiones.

ENTORNOS Y BIENESTAR

El concepto de "entornos saludables", subraya la importancia crucial del entorno físico y social en el que vivimos para nuestro bienestar general. En Chile, donde la mayoría de la población reside en áreas urbanas, comprender las condiciones de estos entornos es esencial para diseñar soluciones que mejoren la calidad de vida de las personas.

El Atlas de Bienestar Humano Territorial (Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, 2022), nos muestra indicadores que afectan directamente el entorno cercano de las personas, como la calidad de la vivienda, el acceso a servicios públicos, la disponibilidad de espacios deportivos y de salud, y la presencia de áreas verdes. Al examinar estos aspectos, podremos identificar oportunidades de mejora y desarrollar estrategias para crear ciudades más saludables y equitativas para todos.

Indicadores de Bienestar Territorial								
	Indicador Bienestar Territorial	Indicador Infraestructura Básica	Indicador Infraestructura Vivienda	Indicador Servicios de Educación matrículas por niño	Indicador Servicios Públicos: Ser. Pub/1000 Habitantes	Indicador Equipamientos deportivos: M2 /habitante	Indicador Equipamientos de Salud: M2 /habitante	Indicador Áreas Verdes: M2 /habitante
Total nacional	0,54	0,73	4,83	0,82	0,19	0,59	0,39	4,55
Arica	0,56	0,74	4,71	0,48	0,29	0,54	0,39	3,05
Iquique	0,53	0,74	5,21	0,35	0,18	0,91	0,21	1,5
Antofagasta	0,64	0,7	4,96	0,71	0,3	0,6	0,31	1,37
Calama	0,48	0,66	4,68	0,83	0,19	0,62	0,27	2,54
Copiapó	0,33	0,8	4,57	0,66	0,41	0,88	0,34	4,52
La Serena	0,36	0,74	4,87	0,54	0,25	0,75	0,21	6,16
Santiago	0,32	0,71	5,03	1,04	0,11	0,52	0,42	3,83
Valparaíso	0,56	0,77	4,71	0,5	0,18	0,48	0,32	4,48
Quillota	0,37	0,77	4,7	0,5	0,44	1,5	0,21	3,11
San Antonio	0,48	0,74	4	0,6	0,35	0,76	0,18	4,95
Rancagua	0,47	0,74	4,92	0,58	0,29	0,65	0,68	5,21
Curicó	0,42	0,7	4,63	1,34	0,33	1,29	0,21	7,48
Talca	0,44	0,81	4,59	0,68	0,29	0,81	0,4	6,4
Chillán	0,46	0,9	4,62	0,49	0,27	0,64	0,38	3,12
Concepción	0,65	0,72	4,54	0,69	0,23	0,53	0,36	3,47
Los Ángeles	0,43	0,92	4,6	0,63	0,26	0,46	0,43	3,52
Temuco	0,52	0,8	4,45	0,46	0,27	0,48	0,35	17,85
Valdivia	0,46	0,82	4,12	0,61	0,42	0,66	0,49	19,2
Osorno	0,46	0,78	4,02	0,66	0,24	0,53	0,32	6,53
Puerto Montt	0,46	0,69	3,95	0,67	0,37	0,46	0,71	7,74
Coyhaique	0,51	0,69	3,97	0,42	1,11	1,04	0,51	1,96
Punta Arenas	0,49	0,77	4	0,76	0,47	1,48	0,67	6,51

Matriz de Bienestar Humano Territorial, Universidad Adolfo Ibáñez y Subsecretaría de Desarrollo Regional, 2021

La tabla revela importantes disparidades regionales en los indicadores de bienestar territorial en Chile. Ciudades del sur, como Punta Arenas y Coyhaique, destacan en casi todos los ámbitos, con buena infraestructura básica, alta disponibilidad de áreas verdes, equipamientos deportivos y de salud, y accesibilidad a servicios públicos. En contraste, regiones del norte, como Calama, Antofagasta y Copiapó, enfrentan desafíos notables, con bajos niveles de infraestructura básica, acceso limitado a servicios públicos y menores áreas verdes por habitante. Santiago de Chile, pese a su alta densidad, sobresale en acceso a educación y servicios públicos, aunque algunas áreas podrían mejorar. Estos contrastes resaltan la necesidad de un enfoque más equilibrado en la planificación territorial y en la distribución de recursos, especialmente en las zonas con indicadores bajos.

En términos de servicios básicos, el 90.6% de las viviendas en Chile tienen acceso privado a inodoros interiores con descarga de agua, cifra menor que el promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) de 97%.

La relación entre el entorno y el bienestar es bidireccional. Un entorno saludable promueve el bienestar de las personas, pero también las personas, a través de sus acciones y decisiones, pueden contribuir a la creación de entornos más saludables y sostenibles. La participación ciudadana, la promoción de estilos de vida saludables y el cuidado del medio ambiente son fundamentales para construir comunidades donde el bienestar sea una realidad para todos.

BORRADOR

PLANES COMUNALES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD 2025-2028

El problema central que aborda el programa corresponde al “déficit de acceso de la población a entornos saludables”, cuyas causas corresponden a espacios públicos insuficientes, déficit de acceso a la información, integración limitada de la promoción de la salud en las políticas comunales y las desigualdades socioeconómicas y territoriales.

Estas orientaciones buscan entregar directrices a los implementadores territoriales del programa, buscando reducir las brechas en el acceso a entornos saludables y el fortalecimiento de la participación social.

Se pondrá énfasis en continuar trabajando sobre los determinantes sociales y ambientales de la salud, reforzando la planificación intersectorial y local para lograr un mayor impacto en la calidad de vida de la población. De esta forma, buscaremos mejorar la eficacia de las intervenciones, focalizando las políticas existentes, y promoviendo la sostenibilidad de las acciones con el fin de facilitar el acceso equitativo a entornos que favorezcan la salud y el bienestar en todas las comunas del país.

El fin del Programa consiste en “Contribuir a aumentar el número de personas con factores protectores para la salud”. Entendiendo por factores protectores de la salud las características individuales, familiares o comunitarias que favorecen el mantenimiento o recuperación de la salud, o que pueden contrarrestar los efectos nocivos causados por factores de riesgo para la salud.

La intervención se centra en aumentar de los entornos (físicos, sociales e informativos) saludables, mejorando el acceso a alimentación saludable, el acceso a la práctica regular de actividad física y a acciones permanente de salud mental y cohesión social a través de intervenciones integrales locales.

Los entornos clave que deben ser abordados en las actividades que se realicen para promover la salud y mejorar la calidad de vida son, entre otros, escuelas, universidades, viviendas, lugares de trabajo, mercados y otros espacios comunes en territorios y comunidades urbanos y rurales. La intervención en esos entornos, considerando los aspectos diversos y multiculturales de las comunidades, permite llegar hasta los grupos poblacionales que viven en las condiciones más vulnerables. necesitándose un enfoque más sistemático para asegurar que se midan los efectos para la salud de las intervenciones orientadas al entorno y se garantice la continuidad (OPS/OMS, 2022).

Existen diferentes definiciones de entornos una de ellas identifica los entornos saludables como ambientes (hogar, ambiente laboral, espacios públicos, de recreación, etc.) en los cuales se propician los comportamientos, conductas y decisiones que promuevan la salud y calidad de vida de las personas, familias y comunidades (Frenk et al., 2021).

Para efectos prácticos, el programa definirá los entornos a intervenir como los sectores geográficos asociados al área de influencia de los establecimientos de la atención primaria de salud: Centros de Salud Público, Centros de Salud Familiar (CESFAM), Centros Comunitarios de Salud Familiar (CECOSF), Consultorio General Rural (CGR), Consultorio General Urbano (CGU), Hospitales (de baja complejidad), Postas de Salud Rural (PSR), entre otros.

Estos polígonos están claramente delimitados en el territorio en base al sistema de reglas establecido por el sistema de salud y permiten monitorear sus indicadores y resultados de salud poblacional. Esta

focalización, permite concentrar las acciones de la intervención en un determinado territorio y tiempo, así como también sus resultados.

Entornos saludables corresponderán a aquellos entornos que cuentan con al menos un activo comunitario de las dimensiones Alimentación Saludable, Actividad Física y Cohesión Social, idealmente, a no más de 800 metros de las viviendas del polígono.

El programa realizará una intervención en los entornos identificados en el territorio para que puedan ser considerados como entornos saludables, desde la perspectiva física, social e informativa y en las dimensiones de Alimentación Saludable, Actividad Física y Cohesión Social, contribuyendo al aumento de factores protectores de la salud y favoreciendo la adopción de hábitos saludables.

La estrategia, a través de los componentes “Políticas y regulaciones sobre entornos saludables”, “Habilitación y optimización de espacios públicos para la vida saludable”, “Participación comunitaria para el empoderamiento en salud” y “Comunicación social y Educación para la salud”, apunta al cierre de brechas identificadas en conjunto con la comunidad respecto a entornos saludables a través de un plan con acciones en el espacio local, con una visión global a nivel comunal y también local a nivel de los espacios geográficos priorizados.

Para este nuevo período, los Planes de Promoción de la Salud para Municipios, Comunas y Comunidades Saludables tendrán una expresión comunal y una regional a través del Plan Regional de Promoción de la Salud que busca contribuir a lograr el propósito de los Planes de Promoción de la Salud para Municipios, Comunas y Comunidades Saludables, a través de actividades que se programarán de acuerdo con cada realidad regional y a la disponibilidad presupuestaria de la Subsecretaría de Salud Pública.

Dimensiones	Componentes
• Alimentación Saludable • Actividad Física • Cohesión Social	1. Políticas y regulaciones sobre entornos saludables. 2. Habilitación y optimización de espacios públicos para la vida saludable. 3. Participación comunitaria para el empoderamiento en salud. 4. Comunicación social y Educación para la salud.

DIMENSIONES

ALIMENTACIÓN SALUDABLE:

Para el caso de la alimentación Saludable, el marco a considerar corresponde al otorgado por la Política Nacional de Alimentación y Nutrición del Ministerio de Salud (Ministerio de Salud, 2017). La que tiene como principios orientadores el derecho humano a la alimentación y la determinación social de la alimentación y nutrición.

En este documento se expresa que la alimentación es un fenómeno complejo, así como también los problemas de salud de la población que se asocian a ella, por ejemplo, la obesidad y otras enfermedades no transmisibles.

Existe consenso mundial de que la obesidad es un problema complejo y multifactorial, por lo que su abordaje requiere una visión integral que considere los determinantes sociales de la salud, sobre todo cuando se tiene foco en la población más vulnerable.

La evidencia científica demuestra que las intervenciones menos efectivas en la población de bajo nivel socioeconómico fueron las que se basaron principalmente en la entrega de información dirigida al cambio de comportamiento individual, por ejemplo, las de educación o campañas comunicacionales. En cambio, las intervenciones que demostraron ser efectivas incluyeron principalmente estrategias o políticas basadas en la comunidad, dirigidas a cambios estructurales en el medio ambiente.

Para ello, es fundamental implementar políticas públicas estructurales, integrales e intersectoriales, ya que un entorno obesogénico aumenta la probabilidad de obesidad en individuos y comunidades, sobre todo en aquellos entornos que tienen factores estructurales que limitan el acceso a alimentos saludables y sostenibles a precios accesibles, o la falta de condiciones seguras y adecuadas para la actividad física, o bien, la ausencia de normativas que desfavorezcan las prácticas de mala alimentación, entre otras condiciones estructurales.

En este contexto, la Estrategia para Detener la Aceleración del Sobrepeso y la Obesidad en la Niñez y Adolescencia (2023-2030) del Ministerio de Salud, que está alineada con las recomendaciones de la OMS, en el marco de la Política Nacional de Alimentación y Nutrición, establece diversas líneas estratégicas, en su mayoría estructurales, que contribuyen a mejorar los entornos alimentarios en nuestro país.

ACTIVIDAD FÍSICA:

La actividad física regular es un factor protector de la salud conocido para la prevención y el manejo de enfermedades no transmisibles (ENT) como las enfermedades cardiovasculares, la diabetes tipo 2 y los cánceres múltiples, todos los cuales son algunas de las principales causas de muerte a nivel mundial. La actividad física también tiene importantes beneficios para la salud mental, ya que reduce la depresión y la ansiedad y mejora el estado de ánimo y el bienestar general. La actividad física regular es beneficiosa para personas de todas las edades y capacidades y durante todo el curso de vida.

En las directrices de la OMS del 2020 sobre Actividad Física y hábitos sedentarios en niños y adolescentes, adultos y adultos mayores se recomienda que los niños y adolescentes realicen al menos 60 minutos diarios de AF de moderada a intensa a lo largo de la semana y que los adultos realicen al menos entre 150 y 300 minutos de AF aeróbica de intensidad moderada; o bien un mínimo de entre 75 y 150 minutos de actividad física aeróbica de intensidad vigorosa; o bien una combinación equivalente de actividades de intensidad moderada y vigorosa a lo largo de la semana. A su vez se da énfasis a la reducción de la conducta sedentaria referida al tiempo de pantalla y actividades sedentes.

La inactividad física se define como el no cumplimiento de las recomendaciones mínimas internacionales de AF para la salud de la población y, el sedentarismo se define por la carencia de movimiento durante las horas de vigilia a lo largo del día, y es caracterizada por actividades que sobrepasan levemente el gasto energético basal. La práctica de AF y deportiva en edades tempranas puede producir un cambio cultural en los estilos de vida a lo largo del curso de vida. Estudios señalan que la participación en AF en la niñez aumenta la probabilidad de seguir participando en tales actividades al ser adultos. Los países y las comunidades deben adoptar medidas que permitan a las personas incrementar la AF, para lo cual se requiere un esfuerzo colectivo, en diferentes sectores y disciplinas para aplicar políticas adecuadas al entorno cultural y social de los países.

En Chile, según la última Encuesta de Hábitos de Actividad Física 2018 del Ministerio del Deporte, en población mayor de 17 años, el 80% de esta es inactiva, no cumpliendo los estándares mínimos recomendados por la OMS. El estudio visibiliza además importantes brechas de participación y de acceso. En el análisis desagregado por estrato social, al descender en la escala socioeconómica disminuye el nivel de práctica de actividad física y/o deportes, donde el segmento ABC1 presenta 48,1% de practicantes, mientras que el segmento E solo alcanza el 17,5%. En la misma encuesta bajo un análisis de género podemos observar el nivel de práctica de los hombres es sostenidamente mayor que en las mujeres, alcanzando un 45,3% frente solo a un 25,3% las mujeres, expresándose una brecha de 20 puntos porcentuales, aun cuando las mujeres son las que expresan mayor interés por su práctica.

Por otra parte, la Tercera Encuesta Nacional de Salud (ENS, 2016-2017) devela altas tasas de sedentarismo como condición extendida en la sociedad (86,7%) evidenciando una brecha mayor en mujeres, a mayor edad y a menor escolaridad. Los factores asociados son el sexo femenino; vivir en zonas urbanas; alto ingreso económico; fumar o ser exfumador; obesidad central, Diabetes Mellitus tipo 2 o síndrome metabólico; mala autopercepción de salud y, poseer aparatos tecnológicos o vehículos de uso particular.

En el caso de población menor de 17 años y en base a la Encuesta Nacional de Hábitos de Actividad Física y Deportes, en población entre 5 y 17 años 2019, solo un 16,5% de la población en edad escolar cumplen con las recomendaciones de actividad física de la OMS, que indica 60 minutos diarios, un 35,1% es parcialmente activo y un 48,4 inactivos. Según la Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes (en adelante NNA) de 5 a 17 años, señala que 59,5 % de los NNA realizaron deporte o

actividad física en la semana anterior a la encuesta. Asimismo, en el Reporte Global de Notas en Niñas, niños y adolescentes, Chile apenas obtiene nota 3,0 de un máximo de 7,0, por debajo del promedio internacional (4,0). Peor aún, la calificación ubica a Chile en la penúltima posición de los 49 países evaluados. El reporte evidencia que sólo 1 de cada 5 niños y niñas de 9 a 11 años es físicamente activo y del total de menores, sólo entre el 14% y 26% se reporta participar en una actividad deportiva. Además, son pocos los niños y adolescentes que se transportan de manera activa (bicicleta, caminando, en patineta u otros).

COHESIÓN SOCIAL:

Participación

De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Bienestar Social - EBS (Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 2023), los datos muestran que en Chile existe una combinación de baja confianza interpersonal e institucional, grupos con escasas redes de apoyo, diagnóstico global que revela carencias en el vínculo social.

Por otro lado, el Informe final Consejo Asesor para la Cohesión Social 2020 del Ministerio de Desarrollo Social (Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 2020), con relación a la pertenencia, el 85% siente orgullo por la nacionalidad chilena y la mayoría de las personas se siente identificada con Chile. Orgullo e identificación nacional constituyen pilares positivos de la cohesión social en Chile.

Dentro los nudos problemáticos de la cohesión social encontramos algunos vínculos sociales fundamentales para la cohesión social se han debilitado: las personas tienen menos amigos, cuentan con menos apoyo en caso de necesidad y un tercio de la población tiene una sola persona (o nadie) con quien hablar temas importantes. (*Informe final Consejo Asesor para la Cohesión Social, 2020*)

En Chile, en promedio las personas tienen tres amistades cercanas, cifra que aumenta con el nivel de ingresos. En contraste, dos de cada diez personas declaran no tener ningún amigo o amiga cercano, llegando a tres de cada diez en las personas que viven en pobreza y en los adultos de 60 años o más, presentándose en estos grupos una precariedad respecto al tamaño de su red.

Se observa una clara segregación socioeconómica en la configuración de las redes de apoyo. Los individuos de mayor nivel socioeconómico, quienes generalmente poseen un mayor nivel educativo, tienden a establecer vínculos de amistad con personas de características similares. Esta homogeneidad en sus círculos sociales se traduce en redes de apoyo más sólidas, que les facilitan el acceso a recursos y asistencia en diversas áreas, como el cuidado familiar, la asesoría legal, la obtención de recursos financieros o la inserción laboral.

En contraste, las personas con menores ingresos presentan redes de apoyo más limitadas, tanto en cantidad como en alcance. Esta carencia restringe su acceso a apoyos cruciales en momentos de necesidad, perpetuando así las desigualdades sociales.

La fragilidad observada en los vínculos interpersonales se extiende al ámbito de la cohesión social, afectando tanto al sentido de pertenencia, manifestado a través de la confianza en las instituciones, como a la orientación hacia el bien común, que se expresa mediante la participación social. En este sentido, se evidencia una contradicción: a pesar de un alto y generalizado nivel de desconfianza en las instituciones, se constata simultáneamente una disminución en la participación en organizaciones sociales y políticas. Esta tendencia, que refleja un debilitamiento del tejido social, se viene registrando desde hace ya dos décadas.

Los niveles de confianza institucional en Chile han sido deficitarios desde mediados de la década de 1990, experimentando una caída aún más pronunciada en los últimos años. Instituciones fundamentales para el orden político, como el gobierno, los partidos políticos y el Congreso, registraron niveles de confianza inferiores al 5% en 2019. Este descontento con la clase política se refleja también en una escasa valoración de la participación ciudadana: solo un tercio de la población considera relevante para la democracia ser un miembro activo en organizaciones sociales. Si bien se ha observado un aumento en las movilizaciones sociales, la participación en organizaciones sociales se mantiene en un modesto 36%.

En este contexto de debilitamiento del tejido social y desconfianza institucional, un 26,5% de la población manifiesta insatisfacción con su vida social. Esta insatisfacción es más pronunciada en mujeres, personas con discapacidad e inmigrantes, sin observarse una correlación clara con el nivel de ingresos. Asimismo, se evidencia una mayor frecuencia de insatisfacción entre quienes han experimentado situaciones de maltrato. (Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 2020)

Si bien la EBS evidencia carencia, revela también espacios de oportunidad para la integración social, al mostrar una alta demanda ciudadana por mayor participación en el diseño de políticas públicas. *(Principales resultados de la Primera Medición del Bienestar Social en Chile, 2021).*

Los datos presentados revelan una paradoja en la cohesión social chilena. A pesar de un arraigado sentido de identidad nacional, existe una preocupante fragilidad en los vínculos interpersonales e institucionales. Las redes de apoyo son limitadas y desiguales, exacerbadas por la segregación socioeconómica. La desconfianza en las instituciones y la baja participación social agravan aún más este escenario, generando una sensación de aislamiento y descontento en una parte significativa de la población.

Esta fragilidad en el tejido social tiene implicaciones directas en la salud y el bienestar de las personas. La falta de apoyo social, la desconfianza y la exclusión pueden aumentar el riesgo de problemas de salud mental y salud física.

La promoción de la salud en Chile debe abordar de manera integral estos desafíos, fortaleciendo los vínculos sociales, promoviendo la confianza y la participación, y reduciendo las desigualdades. Entre las líneas de trabajo que se pueden considerar para avanzar en estos desafíos es el fortalecimiento

de las redes comunitarias fomentando la creación y el refuerzo de espacios de encuentro y apoyo mutuo, como centros comunitarios, grupos de apoyo y programas de voluntariado; promoción de la participación ciudadana facilitando la participación de la comunidad en la toma de decisiones y el diseño de políticas públicas, especialmente en aquellas relacionadas con la salud y el bienestar.

Salud Mental

Salud mental es más que la mera ausencia de trastornos mentales. La dimensión positiva de la salud mental ha sido subrayada en la definición de salud de la OMS, tal cual consta en la constitución de ésta: “La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades” (OMS, 2004).

Los conceptos de salud mental incluyen bienestar subjetivo, autonomía, competencia, dependencia intergeneracional y reconocimiento de la habilidad de realizarse intelectual y emocionalmente. También ha sido definido como un “estado de bienestar por medio del cual los individuos reconocen sus habilidades, son capaces de hacer frente al estrés normal de la vida, trabajar de forma productiva y fructífera, y contribuir a sus comunidades”. Salud mental se refiere a la posibilidad de acrecentar la competencia de los individuos y comunidades y permitirles alcanzar sus propios objetivos.

En el Plan de Acción sobre Salud Mental 2013-2030 la OMS señala que los países no solo deben atender las necesidades de las personas aquejadas por algún trastorno mental, sino también proteger y fomentar el bienestar mental de todos los ciudadanos. La salud mental evoluciona a lo largo de toda la vida. Por consiguiente, a los gobiernos incumbe la función de utilizar los datos sobre factores de protección y de riesgo para promover y proteger la salud mental en todas las etapas de la vida (OMS, 2022).

En la literatura se puede constatar que el concepto de buena salud mental y la promoción de la salud mental suelen utilizarse indistintamente. Con el propósito de realizar una diferenciación de estos conceptos, se propone utilizar el término “buena salud mental” para definir dominios o metas positivas que componen la salud mental (Fusar-Poli, y otros, 2020).

Dominios o Metas Positivas que componen la Salud Mental

Dominio o meta positiva	Descripción
Alfabetización en salud mental	Capacidad de reconocer y tener conocimiento sobre problemas de salud mental, factores y señales de alerta, así como sobre los diferentes servicios de salud mental a los que se puede acceder en caso de necesidad.
Actitudes hacia los problemas de salud mental	Forma en que reaccionamos frente a una persona con un trastorno mental. Las actitudes positivas incluyen la comprensión, la compasión y la empatía, al tiempo que se disminuye la discriminación y la distancia social hacia las personas con problemas de salud mental.
Autopercepción y valores	Conjunto de creencias, valores y emociones subjetivas sobre las propias características internas y externas, que moldean el estilo atribucional, la autocompasión y la autoestima, e inciden en la conciencia y la aceptación que conducen a vivir una vida valiosa.
Habilidades cognitivas	Capacidad de prestar atención, recordar y organizar la información, teniendo al mismo tiempo un grado de flexibilidad cognitiva, atención para permitir la toma de decisiones y resolver problemas.
Desempeño académico/ ocupacional	Aprendizaje y conocimientos objetivos, logros en el estudio, asistencia y comportamiento, así como adaptación escolar y académica.
Emociones	Estados afectivos con propiedades motivacionales que llevan a las personas a una determinada respuesta o comportamiento.
Comportamiento	Conductas son las que sigue una persona cuando se le presenta un estímulo.
Estrategias de autogestión	Habilidades prácticas y cotidianas necesarias para cuidar de uno mismo de forma eficaz e independiente y para funcionar y satisfacer las demandas del entorno: habilidades de afrontamiento para manejar el estrés, resolución de problemas y toma de decisiones para enfrentar las adversidades que puedan aparecer.
Habilidades sociales	Capacidades que permiten a los jóvenes interactuar y comunicarse entre sí para fomentar relaciones positivas.
Relaciones familiares y significativas	Capacidad de establecer relaciones significativas con otros miembros de la familia; relaciones saludables y positivas y conexión con los miembros de la familia dentro de un entorno con límites que faciliten la comunicación y la interacción positivas.
Salud física	Variables físicas, síntomas visibles y medidas relacionadas con un estado físico positivo y dimensiones de la salud.
Salud sexual	Un estado de bienestar físico, emocional, mental y social en relación con la sexualidad.
Sentido de vida	Sentir que la vida tiene un propósito y un significado.
Calidad de vida	El bienestar general de una persona, definido en términos de salud, felicidad y satisfacción de vida.

La Promoción de la Salud Mental se ha definido de diversas maneras; típicamente como el proceso orientado a mejorar las capacidades de las personas y las sociedades para hacerse cargo de su salud, mejorar resiliencia psicológica, creando entornos de apoyo mediante la colaboración y la participación intersectorial.

Promoción de la buena salud mental se podría definir entonces como “la mejora de la capacidad de individuos, familias, grupos o comunidades para fortalecer o apoyar experiencias emocionales, cognitivas y relaciones positivas”. Esta se desarrolla en los contextos domiciliario, escolar, laboral, comunitario y virtual (Sharma, Sharma, & Sharma, 2017).

Diversos estudios proponen utilizar estrategias basadas en el estilo de vida para la prevención, el control y el tratamiento de las afecciones de salud mental. Específicamente se proponen estrategias orientadas a fomentar la nutrición adecuada, actividad física, exposición a la naturaleza, descanso adecuado, activación de procesos de pensamiento positivos y participación en actividades de servicio o conducta prosocial (Morton, 2018).

En el Plan Nacional de Salud Mental 2017-2025 el Ministerio de Salud define la Salud Mental como “La capacidad de las personas para interactuar entre sí y con el medio ambiente, de modo de promover el bienestar subjetivo, el desarrollo y uso óptimo de sus potencialidades psicológicas, cognitivas, afectivas y relacionales, el logro de sus metas individuales y colectivas, en concordancia con la justicia y el bien común” (Salud, 2017).

De la misma forma que la salud en general, los entornos sociales, económicos y físicos moldean la experiencia de salud mental de las personas, constituyendo factores de riesgo que están ligados a desigualdades sociales. Por esta razón, aumentar la salud mental y el bienestar de las personas implica influir en determinantes sociales y económicos, como el nivel de ingresos, la situación laboral, el nivel educativo, las condiciones materiales de vida, el estado de salud física, la cohesión familiar, la discriminación, las violaciones de derechos humanos o la exposición a episodios vitales difíciles como la violencia de género o el maltrato y abandono infantil (Allen, Balfour, Bell, & Marmot, 2014).

El concepto de cohesión social hace referencia a “la eficacia de los mecanismos instituidos de inclusión social como a los comportamientos y valoraciones de los sujetos que forman parte de la sociedad. (...) entre otros, el empleo, los sistemas educacionales, la titularidad de derechos y las políticas de fomento de la equidad, el bienestar y la protección social. Los comportamientos y valoraciones de los sujetos abarcan ámbitos tan diversos como la confianza en las instituciones, el capital social, el sentido de pertenencia y solidaridad, la aceptación de normas de convivencia, y la disposición a participar en espacios de deliberación y en proyectos colectivos.” (Cepal, 2007)

De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Bienestar Social 2023, los datos muestran que en Chile existe una combinación de baja confianza interpersonal e institucional, grupos con escasas redes de apoyo, y un diagnóstico global que revela carencias en el vínculo social.

Los vínculos sociales fundamentales para la cohesión social se han debilitado, como disponibilidad de amistades cercanas, contar con apoyo de otras personas en caso de necesidad y disponer de alguien con quien hablar temas importantes. Además, los resultados indican que, a mayores ingresos, disminuye la desconfianza interpersonal la que su vez ha ido en aumento entre 2021 y 2023, siendo menor para el cuarto y quinto quintil de ingresos (Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 2023).

Dentro de los resultados de la Primera Medición del Bienestar Social en Chile 2021 (Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 2021), realizada por el PNUD en promedio las personas tienen tres amistades cercanas, cifra que aumenta con el nivel de ingresos. En contraste, dos de cada diez personas declaran no tener ningún amigo o amiga cercano, llegando a tres de cada diez en las personas que viven en pobreza y en los adultos de 60 años o más, presentándose en estos grupos una precariedad respecto al tamaño de su red.

En ambas mediciones se observa una segregación socioeconómica en la configuración de las redes de apoyo, donde las personas con menores ingresos son quienes presentan redes de apoyo más limitadas, tanto en cantidad como en alcance.

La fragilidad observada en los vínculos interpersonales se extiende al ámbito de la cohesión social, afectando tanto al sentido de pertenencia, manifestado a través de la confianza en las instituciones, como a la orientación hacia el bien común, que se expresa mediante la participación social. Esta fragilidad en el tejido social tiene implicaciones directas en la salud y el bienestar de las personas. La falta de apoyo social, la desconfianza y la exclusión pueden aumentar el riesgo de problemas de salud mental y salud física.

Diversos estudios señalan que las sociedades con mayor cohesión social evidencian ser más saludables y su índice de mortalidad es más bajo (Chuang, Chuang, & Yang, 2013). Otros estudios describen que en barrios con baja cohesión social se generan modos de vida menos saludables, con menor uso del espacio comunitario para la práctica de actividad física (Schiefer & Noll, 2017).

Las estrategias más efectivas para reforzar la cohesión social son aquellas orientadas a generar conciencia y contrarrestar los estereotipos existentes y las que ofrecen oportunidades para un contacto positivo y una evaluación más cooperativa de las relaciones intergrupales, tales como las siguientes (Echeverría, 2008):

- Facilitar la constitución y participación en asociaciones y trabajos comunitarios.
- Ofrecer programas educativos que brinden a los estudiantes la oportunidad de participar en trabajos comunitarios y de ser miembros de asociaciones.
- Generar participación ciudadana en la implementación de políticas y bienes públicos.
- Facilitar las oportunidades de participación política de los ciudadanos y mejorar la recepción institucional a las iniciativas de abajo hacia arriba.
- Cumplir con una estrategia de crecimiento inclusivo.
- Mejorar la integración de los inmigrantes en la sociedad.
- Mejorar la tolerancia recíproca entre los diferentes grupos étnicos y sociales.
- Entablar un diálogo público con los medios de comunicación, en sentido amplio, para descartar la difusión de las llamadas “noticias falsas”.
- Identificar áreas sensibles para la confianza en los gobiernos e implementar políticas para mejorar el consenso.

En el marco de la Línea Estratégica 1° de Educación, Promoción y Prevención del Plan de Acción en Salud Mental 2019-2025 (Ministerio de Salud, 2021), incluye acciones que apoyan a las personas, familias, comunidades, para adoptar estilos de vida saludables y generar ambientes favorecedores de la salud mental, así como la implementación de acciones para prevenir la aparición de problemas de salud mental, detección temprana y abordaje de factores y/o poblaciones de riesgo. Incluye acciones asociadas a promoción de los derechos humanos y reducción del estigma de las personas con problemas o enfermedades de salud mental.

En este Plan de Acción se describen como actividades de promoción de salud mental, aquellas orientadas al desarrollo de habilidades parentales, trabajo intersectorial para el desarrollo emocional y social de estudiantes en establecimientos educacionales, y fomento de la participación comunitaria.

Todas estas acciones potencian las variables que mejoran el bienestar social y comunitario, tales como la habilidad para disfrutar de la vida, la capacidad de enfrentar los desafíos de la vida, el bienestar emocional y espiritual; las relaciones sociales y el respeto por la cultura, la equidad, la justicia social y la dignidad personal.

Así también incluiremos en este ámbito las Prácticas de Bienestar de la Salud (PBS) reconocidas en la Política en la Medicina Complementaria y sus prácticas de Bienestar de la Salud (Ministerio de Salud, 2024).

La Política incluye prácticas que conceptualizan la salud desde un enfoque salutogénico que busca el mantenimiento del equilibrio y la integridad de las personas, activando recursos o activos que cultivan la salud de personas, familias y comunidades. Se relevan enfoques holísticos, y sinérgicos, desde paradigmas en salud que integran las dimensiones biológicas, psicológicas, sociales, culturales y espirituales (biopsicosocio-espiritual).

De las Prácticas de Bienestar de la Salud (PBS) que contribuyen a la promoción de la salud mental, y bienestar y que se pueden programar en los planes comunales de promoción de la salud, son todas aquellas orientadas a la actividad física, alimentación saludable; vínculos sociales, resiliencia, pensamientos y emociones positivas y autonomía, las que pueden aportar al bienestar, de quienes anhelan una calidad de vida satisfactoria, una adultez mayor plena y un envejecimiento positivo.

COMPONENTES

1.- COMPONENTE POLÍTICAS Y REGULACIONES SOBRE ENTORNOS SALUDABLES

Los gobiernos locales desempeñan un papel clave en la promoción de la salud por su capacidad para actuar en los entornos, trabajar intersectorialmente, integrar la participación comunitaria, y adaptar las intervenciones a las necesidades y contextos específicos de la población (criterios regionales MCCA OPS-OMS)

De acuerdo con los criterios regionales para Municipios, Comunas y Comunidades Saludables de la OPS-OMS, alcaldes, alcaldesas, comunidades, concejos municipales y otros actores locales tienen un papel clave como impulsores de políticas públicas saludables. Se señala que se debe tener en cuenta que estas políticas trascienden la competencia exclusiva del sector de la salud: otros sectores como educación, transporte urbanismo, vivienda, desarrollo social, trabajo, finanzas u otros llevan a cabo políticas que pueden tener un impacto significativo en la salud, el bienestar y la equidad (OPS/OMS, 2024).

Los gobiernos locales deben desempeñar un papel fundamental en promover la salud y aumentar el desarrollo social; descentralizar los recursos y la toma de decisiones al nivel local puede mejorar la efectividad y el impacto de la acción local. Esto debe incluir el fomento de la participación social y la aplicación de enfoques intersectoriales en todos los niveles de gobierno para reducir las desigualdades e inequidades en la salud, centrándose en los que se han quedado atrás en entornos urbanos y rurales. Entre los temas clave que deben abordarse se encuentran que los gobiernos proporcionen opciones de movilidad saludables para que las personas se desplacen dentro de estos entornos y entre ellos, y que fortalezcan las acciones sobre salud ambiental (OPS/OMS, 2022).

En este marco, el componente de Políticas y Regulaciones locales saludables busca fortalecer la gobernanza y el trabajo intersectorial para mejorar la salud y el bienestar, y abordar los determinantes sociales de la salud.

A nivel comunal se enfoca en potenciar la elaboración, implementación y seguimiento de políticas y regulaciones municipales que mandaten el mejoramiento de entornos a nivel municipal. Estos pueden corresponder a decretos alcaldícos, ordenanzas, reglamentos, planes municipales, convenios interinstitucionales o con privados, entre otros.

A nivel regional, se centra en generar los espacios que promuevan Salud en Todas las Políticas, coordinando con las autoridades de salud locales y regionales, así como con los sectores público y privado respuestas de política integrales incluyendo consideraciones relativas a la salud en todos los sectores y ámbitos de política, siempre teniendo en cuenta y abordando los posibles conflictos de intereses al colaborar con asociados. (estrategia regional de promoción de la salud 2023 OPS_OMS). En este sentido, las actividades que se programan desde a SEREMI de Salud son:

- Formación para la abogacía en Salud en Todas Las Políticas para tomadores de decisión regional y municipal.
- Abogacía y Asesoría en terreno de Promoción de la Salud, calidad de vida y políticas públicas saludables, a nivel regional y municipal.

Comentado [CC1]: Estas son las actividades regionales del componente 1

2.- COMPONENTE HABILITACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA VIDA SALUDABLE

Los entornos naturales y construidos saludables son vitales para “garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades”, que es la finalidad del Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 (ODS 3) de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

El carácter y la calidad del entorno construido, como la existencia y el tamaño de las áreas verdes y los parques, la calidad del aire y del agua, la combinación de usos del suelo, la combinación de modos de tránsito y la densidad del tránsito, son cruciales para garantizar la salud individual y comunitaria. De este modelo, las estrategias de planificación para gestionar y controlar estas características ambientales que afectan directa o indirectamente a la salud y el bienestar son una actividad básica de salud pública ambiental (OPS, 2021).

El objetivo de este componente es habilitar y/u optimizar espacios públicos, infraestructura y equipamiento, con involucramiento directo de las personas que son parte de aquellos entornos. Incluye actividades como: implementación de máquinas de ejercicios en plazas, ciclovías, skatepark, bebederos, techumbres, kioscos escolares, huertos urbanos, habilitación de espacios para ferias libres, entre otros. El involucramiento de las personas puede, en principio, tomar diversas formas, dependiendo de la realidad local.

3.- COMPONENTE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA PARA EL EMPODERAMIENTO EN SALUD

Para OPS-OMS, el fortalecimiento de la participación comunitaria es un proceso en el cual los miembros de la comunidad se reúnen, planifican estratégicamente, definen prioridades, reparten tareas y establecen objetivos y estrategias en función de las necesidades y los recursos existentes (financieros, técnicos y humanos) y los recursos que podrían obtenerse por medio de alianzas.

Por un lado, este componente busca contribuir a facilitar oportunidades que aseguren la participación de la comunidad en la toma de decisiones que afectan la vida de sus miembros, aprovechando los activos y las capacidades de la comunidad, lo cual se ve expresado en mecanismos de participación como identificación de activos comunitarios en salud, Escuelas de líderes y diálogos ciudadanos, en los cuales se entrega información completa, precisa y apropiada, buscando de esta forma el fortalecimiento de las capacidades de la comunidad para abogar por sus necesidades y perspectivas (OPS/OMS, 2022).

Dichos mecanismos tienen el objetivo de generar alianzas, identificar recursos comunitarios, estrategias para movilizar a la comunidad, construir alianzas intersectoriales, recoger y compartir información, priorizar, identificar fortalezas y debilidades, y también para intencionar el desarrollo de políticas públicas locales orientadas a mejorar entornos para la Actividad Física y Alimentación Saludable. Algunos de éstos son: escuelas de gestores territoriales en salud, diálogos ciudadanos comunales, cabildos, asambleas territoriales, entre otros.

Por otro lado, busca impulsar la formación y articulación de redes locales para incidir en los cambios de costumbres, culturales y sociales asociadas a la alimentación, actividad física, salud mental, cohesión social que se requieren en las comunidades, involucrando a las personas con su entorno de

vida y asociatividad, lo cual contribuye al desarrollo de factores protectores psicosociales, debido a que un vínculo saludable al interior de la comunidad fortalece la confianza en los otros, la reciprocidad, el liderazgo comunitario y, en definitiva, fortalece el tejido social comunitario que permite a los individuos proteger su salud mental facilitar la participación y el empoderamiento de la comunidad, y el compromiso de la sociedad civil.

Respecto de la salud mental, en el informe de diálogos de salud mental 2024 realizado por la subsecretaría de Salud Pública durante el año 2023, en las opiniones ciudadanas al respecto destacan las categorías de "promoción y participación social" y "redes de apoyo familiar y comunitario" las cuales enfatizan la importancia de intervenciones poblacionales, intersectoriales y basadas en el fortalecimiento del tejido social como componentes esenciales de una política integral de salud mental. Dando cuenta de la importancia de las redes de apoyo familiar y comunitarias, reconociendo que el bienestar y la recuperación en salud mental están intrínsecamente ligados a las relaciones de cuidado mutuo y el sentido de pertenencia. Esto subraya la necesidad de políticas que fortalezcan estos vínculos comunitarios como parte esencial de la atención integral en salud mental fundamentando su inclusión en esta intervención.

4.- COMPONENTE COMUNICACIÓN SOCIAL Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD

COMUNICACIÓN SOCIAL (4A)

Su objetivo principal es garantizar que la población esté informada sobre las conductas de riesgo que afectan su salud y la de los demás, promoviendo la toma de decisiones informadas para prevenir enfermedades y mitigar sus efectos. También busca aumentar la percepción del riesgo, tanto real como percibido, asociado a las enfermedades no transmisibles (ENT) y las conductas no saludables que las favorecen, fortaleciendo el conocimiento necesario para que las personas adopten estilos de vida más saludables. En este contexto, la comunicación social en salud desempeña un papel clave en la creación de entornos que favorecen el bienestar, garantizando su accesibilidad, mediante un enfoque participativo y fomentando el diálogo entre comunidades, autoridades locales y otros actores claves.

A nivel regional, desde la SEREMI de Salud se programan acciones para un Plan de medios regional.

EDUCACIÓN PARA LA SALUD (4B)

Lograr la autoeficacia de las personas para llevar una vida más saludable aumentando sus conocimientos. Entregando información que motive y eduque a la población para desarrollar competencias que les facilite llevar una vida más sana.

La Educación para la salud es una estrategia, también una herramienta, pero por sobre todo una disciplina de la salud, es la suma de contenidos organizados y metodologías, que permite a los individuos tomar las mejores decisiones sobre su bienestar, reconociendo la experiencia de los individuos, sus condiciones de vida, su entorno social y cultural y su historia personal.

La Educación en Salud requiere de un equipo profesional capacitado que aborde los contenidos en forma individual o grupal, pero siempre teniendo presente el uso de un lenguaje adecuado a las características étnicas, sociales y culturales, además, desprendiéndose de la asimetría del conocimiento, que por lo general establece barreras para el logro del propósito de lograr conocimiento, así mismo, las técnicas metodológicas incorporan el canto, el teatro, títeres, juego de roles, así como, elementos que están en el entorno como la arcilla, la vegetación, etc.

En este sentido, por ejemplo, se realizan acciones educativas sobre cómo utilizar la infraestructura disponible en el entorno, no solo para la actividad física y alimentación saludable, sino, además, para el bienestar, la salud mental y la cohesión social

Para las sesiones educativas planificadas por el nivel comunal, la SEREMI podrá recomendar utilizar los siguientes materiales:

Documento	Disponible en:
Guía para la Familia, del Programa de Alimentación Saludable y Actividad Física para Familias	https://dipol.minsal.cl/recursos-educativos/ .
Manual Métodos y medios en promoción y educación en salud elaborado por la <i>Fundació de la Univesitat de Catalunya</i>	https://reader.digitalbooks.pro/book/preview/29280/00004.html?1738945664630

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN

La estrategia de intervención se mantiene centrada en el liderazgo de los gobiernos locales para lograr mejores resultados en salud y calidad de vida, lo que requiere de la concertación de voluntades políticas, técnicas y financieras, centrales, regionales y locales. A través de la Estrategia Municipios, Comunas y Comunidades Saludables (MCCS) se propicia alcanzar el reconocimiento formal de la promoción de la salud en los Municipios, en base a la alianza salud y desarrollo local en donde los gobiernos comunales, junto a la comunidad, se empoderen con el fin de generar políticas públicas saludables para la población apuntando a lograr la construcción de entornos saludables donde las personas viven, trabajan, crean redes, establecen vínculos con otras personas y con el medio ambiente (Ministerio de Salud, 2017).

El enfoque territorial es crucial para incidir para mejorar las dimensiones del programa en los entornos. Es por esto que los esfuerzos se dirigen a que las comunas integren los componentes en sus planes comunales, los que son realizados en el sustento de la participación ciudadana, permitiendo así llegar a la mayor cantidad posible de habitantes, y hacer de la promoción un proceso inclusivo, participativo y democrático.

La integración de los resultados esperados de los componentes se da a partir de la elaboración de una planificación anual, la cual debe diseñar intervenciones en los componentes en cada uno de los sectores correspondientes a los diferentes espacios o entornos a intervenir (en base a criterios de población y geográficos). Se trata de proyectar una ruta de trabajo, compuesta no sólo de una sumatoria de actividades, sino que, de intervenciones basadas en evidencia que respaldan su efectividad. Así, los componentes del Programa están pensados para intervenir / interactuar en los diferentes niveles: personal, interpersonal/familiar, comunitario, organizacional, estructural/social.

De acuerdo con las necesidades expresadas por la comunidad que pertenece a un entorno físico identificado como prioritario se generan intervenciones integrales en espacios para que las personas accedan a través de actividades.

Para aumentar el acceso a entornos saludables debe existir a la base disponibilidad física de ellos. En este sentido, las necesidades de disponibilidad de entornos saludables se abordan desde el componente 2 de habilitación y optimización de espacios en que se realizan actividades en el espacio físico como la instalación de máquinas de ejercicio, o mejoras a una plaza como la instalación de techumbres que motiven el uso de ese espacio, un punto de venta de alimentos naturales y frescos, una sala o centro de promoción de la salud, entre otros.

Pero no es suficiente la existencia de un espacio físico mejorado o habilitado para que exista disponibilidad, se requiere que dichos espacios contengan una oferta programática que dé vida a aquellos espacios, lo cual se realiza a través del mismo componente 2 con actividades como programas permanentes de actividad física.

Por otro lado, para que las personas accedan a los entornos físicos saludables disponibles se requiere que estén informadas y hayan desarrollado habilidades y destrezas que apoyen cambios de conducta y cuidado de los entornos, lo cual se aborda a través del componente 4 con estrategias

comunicacionales locales que difundan la oferta en promoción de la salud y entreguen mensajes de salud positivos. Se ha demostrado la asociación positiva entre medios de información local y acciones deportivas/recreativas en su capacidad de influir en comportamientos beneficiosos para la salud como la alimentación saludable y actividad física como en términos de beneficios en capital social y apoyo social del barrio (Santana et al., 2009).

Estas intervenciones integrales deben considerar acciones en el entorno social dónde viven las personas, ya que es imprescindible actuar en factores psicosociales como las redes sociales y de apoyo y en factores sociales que, como se ha mencionado anteriormente pueden desencadenar la exposición a riesgos que tienen un impacto directo sobre la salud y calidad de vida de las personas.

En este marco, las actividades del componente 3 de Participación Comunitaria buscan impulsar la formación y articulación de redes locales para incidir en los cambios de costumbres, culturales y sociales asociados a factores protectores de la salud que se requieren en las comunidades.

El ciclo completo de ejecución de la estrategia, que tal como se ha señalado anteriormente es una acción permanente sobre los entornos físico, informativo y social (componentes 2, 3 y 4) es completado y complementado con el componente 1 de Regulaciones y Políticas municipales para la vida saludable, el cual busca potenciar la elaboración, implementación y seguimiento de regulaciones y políticas locales (ordenanzas, decretos, planes comunales) que buscan mejorar los entornos señalados que promuevan la salud, por ejemplo decretos alcaldicios que establecen planes de utilización de los entornos, entre otros.

Finalmente, cómo indica el modelo socio ecológico, las intervenciones más costo efectivas son aquellas que consideran diversas estrategias y son internivel, esto quiere decir que abordan los niveles individual, interpersonal, comunitario, organizacional y social.

Así, con la inclusión de cada uno de los componentes mencionados, el plan de promoción de la salud se constituye en el instrumento de gestión de la estrategia MCCS, y busca implementar, entre otras medidas, la generación de políticas locales que promuevan la creación de entornos saludables para incentivar la práctica de actividad física y la alimentación saludable. Para este efecto el Ministerio de Salud, formula, monitorea y evalúa el programa, y entre la Seremi y la Municipalidad se establecen los compromisos relacionados con los objetivos establecidos en la estrategia Municipios, Comunas y Comunidades Saludables del Programa de Promoción de la Salud.

La planificación de los planes favorece la eficiencia en el uso de los recursos, contribuye a la continuidad de las intervenciones a nivel local, por lo tanto otorga mayor sostenibilidad a los procesos, reconoce las capacidades de planificación en el territorio con intervenciones estructurales que consideren la creación de entornos que promuevan la salud abordando las determinantes sociales que se manifiestan en los territorios, ayuda a lograr articulación y sintonía con los instrumentos de planificación comunal, y permite realizar evaluaciones de resultado y proceso en la comuna.

El siguiente esquema muestra gráficamente la estrategia del programa denominada “Municipios, comunas y comunidades saludables – MCCS” la cual se sustenta en el marco teórico principal de la

Promoción de la Salud y se operacionaliza a través del programa Planes de Promoción de la Salud para Municipios, Comunas y Comunidades saludables:



Con el fin de que la intervención pueda identificarse por la ciudadanía, evidenciar concretamente las brechas a intervenir y poder medir sus resultados en términos ecológicos, fue necesario focalizar la intervención del Plan de Promoción. Para ello, se ha determinado que las acciones y actividades de cada Plan de Promoción sean llevadas a cabo en polígonos de la comuna, los cuáles corresponderán al área geográfica a cargo de un centro de salud de atención primaria dentro de la comuna (Centros de Salud (CES), Centros de Salud Familiar (CESFAM), Centros Comunitarios de Salud Familiar (CECOSF), Hospital Comunitario (HC), Postas de Salud Rurales (PSR), o Consultorios Generales). Dichos polígonos deben ser exhaustivos y excluyentes, es decir, cada polígono debe tener límites conocidos y claros, sin que se superponga con otro.

Para la elección del polígono a intervenir, se recomienda la elaboración de un análisis de contexto en promoción de la salud realizado con enfoque participativo e intersectorial. En dicho diagnóstico se deberán identificar los entornos físicos y sociales que el polígono necesita intervenir para lograr un estándar propuesto por el Departamento de Promoción de la Salud, y de esta forma considerar dicho polígono geográfico como un entorno saludable. El estándar propuesto se basa en el concepto de barrios en los cuales, los habitantes de dichos barrios puedan acceder a actividades o infraestructura que promueva hábitos saludables y con ello potencie los factores protectores de la salud de las personas.

Para el estándar, se tomarán en cuenta recursos comunitarios, activos comunitarios y actividades presentes, que promueven la salud y el bienestar, en 3 dimensiones distintas: alimentación saludable, actividad física y cohesión social, las que estarán apoyadas por acciones de participación y que en conjunto se muestran en la siguiente tabla:

Dimensión	Recursos-Activos Comunitarios y/o actividades			
Alimentación Saludable	Puntos de venta de alimentos frescos	Bebederos de agua potable	Huertos Comunitarios	Invernaderos Comunitarios
Actividad Física	Talleres permanentes de Actividad Física	Instalación de Espacios para Actividad Física		
Cohesión Social: Participación	Diagnóstico y Planificación del Plan Comunal	Levantamiento de recursos y activos comunitarios	Escuelas de líderes Comunitarios	Diálogos y Conversatorios Comunitarios
Cohesión Social: Salud Mental	Talleres de Atención Plena	Talleres de Reconocimiento de emociones	Grupos de apoyo	Escuelas de líderes Comunitarios

Para lograr el estándar de entorno saludable, el polígono deberá contar con los recursos - activos comunitarios y/o actividades de cada dimensión, disponibles para toda la población del polígono, como máximo a 10 minutos de caminata desde cada hogar (20 minutos de ida y vuelta aprox). Lo anterior dado que existe un acuerdo general en la literatura científica de que el tiempo máximo que una persona está dispuesta a caminar a un servicio o comercio a nivel de barrio -en promedio- son diez minutos. Talen sugiere que el promedio de velocidad caminable es 1.4 m/seg, que se clasifica como “una caminata fácil y saludable alrededor del barrio”, cinco minutos de caminata cubren 400 metros y diez minutos de caminata cubren 800 metros (Talen, 2011).

De esta forma, cada polígono elegido debe ser intervenido hasta lograr su estatus como entorno saludable, independiente del tiempo o años consecutivos de inversión necesarios para lograrlo. El monto mínimo de inversión en cada polígono corresponde a 4.000.000 de pesos, siendo posible agregar un segundo polígono simultáneamente sólo si la intervención considerada en el primero es considerada suficiente por la SEREMI para alcanzar dicho estatus.

La estrategia de planificación para llegar a completar el territorio con polígonos saludables corresponde a una decisión comunal. Una vez logrado aquello, se considerará por parte del programa que las personas que viven en dicho entorno habitan en un entorno saludable dado que tienen acceso a la infraestructura básica para ello.

En el caso de las comunas rurales con alta dispersión geográfica, se deberá trabajar un modelo diferente al de 20 minutos, tomando en cuenta las grandes distancias que pueden separar los hogares de los recursos comunitarios.

ACTIVIDADES

Las intervenciones en los entornos se diseñan con actividades de distintos componentes, de manera que se genere sinergia entre ellas para lograr el propósito del programa, que es mejorar el acceso de la población a entornos saludables.

Desde el 2021, las actividades del programa se encuentran ordenadas y jerarquizadas, permitiendo dimensionar el peso de cada línea de acción respecto a las otras y su coherencia con el objetivo a cumplir por el componente.

Para este período 2025-2028, se continuará la modalidad de trabajar con actividades asociadas a componentes, asegurando la consistencia interna de la intervención. Con el propósito de asegurar la vinculación entre componentes tanto en la planificación como en la ejecución, que otorgue coherencia a las intervenciones locales, entendida como que las actividades incluidas se potencien entre ellas, que los resultados esperados en los componentes estén o se ven afectados por la sintonía / sincronía entre las actividades planificadas y ejecutadas (Frenk et al., 2021).

Para este período continuará la modalidad de trabajar con actividades asociadas a componentes, lo que implica un mecanismo para asegurar la consistencia de las intervenciones). Para ello es necesario que las actividades incluidas se potencien entre ellas.

El instrumento de evaluación de coherencia disponible en el anexo N°3, corresponde a una herramienta actualizada del período anterior, en formato de cuestionario breve cuyo objetivo es verificar el cumplimiento de ciertos requisitos en la formulación de los Planes por parte del equipo gestor de promoción, así como asegurar que ciertos aspectos han sido debidamente considerados en su diseño y desarrollo. Este cuestionario debe ser contestado por el equipo gestor de promoción de la salud de cada comuna, en una instancia en que participen todos los miembros del equipo, ya que es de interés que cada uno de estos aspectos sea conversado y la respuesta sea por consenso entre los presentes. Asimismo, se espera que aquella instancia permita efectuar ajustes a la planificación en virtud de aumentar la coherencia de las actividades.

En este contexto, para el período 2025-2028, se estableció un total de actividades, las que se disponen en la **“Matriz de actividades”**, que contiene los siguientes campos: ID y nombre de la actividad, componente, definición, objetivo, agrupación, recomendaciones, nivel del modelo socio ecológico. Ésta se encuentra en el anexo N°7.

Al momento de planificar, cada equipo a nivel local deberá elaborar una descripción detallada de la actividad que se realizará. Para que una actividad se considere como correctamente formulada debe cumplir con:

- 1.- Señalar explícitamente sus objetivos de logro, es decir para qué la realiza.
- 2.- Contener información acerca del método para llevarla a cabo, es decir, cómo la realizará.
- 3.- Contener la descripción detallada de la población objetivo, indicando quienes serán los beneficiarios, personas, instituciones.

4.- Contener información acerca de su duración, más allá del cronograma, por ejemplo, duración de sesión educativa, duración de escuela de líderes, duración de talleres permanentes de actividad física, actividades comunicacionales, etc.

5.- Propuesta de medios de verificación que permitan mostrar el resultado de cada actividad.

Podrán sumarse nuevas actividades a las contenidas en estas orientaciones técnicas en la medida que se cumpla con lo siguiente:

- Solicitud del Nivel Central o de una SEREMI en específico con fundamentación en cuanto a evidencia científica que la respalda y justificación según contexto local, etc.
- Reunión de revisión por comisión de revisión de actividades conformada por nivel central y representantes de Seremis de salud.
- Agregando a la plataforma MIDAS y comunicando mediante oficio a las Seremis de Salud de la incorporación de la nueva actividad.

En específico para el nuevo período 2025-2028, se destaca que el listado de actividades del programa ha sido actualizado, considerando para ello los Best Buys de OPS-OMS para las enfermedades no transmisibles (WHO, 2017) predominantes en nuestra etapa de la transición epidemiológica, poblacional y nutricional, entre otras revisiones de evidencia y literatura, mejorando las recomendaciones para que estas se asocien y se impulse la sinergia entre ellas, potenciando de esta forma su impacto para lograr los resultados esperados.

Por ejemplo, respecto a recomendaciones de acciones en alimentación saludable, considerando la evidencia científica y las recomendaciones de organismos, tanto internacionales como nacionales, el Dpto. de Nutrición y alimentos del MINSAL recomienda priorizar estrategias o políticas estructurales por sobre políticas individuales, para modificar entornos alimentarios y contribuir a mejorar la alimentación y salud de la población.

Algunas medidas estructurales, que pueden potenciarse en los territorios son:

- Promoción de entornos alimentarios saludables en escuelas y comunidades: Las escuelas y entornos comunitarios son espacios clave para fomentar hábitos alimentarios saludables. Restringir el acceso a alimentos poco saludables y promover opciones más nutritivas puede generar cambios positivos en el comportamiento alimentario de niños, niñas y adolescentes, así como en sus familias. Es esencial fortalecer la implementación de la prohibición de alimentos “ALTO EN” en los establecimientos educativos y sus alrededores, además de garantizar el acceso a agua potable en las escuelas.
- Incentivar las compras locales, los circuitos cortos y la agricultura familiar campesina: aumentar el acceso a alimentos frescos y saludables a través de ferias locales, mercados campesinos, caletas y otros canales de distribución puede facilitar una alimentación nutritiva a precios más bajos, especialmente en comunidades rurales o de bajos ingresos, donde los alimentos ultra procesados suelen ser más accesibles.

- Apoyo a la lactancia materna y la alimentación temprana: la lactancia materna está vinculada a menores tasas de obesidad infantil. Facilitarla en todos los contextos, incluidos los laborales, es fundamental para mejorar los resultados de salud, especialmente en poblaciones vulnerables, por ejemplo, promover la instalación de salas de lactancia en establecimientos promotores de la salud u otras instancias.

En cuanto a la Actividad Física, OPS-OMS recomienda en el primer lugar intervenciones costo-eficaces implementar campañas de comunicación sostenidas y de alcance poblacional sobre las mejores prácticas para promover la actividad física, con vínculos a programas comunitarios y mejoras ambientales para permitir y apoyar el cambio de comportamiento.

En segundo lugar, proporcionar evaluación de la actividad física, asesoramiento y apoyo para el cambio de comportamiento como parte de los servicios de atención primaria de salud de rutina mediante el uso de una intervención breve.

En tercer lugar, recomienda otras intervenciones en las cuales no hay análisis de costo- efectividad disponible como son:

- Implementar la planificación urbana y del transporte y el diseño urbano, en todos los niveles de gobierno, para proporcionar barrios compactos que proporcionen un uso mixto del suelo y redes conectadas para caminar y andar en bicicleta y un acceso equitativo a espacios públicos abiertos seguros y de calidad que permitan y promuevan la actividad física y la movilidad activa;
- Implementar programas para toda la escuela que incluyan educación física de calidad, instalaciones, equipos y programas adecuados que respalden el traslado activo hacia y desde la escuela y apoyen la actividad física para todos los niños de todas las capacidades durante y después de la escuela;
- Mejorar la infraestructura para caminar y andar en bicicleta, garantizando un acceso universal y equitativo para permitir y promover la caminata, el ciclismo y otras formas de micromovilidad (por ejemplo, sillas de ruedas, scooters y patines) de manera segura para personas de todas las edades y capacidades; Implementar programas de actividad física en el lugar de trabajo con múltiples componentes;
- Proporcionar y promover la actividad física a través de la provisión de programas deportivos y recreativos comunitarios (de base) y realizar eventos gratuitos de participación masiva para alentar la participación de personas de todas las edades y capacidades (WHO, 2017).

Transporte activo se refiere a cualquier forma de viaje no motorizado, incluidos caminar, andar en bicicleta y otros ciclos (Ministerio de Salud, 2024). Los traslados activos son cada vez más reconocidos como un medio para aumentar la actividad física general. Los datos de varios países mostraron que los niños, niñas y adolescentes que viajan a la escuela de manera activa son más activos físicamente en general, al igual que los adultos que se desplazan activamente al trabajo también son más activos físicamente, mejorando su estado de salud (WHO Regional Office for Europe, 2024).

El Plan de Acción Mundial sobre Actividad Física 2018-2030 de la OMS, insta a todos los países miembros a adoptar un enfoque sistémico que permita alcanzar para 2030 una reducción relativa del 15% en la prevalencia mundial de inactividad física entre adultos y adolescentes y, de esa manera, mejorar la salud y el bienestar, para lo cual aboga por fortalecer los entornos activos – mejores lugares y espacios para que todas las personas se mantengan activas, incluyendo diversas acciones para promover el uso de la bicicleta y caminar como medios de transporte y actividad física. Las principales acciones relacionadas con estos objetivos son:

1. Desarrollo de Infraestructura Segura y Atractiva:

- Mejorar la infraestructura urbana para hacerla más segura y atractiva para caminar y andar en bicicleta.
- Crear redes de ciclovías y senderos peatonales bien conectados y accesibles.
- Garantizar la iluminación adecuada y la seguridad vial en estas áreas.

2. Políticas de Transporte y Uso del Suelo:

- Implementar políticas que promuevan el uso de la bicicleta y caminar como medios de transporte sostenibles.
- Integrar la planificación del uso del suelo y el transporte para favorecer la movilidad activa.
- Priorizar el desarrollo de espacios públicos que fomenten la actividad física.

3. Programas y Campañas de Promoción:

- Realizar campañas de concienciación y promoción sobre los beneficios de caminar y andar en bicicleta.
- Desarrollar programas comunitarios que animen a las personas a adoptar estas prácticas como parte de su rutina diaria.
- Incluir la promoción de la movilidad activa en los programas de salud pública y educación.

4. Educación y Formación:

- Educar a los ciudadanos sobre la importancia de la actividad física y cómo incorporar la caminata y el ciclismo en su vida diaria.
- Capacitar a los urbanistas, arquitectos y planificadores de transporte sobre la creación de entornos favorables para la movilidad activa.
- Promover la seguridad vial y el comportamiento responsable entre los peatones y ciclistas.

5. Accesibilidad y Equidad:

- Asegurar que las infraestructuras para caminar y andar en bicicleta sean accesibles para todas las personas, incluyendo aquellos con discapacidades.
- Abordar las barreras sociales y económicas que puedan impedir la participación en la movilidad activa.

- Fomentar la equidad en el acceso a espacios seguros y atractivos para la actividad física.

6. Colaboración Intersectorial:

- Fomentar la colaboración entre los diferentes sectores (salud, transporte, urbanismo, educación) para desarrollar políticas y programas integrales.
- Impulsar alianzas con organizaciones no gubernamentales, comunidades locales y el sector privado para promover la movilidad activa.

Por su parte para potenciar resultados en cohesión social y salud mental las recomendaciones van en la línea del fomento de los modos de vida saludables, las competencias para la vida, las intervenciones para cuidadores y el autocuidado para los prestadores de servicios de la comunidad, así como la prevención del suicidio y del consumo de sustancias psicoactivas.

Finalmente, en cuanto a resultados sociales como asociatividad y cohesión social, la evidencia recomienda impulsar el trabajo en materia de activos comunitarios reconocidos como tales por las comunidades, así como la generación de acciones comunitarias y el desarrollo de competencias individuales para la asociatividad.

Dentro de las actividades posibles de desarrollar en el contexto del Programa de Planes de Promoción de la Salud para MCCS en el marco de la Cohesión Social y Salud Mental, se recomienda:

1. Intervenciones comunitarias orientadas a la restauración de la cohesión social:

Parte de los objetivos de este tipo de actividades apunta a generar conciencia y contrarrestar los estereotipos que puedan existir entre los diferentes grupos que existen en la comunidad, ofreciendo oportunidades para un contacto positivo y una evaluación cooperativa de las relaciones intergrupales. Algunas de las acciones que se pueden desarrollar son: participación en asociaciones y trabajos comunitarios; fomentar la participación y empoderamiento ciudadano; mejorar la integración de quienes han migrado recientemente hacia el territorio; entablar un diálogo público con los medios de comunicación para descartar la difusión de las llamadas “noticias falsas” sobre los grupos sociales que están presentes en el territorio y comunidad (Chuang, Chuang, & Yang, 2013).

2. Actividades sociales con personas mayores:

Estas actividades deben caracterizarse por ser significativas para las personas que participan, adaptadas a sus habilidades y preferencias, y con fuerte foco en fomentar la conexión social y reducir el aislamiento (Wahlbeck, 2015).

3. Intervenciones para el entrenamiento en la práctica de la atención plena:

Estas intervenciones deben implementarse con cuidado, no se puede dar por sentado que serán útiles para todas las personas y en todos los contextos (Galante, et al., 2021).

- Se deberán tener los cuidados necesarios para resguardar a personas para las cuales estas prácticas podrían estar contraindicadas (por ejemplo, personas con algún trastorno de salud mental grave y que no esté controlado, o personas cuyas creencias o trasfondos culturales invalidan este tipo de prácticas).
- Se debe asegurar que quienes faciliten estas intervenciones cuenten con el conocimiento y competencias suficientes.

4. Fortalecimiento de estrategias de afrontamiento:

El afrontamiento se define como el esfuerzo cognitivo y conductual, en constante cambio, de las personas para manejar demandas, dificultades, problemas o adversidades que resultan exigentes para quienes las viven o pueden exceder sus recursos y capacidades. Aquellas estrategias que incluye acciones activas y centradas en los problemas son promotoras de una buena salud mental, y se han visto relacionadas a generar en las personas una sensación de mayor control sobre la vida y las situaciones que les van ocurriendo, además de reforzar la autoeficacia y autoestima (Groth, et al., 2019).

Para implementar estas actividades, es posible utilizar los documentos desarrollados por la Organización Panamericana de la Salud:

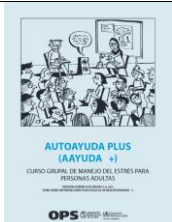


“En tiempos de estrés, haz lo que importa”

Versión adaptada para América Latina, publicada en 2022



<https://iris.paho.org/handle/10665.2/55829>



“Autoayuda plus AAYUDA+”

Curso grupal de manejo del estrés para personas adultas

Versión genérica de ensayo 1.0, publicada en 2021



<https://iris.paho.org/handle/10665.2/57797>

En la implementación de estas actividades se recomienda que quienes las faciliten cuenten con conocimiento sobre PAP (Primera Ayuda Psicológica), e incluso se puede incorporar esta técnica como parte de las competencias a desarrollar (Sharma, Sharma, & Sharma, 2017).

5. Educación e información:

Transversalmente en todas las actividades que se realicen, se pueden incorporar acciones de educación en salud mental, especialmente enfocada en entregar conocimiento sobre los problemas de salud mental y señales de alerta, aumentar la familiaridad con los problemas de salud mental, y entregar información sobre los diferentes servicios de salud mental que existen y las formas de acceder en caso de necesidad

MODELO DE GESTIÓN

El modelo de gestión funciona a través de transferencias desde el nivel central hacia las Seremis de Salud respectivas y éstas a los municipios, los que deben elaborar y ejecutar planes de Promoción de la Salud a cuatro años, cada uno de los cuales debe tener una programación anual, cuestión que fortalece la continuidad de las intervenciones y mejora la gestión administrativa.

A nivel operativo, cabe señalar que el programa se ejecuta mediante convenios suscritos entre las 16 Seremis de Salud con los municipios de su jurisdicción que desarrollen, una planificación a cuatro años en sincronía con el periodo alcaldicio actual.

Sin perjuicio de lo anterior y en casos debidamente justificados, las Seremis de Salud podrán suscribir convenios por un número menor de años.

El **“Formato de convenio”**, se encuentra en el anexo N°8.

A través de estos convenios, el Ministerio de Salud entrega recursos a los municipios con un foco en equidad, para la ejecución de la planificación de Promoción de Salud en el territorio, lo cuales son complementados con recursos provenientes de otras fuentes presupuestarias como las municipalidades, otros sectores y la misma comunidad.

Para que un municipio acceda al programa debe cumplir los siguientes requisitos: encargado/a de promoción de la salud, presentar plan de acuerdo con orientaciones entregadas por el nivel central y contar con procesos administrativos cerrados con el Ministerio de Salud.

El rol de la Seremi es validar que las planificaciones cumplan con las orientaciones técnicas del programa, monitorear y evaluar la ejecución de las actividades y los planes de Promoción de la Salud. Para ello, cada Seremi debe realizar un trabajo permanente de acompañamiento y asistencia técnica a las comunas, a través de apoyo a la gestión, capacitación, abogacía con las autoridades y seguimiento al plan de Promoción de la Salud.

Por su parte, el nivel central elabora orientaciones técnicas, monitorea los avances y resultados del país, de forma coordinada con las Seremi, entrega asistencia técnica y brinda espacios de abogacía en el plano regional y local.

Los Planes de promoción de la salud son elaborados por los municipios. Esto requiere que los equipos locales municipales sean capaces de reflexionar sobre el territorio, sobre los determinantes sociales de la salud y sobre la calidad de vida, y traducir las necesidades de las comunas, priorizando los entornos en los cuales actuar, en un plan único de acción compuesto por actividades elegibles desde un pool de opciones. Asimismo, los municipios son los responsables de ejecutar las actividades y evaluación de éstas, así como reportar a las SEREMI de esto.

La planificación y ejecución de las actividades se agrupa en torno a 4 componentes, ejecutados en base a una secuencia lógica común de fases de planificación-ejecución-evaluación que todos los componentes comparten. Estos se diferencian, principalmente en el objetivo y tipo de actividades que cada componente recoge. Las fases de producción genéricas son:

Fase de Planificación:

1. Municipio realiza análisis de contexto según metodología.
2. Priorización de entornos (polígonos) y selección de actividades de manera participativa.
3. Municipio planifica de acuerdo con presupuesto asignado.

Fase de Ejecución:

1. Transferencia de fondos para ejecución.
2. Desarrollo /ejecución de actividades planificadas.
3. Difusión de la ejecución de actividades del Plan.

Fase de Evaluación:

1. Evaluación anual y cada 4 años.

La estrategia del programa plantea que las intervenciones en Promoción de la Salud requieren de un liderazgo que tenga en cuenta no solamente los puntos críticos del territorio, sino también sus riquezas y potencialidades para que puedan ser utilizadas localmente al servicio de la comunidad. En este sentido, se hace necesario que los alcaldes y alcaldesas estén convencidos del potencial transformador del binomio promoción de la salud/desarrollo local que la Estrategia propone y de que el Chile de todos sólo es posible si se goza de más y mejores oportunidades para que las personas logren realmente ser protagonistas de sus vidas y de su futuro (Ministerio de Salud, 2017).

La planificación a cuatro años contribuye a la continuidad de las intervenciones a nivel local, al coincidir con los periodos de una administración alcaldicia. Otorga mayor sostenibilidad a los procesos, reconoce las capacidades de planificación en el territorio con intervenciones estructurales que consideren la creación de entornos que promuevan la salud abordando las determinantes sociales que se manifiestan en los territorios, ayuda a lograr articulación y sintonía con los instrumentos de planificación local, y permite realizar evaluaciones de resultado y proceso en la comuna.

Sin embargo, para que este modelo logre su mayor potencial, es indispensable que las rendiciones comunales se realicen en los tiempos definidos por la Contraloría General de la República, así como también el cierre de cada año del convenio, esto último para poder contar con los recursos durante los primeros meses de cada año, optimizando de esa manera el tiempo disponible para que cada comuna logre ejecutar las actividades planificadas.

La evidencia científica recomienda que los bienes y servicios que se planifican y prestan a nivel local ofrezcan mejores oportunidades para comprometerse con las comunidades sobre las cuestiones que afectan a su salud, y la forma de abordarlos (Health Service Executive, 2011).

MINSAL ha podido identificar ciertas condiciones base que deben tener las Municipalidades para iniciar el proceso hacia el mejoramiento de la calidad de vida y bienestar de sus habitantes a través de la estrategia Municipios, Comunas y Comunidades Saludables:

- **Respaldo Político**

La voluntad política consiste en la sensibilidad de las autoridades a la propuesta de intervención, su predisposición a escucharla, a diseminarla e impulsarla (Ministerio de Salud, 2017).

- **Respaldo Técnico / Recurso Humano**

“Las personas que trabajan en la municipalidad tienen una gran capacidad para mejorar los procesos de trabajo y aportar con su máximo potencial al logro de los objetivos, en la medida en que estén motivados y comprometidos con éstos, así como con el futuro de la municipalidad y con su propio desarrollo. Está demostrado que las personas motivadas con su trabajo tienen un mejor rendimiento y mayores posibilidades de contribuir a generar mayor satisfacción en usuarios y usuarias que aquellas que no lo están” (Ministerio de Salud, 2017) .

- **Capacidad de Gestión**

Hace referencia al logro de resultados, mediante la utilización eficaz, eficiente y permanente de los recursos de la institución u organización, para dichos objetivos. Actualmente el financiamiento municipal para acciones de promoción de la salud es provisto por los recursos entregados por el Ministerio de Salud, los cuales en muchos casos se complementan con recursos municipales no financieros: en infraestructura, logística, recursos humanos, transporte y comunicaciones. Para lograr lo anterior es fundamental la detección de actores relevantes (individuales, colectivos o institucionales) interesados o afectados por la iniciativa, lo que se logra con un conocimiento acabado de la comunidad en cuanto a sus necesidades, expectativas y grado de satisfacción con los servicios que se les está entregando desde el nivel municipal.

A nivel operativo, para la fase de planificación se ha desarrollado la metodología de análisis de contexto, proceso que da el inicio a la planificación, con sus conclusiones diseña la intervención más adecuada y pertinente para el territorio respectivo.

Para este período se ha desarrollado una metodología de codificación de gastos, con la que se espera contribuir a aumentar la eficiencia del gasto público. Esta codificación que comienza con el Subtítulo (21, 22 o 29), continúa con el ítem y asignación de acuerdo con las clasificaciones presupuestarias establecidas por el Ministerio de Hacienda en su Decreto N° 854.

Respecto de los recursos para la elaboración de las planificaciones, en concordancia con las recomendaciones entregadas por el panel de expertos de la Evaluación de Programas Gubernamentales de la DIPRES realizados al Programa el año 2021, los criterios de asignación de los recursos se mantienen desde el período anterior con foco en equidad. Tanto, los indicadores como la lógica de esta distribución, se explicitan más adelante en el modelo de distribución de recursos del Programa.

Para el proceso de validación de las planificaciones por parte de las Seremis de Salud se ha desarrollado una Pauta de Evaluación que busca ser un apoyo para mejorar la calidad de las planificaciones. Se encuentra disponible en el anexo N°1.

Respecto de la fase de ejecución del Plan es importante señalar que la información de ejecución técnica se registra en la plataforma electrónica dispuesta por el Ministerio de Salud, que en este caso corresponde al sistema MIDAS y que las modificaciones a ésta se deben efectuar en el mismo sistema,

adjuntando el Oficio de Solicitud de Modificación desde la Municipalidad en el cual deberá constar de una explicación de cómo con los cambios requeridos se está asegurando la coherencia de las actividades del Plan. La acción de modificación o edición de las actividades, al igual que la planificación inicial pasará por un proceso de validación desde la SEREMI.

En cuanto a la ejecución financiera y rendiciones financieras se deberán realizar por la plataforma dispuesta por la Contraloría General de la República, incorporando en “observaciones” la codificación de gastos programada, generando coherencia entre ambos registros.

Dado que las intervenciones de Promoción de la Salud deben ser evaluadas tanto en su proceso como en sus resultados, y deben ser implementadas a la luz de la mejor evidencia científica disponible (Ministerio de Salud, 2020), al igual que en el período anterior, se ha actualizado el instrumento de evaluación de calidad y resultados de las actividades de los Planes de Promoción de la Salud, el cual se encuentra disponible en anexo N°4. Sin embargo, se espera que cada comuna evalúe el proceso y resultado de cada actividad planificada.

CAPITAL HUMANO

Tal como el proceso anterior, se evidencia la necesidad de especificar los perfiles regionales y comunales con recomendaciones para que las Seremis de Salud, incorporen contenidos mínimos en los procesos de inducción de nuevos encargados comunales de Promoción de la Salud.

Dada esta necesidad de fortalecer las capacidades, se debe hacer mención especial de algunas áreas de capacitación para la promoción de salud que son prioritarias por el escaso desarrollo que han tenido:

- Capacitación en gestión de la salud
- Capacitación en gestión de la Intersectorialidad
- Capacitación en recursos políticos
- Capacitación para el desarrollo de ciudadanía

En una investigación teórica, sobre capital humano, se considera como el activo con más valor dentro de una organización cuyo importe puede medirse a través de la transformación empresarial donde se garantiza el éxito de la compañía a través de la experiencia, conocimiento, motivación, fijación de objetivos y manejo de cambio del entorno. De igual forma, el capital humano es el valor substancial que posee una organización e involucra el grado de formación, experiencia, haberes, capacidades, habilidades, competencias, equipo de trabajo y conocimiento que garanticen la productividad organizacional (Rojas, 2018).

Es por ello que las comunas deben comprender que las horas destinadas a promoción y participación, son una inversión, así las comunidades, pueden obtener grandes retribuciones al

destinar a un/a encargado/a de promoción como gestor público, a tiempo completo, en forma estable, capacitado, con capacidad de gestión y liderazgo; dichas recompensas son la visibilización del programa de promoción de salud, resultados de impacto en hábitos de vida saludable, más cobertura, y participación, en un nivel mayor de complejidad (Figueroa, 2020).

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS

Para asegurar una distribución equitativa, hemos diseñado un modelo de distribución basado principalmente en la Pobreza Multidimensional, el que tendrá una ponderación de 60%. Este indicador, elaborado a partir de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional - CASEN (Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 2023), nos permite identificar de forma precisa las áreas del país con mayores carencias en educación, salud, vivienda y otros ámbitos fundamentales para el bienestar de las personas. Al centrar nuestra atención en estas zonas, podemos maximizar el impacto de nuestras intervenciones y contribuir a reducir las desigualdades.

La elección de la pobreza multidimensional se fundamenta en su capacidad para ofrecer una visión integral de la situación de las personas y las comunidades. A diferencia de otros indicadores que se centran en un solo aspecto, como el ingreso, la pobreza multidimensional considera múltiples dimensiones de la vida, lo que nos permite tener una imagen más completa y precisa de las necesidades de cada territorio. Además, este indicador cuenta con una amplia base de datos y ha sido utilizado en diversos estudios a nivel nacional, lo que garantiza su confiabilidad y solidez. Cabe señalar que, además, es el único de los utilizados en el trienio anterior que fue actualizado y que sigue contando con datos desagregados a nivel de comunas.

Si bien la pobreza multidimensional se expresa como un único valor en forma de porcentaje, abarca diferentes dimensiones que a su vez cuentan con varios indicadores. Lo anterior se puede ver reflejado en la siguiente tabla:

DIMENSIÓN	INDICADOR
Educación	Acceso a la Educación
	Rezago Escolar
	Escolaridad
Salud	Acceso a atención de Salud
	Adscripción a Sistema Previsional de Salud
	Malnutrición
Trabajo y Seguridad Social	Ocupación
	Seguridad Social

	Jubilación de personas en edad de jubilar
Vivienda	Hacinamiento
	Estado de la vivienda
	Servicios Básicos

Del 40% restante de los recursos, la propuesta para este nuevo período es entregar un 35% de ellos como base para los Municipios que reciban menos de \$15.000.000 por concepto de equidad, lo cual será un piso que nos ayudará a que dichas comunas cuenten con un monto suficiente para desarrollar un Plan de Promoción con todos sus componentes en un polígono determinado, incluyendo actividades que impliquen la instalación de infraestructura.

Finalmente, un 5% será repartido entre comunas denominadas “Extremas” y “Territorios Especiales” lo que va en concordancia con la Política Nacional de Zonas Extremas (PNZE), instrumento que reemplazó a los Planes Especiales de Desarrollo de Zonas Extremas, y cuyo fin es promover bajo un enfoque de derechos, integralidad e intersectorialidad, la naturaleza convergente de estos territorios, en un horizonte proyectado a 10 años (MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA; SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO, 2023).

Al centrarnos en las necesidades de las comunidades más vulnerables, podemos maximizar el impacto de nuestras intervenciones y contribuir de esa manera a un desarrollo más justo y equitativo de los territorios.

Los recursos no comprometidos para su ejecución, informados por las Seremis de Salud, cuando un Municipio no desee suscribir un convenio, no cumpla con los requisitos para suscribir uno, o se ponga término anticipado a uno previamente suscrito, serán considerados remanentes que quedarán a disposición del Nivel Central para ser redistribuidos en base a las necesidades del programa identificadas a nivel nacional. De la misma forma serán considerados remanentes del Programa a disposición de Nivel Central, los recursos adicionales que entregue la Dirección de Presupuestos como inflactor para cada año.

Recomendaciones en torno al perfil de los referentes de las SEREMI

En conjunto con un grupo de encargados regionales de los Planes de Promoción de la Salud (regiones que participaron: Antofagasta, Coquimbo, Metropolitana, O'Higgins, Biobío, Araucanía, Los Lagos y Aysén), se realizó el siguiente ejercicio, donde se encomendó que pudieran definir desde sus experiencias locales, cuáles deberían ser las características que detallaran ciertos grados de conocimientos y habilidades para operacionalizar esta estrategia. Definir los conocimientos y habilidades para el encargado regional de promoción de la salud, contribuye a orientar procesos de selección e implementar procesos de inducción y capacitación.

Perfil referentes de las SEREMI

Conocimientos profesionales, Postgrados (Magíster - Diplomado) en:

- Salud Pública
- Políticas Públicas
- Equidad en Salud y Determinantes Sociales de la Salud
- Promoción de la Salud
- Educación para la Salud
- Comunicación Social
- Ciencias Sociales
- Participación Ciudadana, social y comunitaria
- Intersectorialidad
- Actividad Física,
- Nutrición y alimentación,
- Psicología comunitaria
- Psicología de la salud

Cursos de formación y/o procesos de inducción en las temáticas ya mencionadas:

- Conocimiento de la Estrategia MCCS y Estrategias de Promoción de la Salud vigentes.
- Orientaciones Técnicas para la elaboración de los Planes de Promoción de la Salud para MCCS.
- Enfoques transversales (Determinantes Sociales de la Salud, Salud en Todas las Políticas, Factores Protectores Psicosociales e Interseccionalidad)
- Modelo de Salud Integral con enfoque familiar y comunitario
- Evaluación de Políticas Públicas, Programas y Planes
- Conocimientos en administración o gestión en salud, planificación estratégica, gestión territorial, financiamiento y presupuestos municipales – regionales, herramientas de gestión administrativa (Ley de compras públicas normativas de rendición de cuentas)
- Conocimiento en análisis de datos.
- Conocimiento de la Estrategia Nacional de Salud y pertinencia local
- Otros temas específicos de salud pública como: contaminación ambiental, zoonosis, salud laboral, urbanismo saludable, agricultura sostenible, determinantes socioambientales, consumo de tabaco, etc.

Habilidades y competencias:

- Liderazgo, proactividad y capacidad de autogestión.
- Capacidad de trabajo en equipo.
- Capacidad de realizar procesos de abogacía tanto con autoridades regionales y locales.
- Tolerancia a la frustración/ Orientación al cambio/ resolución de conflictos.
- Habilidades emocionales/ manejo de conflictos.
- Habilidades sociales en el ámbito sanitario/ Empatía, respeto, escucha activa, autocontrol, comunicación activa.
- Capacidades para resolución de problemas/ -Situaciones de discriminación por razones de género o de todo tipo.
- Habilidades para trabajar intersectorialmente.

Cantidad de horas necesarias para realizar las funciones vinculadas a Planes de Promoción de la Salud para Municipios, Comunas y Comunidades Saludables

Siguiendo la misma línea que se consideró en el período anterior, se utilizará la metodología recomendada en las “ (Ministerio de Salud, 2022) de la División de Atención Primaria (DIVAP) de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, en el cual para obtener las horas ideales de trabajo se realiza un cálculo del ciclo anual de actividades.

En este contexto, como primer paso para efectuar el cálculo de horas, se definieron las actividades que deben realizar los equipos de las Seremis en el marco de los planes de promoción de la salud, las cuales están disponibles en el anexo N°7. En un segundo paso se estimó la cantidad de horas necesarias por actividad.

Tabla N°3: Descripción del cálculo de horas.

Se considerará para este proceso **52** semanas anuales iniciales, de las cuales debemos descontar los días no hábiles del año a programar según los siguientes criterios:

A los **365** días anuales, que corresponden a **52** semanas se descontará:

- Sábados y domingos
- Feriados anuales del año a programar lo que corresponde a 2 semanas al año (9 a 10 días hábiles en general)
- Tarde de los días **17** de septiembre, **24 y 31** de diciembre.

Dejando un total de **220** días a programar

Para realizar este ejercicio se tomó en consideración la participación de 10 regiones, de las cuales se hizo un levantamiento con las horas que se estimó que ocuparían en las actividades programadas de los planes, para obtener un resultado.

Resultado:

- Para un período anual, compuesto por 220 días trabajados de acuerdo con el cálculo señalado anteriormente, el promedio de horas que se destinarían actualmente para todas las actividades que los equipos de SEREMI desempeñan en el marco del trabajo de los Planes de Promoción de la Salud, es de 0,37 horas al día por comuna. Este cálculo se obtuvo considerando la implementación de planes en el 100% de las comunas del país para el trienio 2022-2024.
- Este promedio es equivalente a 81,4 horas al año por comuna, considerando los 220 días al año de trabajo de un funcionario.

Sin embargo, esta cifra es un promedio obtenido en base a la información de 10 regiones y con variabilidad dependiendo de los contextos regionales propios de cada territorio. Es así, como la región que presenta el menor número de horas promedio por comuna al año es 0.06 horas y la región con el número mayor fue de 3.105 horas.

Recomendaciones respecto del perfil de las personas encargadas a nivel comunal

Existe consenso que las personas encargadas a nivel comunal de promoción de salud, debe tener absoluta claridad del diagnóstico local, lo que se debe realizar, cuáles serán las estrategias y los actores locales que debe tener como aliados ante la tarea. Existe consenso entre los encargados de promoción que llevan más de cinco años en el cargo, que el proceso de apropiación y conocimiento cabal del cargo, demora un periodo de tres años aproximadamente, y recién desde el cuarto año en adelante, es posible obtener logros y resultados importantes (Figueroa, 2020).

Además, es importante señalar que varias de las funciones que a continuación se describen, son definidas como complejas para algunas regiones, donde los encargados son funcionarios de diversas dependencias del Municipio (DIDECO, Oficinas de deportes, cultura, y otras) sin mayores competencias en Salud Pública y sin relación formal y administrativa con los equipos de salud primaria. Por lo anterior, se debería considerar un perfil diferenciado en las comunas sin atención primaria Municipal.

Tabla 2: Perfil referentes de las COMUNAS

Conocimientos técnicos:

- Conocimiento en Salud Pública y Promoción de la Salud, DSS e intersectorialidad.
- Conocer la Estrategia Municipios, Comunas y Comunidades Saludables
- Conocimientos en administración o gestión municipal, planificación estratégica, gestión territorial, financiamiento y presupuesto municipales – regionales, herramientas de gestión administrativas (Ley de compras públicas normativa de rendición de cuentas).
- Conocimiento en enfoque transversales (Determinantes Sociales de la Salud, Salud en Todas las Políticas, Factores Protectores Psicosociales e Interseccionalidad).

- Conocimiento sobre Atención Primaria de Salud (MAIS, OOTT de la RED)
- Conocimiento de la red intersectorial pertinente a la gestión
- Educación para la salud
- Educación adultos
- Metodologías de participación
- Sistematización y evaluación
- Gerencia social

Habilidades y/o destrezas:

- Trabajo en Equipo
- Adaptación al Cambio
- Proactividad
- Trabajar en Equipo intersectorialmente
- Creativo/a
- Resolución de Conflictos
- Generar Diálogos y Comunicación Efectiva
- Capacidad de gestión
- Lograr articulaciones integradas con el intersector y autoridades locales
- Liderazgo
- Capacidad de abogacía.
- Capacidad de sistematización.
- Tolerancia a la frustración/ Orientación al cambio.

Tabla 3: Contenidos mínimos de inducción de nuevos referentes comunales de Promoción de la Salud

- Orientaciones técnicas asociadas a Planes de Promoción de la Salud para MCCA y Estrategia MCCA.
- Uso de plataforma digital dispuesta para la gestión de los Planes de Promoción de la Salud para MCCA.
- Marcos teóricos y estrategias de Promoción de Salud.
- Promoción de la Salud, Equidad en Salud, Determinantes Sociales de la Salud.
- Salutógenesis.
- Contenidos jurídicos administrativos relacionados con los convenios de Planes de Promoción de la Salud para MCCA.
- Procedimientos para realizar abogacías.
- Trabajo Intersectorial y Salud en Todas las Políticas.
- Administración y gestión de los recursos, rendiciones en plataforma de la Contraloría General de la República.
- Gestión e instrumentos municipales y territorial.
- Manejo de estrategias, enfoques y metodologías educativas, comunitarias de salud – participativas.
- Metodología en participación social, por ejemplo: diagnóstico participativo.
- Metodología en educación de adultos
- Estrategias comunicacionales efectivas y uso de redes sociales.
- Conocimiento en Planificación Estratégica.
- Sistemas de reconocimiento para entornos.
- Enfoque Interseccionalidad

PLATAFORMA DIGITAL MIDAS

El módulo de Promoción en MIDAS (Modernización de la Información Digital de la Autoridad Sanitaria), consiste en un módulo de gestión, enfocado en el usuario, que ayuda a los municipios del país a planificar, ejecutar y evaluar de manera sistematizada las actividades de los Planes de Promoción de la Salud.

Esta plataforma permite diseñar los Planes identificando los entornos que serán intervenidos, es decir, el polígono y los recursos comunitarios dónde se realizarán las actividades, identificar actividades que contribuyan al logro de los resultados esperados del programa, editar la planificación en casos justificados, registrar la ejecución de las actividades de esté, además de contar con una funcionalidad de reportabilidad en tiempo real para los perfiles nacional, regional y comunal. Cada una de las funcionalidades de la plataforma cuenta con un manual de usuario.

EVALUACIÓN

La evaluación es una fase muy relevante en el ciclo de las políticas Públicas. Es por esto que hemos definido un listado mínimo de elementos que nos permiten considerar exitosa la gestión de un Plan Comunal de Promoción de la Salud. Estos elementos serán considerados metas del programa.

Concretamente, las metas para cumplir son las siguientes:

1. 90% de cumplimiento de las actividades planificadas anualmente.
2. Ejecución presupuestaria anual de al menos un 90% de los recursos.
3. Cumplir con el registro de la ejecución del Plan en la plataforma dispuesta por el Ministerio de Salud para este fin.
4. Aplicación de instrumentos de evaluación especificados por el Ministerio de Salud.
5. Equipo gestor y comité intersectorial conformado y/o actualizado, oficializados por acto administrativo correspondiente.
6. Envío de rendiciones financieras mensuales dentro de los plazos establecidos en el presente convenio.
7. Cumplimiento de 50% del cronograma planificado para todas las actividades.

REFERENCIAS

- Allen, Balfour, Bell, & Marmot. (2014). Social determinants of mental health. *International review of psychiatry*, 26(4), 392 – 407.
- Banco Mundial. (2023). *CHILE: HACIA UN ESTADO DIVERSO, INCLUSIVO Y SIN DISCRIMINACIÓN*. Obtenido de <https://documents1.worldbank.org/curated/en/099324411082311972/pdf/IDU0eb243f2701774049890b8b6084b5a1735164.pdf>
- Cepal. (2007). *Cohesión Social: inclusión y sentido de pertenencia en América Latina y el Caribe*. Obtenido de <https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/15c3f203-d4af-40a0-aa7d-faf84b93cc4e/content>
- Cerin, E., Saelens, B., Sallis, J., & Frank, L. (2006). Neighborhood Environment Walkability Scale: Validity and Development of a Short Form. *Medicine and Science Sports and Exercise*, 1682-1691.
- Chuang, Chuang, & Yang. (2013). Social cohesion matters in health. *International journal for equity in health*, 1-2.
- Colás, M., & Buendía, M. (1994). *Investigación Educativa*. . Andalucía: Ediciones Alfar.
- Echeverría. (2008). *Health & Place*.
- Figuerola, S. (2020). *Tesis de Grado: Formulación de propuesta técnica , para la incorporación del componente valor público , en los planes comunales de promoción de salud , en comunas de la Región de O ' Higgins, Chile*.
- Fusar-Poli, Pablo, D., Micheli, D., Nieman, Correll, Kessing, . . . Amelsvoort, V. (1 de Febrero de 2020). A scoping review.. What is good mental health? A scoping review. *European neuropsychopharmacology*, 33-46.
- Galante, J., Friedrich, C., Dawson, A., Modrego-Alarcón, M., Gebbing, P., Delgado-Suárez, I., . . . Jones, P. (2021). Mindfulness-based programmes for mental health promotion in adults in nonclinical settings: A systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. *PLoS medicine*.
- Groth, N., Schnyder, N., Kaess, M., Markovic, A., Rietschel, L., Moser, S., . . . Schmidt, S. (2019). Coping as a mediator between locus of control, competence beliefs, and mental health: A systematic review and structural equation modelling meta-anameta-analysis. *Behaviour research and therapy*.
- Ministerio de Desarrollo Social y Familia. (2020). *Informe final Consejo Asesor para la Cohesión Social*. Obtenido de https://www.desarrollosocialyfamilia.gob.cl/storage/docs/Informe_Final_Consejo_Cohesion_Social.pdf
- Ministerio de Desarrollo Social y Familia. (2021). *Primera Medición del Bienestar Social en Chile 2021*. Santiago. Obtenido de <https://www.estudiospnud.cl/informes-desarrollo/principales-resultados-de-la-primera-medicion-del-bienestar-social-en-chile/>
- Ministerio de Desarrollo Social y Familia. (2023). *Encuesta Casen 2022*. Obtenido de Chile: <https://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/encuesta-casen-2022>
- Ministerio de Desarrollo Social y Familia. (2023). *Encuesta de Bienestar Social*. Chile. Obtenido de <https://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/encuesta-bienestar-social-2023>
- Ministerio de Salud. (2017). *ORIENTACIONES POLÍTICO-ESTRATÉGICAS PARA EL GOBIERNO LOCAL*. Chile.

- Ministerio de Salud. (2017). *Política Nacional de alimentación y nutrición*. Obtenido de http://www.bibliotecaminsal.cl/wp/wp-content/uploads/2018/01/BVS_POL%C3%8DTICA-DE-ALIMENTACI%C3%93N-Y-NUTRICI%C3%93N.pdf
- Ministerio de Salud. (2021). *Plan de acción de Salud Mental 2019-2025*. Chile. Obtenido de <https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2022/01/Plan-de-Acci%C3%B3n-Salud-Mental-2019-2025.pdf>
- Ministerio de Salud. (2022). *Orientaciones para la planificación y programación en red*. Chile.
- Ministerio de Salud. (2024). *Guía de Transporte Activo Escolar*. Obtenido de <https://dipol.minsal.cl/departamentos-2/promocion-de-la-salud-y-participacion-ciudadana/>
- Ministerio de Salud. (2024). *Informe Nacional Diagnósticos Regionales de Salud con Enfoque en Determinantes Sociales*. Obtenido de https://epi.minsal.cl/datos_drs/#/
- Ministerio de Salud. (2024). *Política de Medicina Complementaria y Prácticas de Bienestar de la Salud*. Chile. Obtenido de https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2024/10/2024.08.16_POLITICA-MEDICINA-COMPLEMENTARIA-VF.pdf
- MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA; SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO. (2023). *Decreto 43 APRUEBA REGLAMENTO QUE FIJA LA POLÍTICA NACIONAL DE ZONAS EXTREMAS*. Obtenido de <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1195801>
- Morton. (2018). Combining lifestyle medicine and positive psychology to improve mental health and emotional well-being. *American journal of lifestyle medicine*, 370-374.
- OMS. (2004). *Invertir en Salud Mental*. Obtenido de <https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/42897/9243562576.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- OMS. (2008). *Subsanar las desigualdades en una generación*. Obtenido de https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/69830/WHO_IER_CSDH_08.1_spa.pdf?sequence=1
- OMS. (2018). *Género y salud*. Obtenido de <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/gender>
- OMS. (2020). *El poder de las ciudades: lucha contra las enfermedades no transmisibles y los traumatismos causados por el tránsito*. Obtenido de <https://iris.who.int/handle/10665/335914>
- OMS. (2022). *Plan de Acción Integral de Salud Mental 2013-2030*. Obtenido de <https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/357847/9789240050181-spa.pdf?sequence=1>
- OPS. (2021). *AGENDA PARA LAS AMÉRICAS SOBRE SALUD, MEDIOAMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO*. Obtenido de https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/55212/OPSCDECE210004_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- OPS/OMS. (2022). *Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030*. Obtenido de <https://iris.paho.org/handle/10665.2/55950>
- OPS/OMS. (2024). *Criterios para Municipios, Ciudades y Comunidades Saludables en la Región de las Américas*. Obtenido de <https://iris.paho.org/handle/10665.2/59524?locale-attribute=es>
- OPS/OMS. (s.f.). *Curso Virtual de Promoción de la Salud (autoaprendizaje)*. Obtenido de <https://campus.paho.org/es/curso/promocion-salud>
- OPS/OMS. (s.f.). *Determinantes Sociales de la Salud*. Obtenido de <https://www.paho.org/es/temas/determinantes-sociales-salud>
- Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud. (2024). *Curso Promoción de la salud*. Obtenido de <https://bit.ly/CVOPS-PromocionSalud>.

- Rojas, J. (2018). Capital humano un desglose teórico para su operatividad en organizaciones inteligentes. *CICAG: Revista Del Centro de Investigación de Ciencias Administrativas y Gerenciales*, 16, 43–54.
- Salud, M. d. (2017). *Plan Nacional de Salud Mental 2017-2025*.
- Schiefer, & Noll, V. d. (2017). The essentials of social cohesion: A literature review. *Social Indicators Research.*, 579-603.
- Sharma, Sharma, & Sharma. (2017). Mental health promotion: a narrative review of emerging trend. *Current opinion in psychiatry*, 339-345.
- Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. (2022). *Atlas Matriz de Bienestar Humano Territorial*. Chile. Obtenido de <https://proactiva.subdere.gov.cl/handle/123456789/638>
- Talen, E. (2011). Rehabilitación urbana expansiva: formas urbanas sostenibles en lugares insostenibles. *Environment and Planning B: Planning and Design*, 952-978.
- UN. (s.f.). *Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades*. Obtenido de <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/>
- UNFPA. (2006). IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO: APROXIMACIÓN TEÓRICO-CONCEPTUAL. En L. Mora, H. Fritz, & T. Valdés. Obtenido de <https://elsalvador.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Herramientas%20de%20trabajo%20en%20genero%20UNFPA.pdf>
- Wahlbeck, K. (2015). Public mental health: the time is ripe for translation of evidence into practice. *World Psychiatry*, 36-42.
- WHO. (2017). 'Best buys' and other recommended interventions for the. Obtenido de <https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/259232/WHO-NMH-NVI-17.9-eng.pdf?ua=1>
- WHO Regional Office for Europe. (2024). *Health-enhancing physical activity in the European Union*.

ANEXOS

ANEXO N° 1 Pauta de validación de Planes de Promoción de la Salud para Municipios, Comunas y Comunidades Saludables

Región:

Comuna:

La formulación de los Planes de Promoción de la Salud para MCCS deben pasar por un proceso de evaluación, el que busca validar la programación del Plan, revisando que haya sido formulado de forma correcta, coherente, consistente y atingente.

Durante este proceso se valida que las actividades sean pertinentes con las necesidades de la comuna en materia de promoción de la salud.

En términos prácticos, esta evaluación se debe realizar utilizando una pauta que consta de tres áreas. La primera de ellas evalúa los aspectos más relevantes relacionados con el análisis de contexto, la segunda evalúa la calidad de los registros de planificación de actividades y la tercera se relaciona con aspectos centrales de la evaluación de coherencia.

Esta Pauta se acompaña de algunos indicadores elaborados de manera automática por la plataforma digital para apoyar la evaluación realizada por la SEREMI.

Cabe señalar que la validación de las planificaciones es un proceso dinámico, en el cual la SEREMI puede devolver la planificación al nivel comunal para corregir alguno de los aspectos evaluados en la pauta u otros detectados que requieran mejora.

Área	Criterio	Indicador Automático	SI / NO	Fundamentación (obligatorio)
Análisis de Contexto	1.- Se realizó análisis de contexto para identificar las necesidades de la comunidad	N/A		
	2.- El análisis de contexto está basado en una perspectiva de Determinantes Sociales	N/A		

	3.- El análisis de contexto fundamenta la priorización del/ los entornos seleccionados (polígono/s).	N/A		
Planificación	4.- Las actividades están correctamente formuladas y son pertinentes para el desarrollo de su objetivo.	4.1.- Cada actividad señala explícitamente sus objetivos de logro, es decir para qué la realiza. (Se recomienda evaluar campo: Detalle de actividad con enfoque local)	N/A	
		4.2.-Cada actividad contiene información acerca del método para llevarla a cabo, es decir, cómo la realizará. (Se recomienda evaluar campo: Detalle de actividad con enfoque local)	N/A	
		4.3.- Cada actividad cumple con la descripción detallada de la población objetivo, indicando quienes serán los beneficiarios, personas, instituciones. (Se recomienda complementar evaluación con el campo: Detalle de actividad con enfoque local)	Porcentaje de actividades con población objetivo	
		4.4.- Cada actividad contiene información acerca de su duración, más allá del cronograma, por		

	ejemplo, duración de sesión educativa, duración de escuela de líderes, duración de talleres permanentes de actividad física, actividades comunicacionales, etc. (Se recomienda evaluar campo: Detalle de actividad con enfoque local)			
	4.5.- ¿Los medios de verificación propuestos, permiten mostrar el resultado de cada actividad? (Se recomienda evaluar campo: Verificador de proceso y resultado)			
	5.-Las intervenciones programadas no se centran sólo en el nivel individual, interpersonal y organizacional, sino que incorporan actividades relacionadas con el nivel comunitario y el nivel de políticas públicas.	N° de actividades de nivel comunitario N° de actividades de nivel de políticas públicas		
	6.-Se incorpora a la sociedad civil de manera consultiva y/o resolutive en el diseño del plan (comités paritarios, centros de padres, centros de alumnos, consejos escolares, organizaciones funcionales, comunidades indígenas, organizaciones territoriales u otros).	SI/NO Respuesta automática desde Planificación sección gestión del plan		
	7.-Planifica en todos los componentes. Fundamentar la no planificación en alguno.	N° de actividades planificadas del componente 1 Políticas y regulaciones locales saludables		

		N° de actividades planificadas del componente 2 Rehabilitación y optimización de espacios públicos para la vida saludable N° de actividades planificadas del componente 3 Participación comunitaria para el empoderamiento en salud N° de actividades planificadas del componente 4A Comunicación social N° de actividades planificadas del componente 4B Educación para la salud		
Coherencia de actividades	8.- ¿Las actividades planificadas son coherentes con un cierre de brecha levantado en el análisis de contexto?	N/A		
	9.- ¿Las actividades planificadas son coherentes y sinérgicas entre sí para lograr un resultado integral?	N/A		
	10.- ¿Las actividades planificadas son pertinentes al/los entorno/s priorizados (polígono/s)?	N/A		
	11.- ¿El diseño de cada actividad tiene la característica de aceptabilidad para el mundo social y cultural en el cual van a ser aplicadas?	N/A		

*N/A: No aplica

Comentarios generales a la planificación:

BORRADOR

ANEXO 2 Pauta para evaluar la incorporación de enfoque de Género en los Planes de Promoción de la Salud para Municipios, Comunas y Comunidades Saludables

La Promoción de la Salud como función esencial de la Salud Pública tiene como fin elevar la calidad de vida y nivel de salud de la población. Desde los Planes de Promoción de la Salud para Municipios, Comunas y Comunidades Saludables se contribuye a dicha función liderando la formulación, seguimiento y evaluación de las políticas locales e intervenciones de habilitación y mejoras de los entornos saludables. Considerando los enfoques de derechos, equidad, género y participación, atendiendo a los determinantes sociales y las necesidades de salud de las comunidades.

Con el propósito de contribuir a la equidad de Género en la disponibilidad y acceso a los bienes y servicios con los que contribuye el Programa de Planes de Promoción de la Salud para Municipios, Comunas y Comunidades Saludables, se pone a disposición esta herramienta, la cual fue elaborada por el equipo del Departamento de Promoción de la Salud de la División de Políticas Públicas Saludables y Promoción en conjunto, con el Departamento de Derechos Humanos y el Departamento de Gestión del Cuidado de la División de Atención Primaria, en base a la “Guía para la incorporación de la Perspectiva de Género en Programas de Salud” de la Secretaría de Salud, Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. México.

En nuestro país, se han logrado importantes avances en materia de Políticas Públicas que incorporan la equidad de género en sus principios y acciones, ejemplo de ello es la Política Sectorial de Género del Ministerio de Salud del año 2010 que hace suyo los mandatos internacionales y nacionales de igualdad entre mujeres y hombres, en el marco ético y jurídico de los derechos humanos. De la misma manera, constituye un importante instrumento sectorial para contribuir a la justicia social en salud, al cumplimiento de los compromisos internacionales. Entre éstos cabe mencionar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, de los cuales, el quinto está referido a “igualdad de género y empoderamiento de las mujeres”, es por ello la importancia de incorporar la perspectiva de género en nuestro quehacer profesional e institucional.

Es importante considerar que el análisis de Género, permite lo siguiente:

- Examinar los roles y responsabilidad en la sociedad, incorporando diferencias en la distribución de responsabilidad basada en estereotipos de género.
- Evitar que los medios de comunicación perpetúen la atribución de roles basada en el género.
- Permite incorporar lenguaje inclusivo para hablar y comunicarse con la comunidad con el respeto de equidad y sin expresar sexismo.
- El lenguaje es una potente herramienta de cambio e instrumento para erradicar la desigualdad e invisibilización de las mujeres.
- El lenguaje no sexista, hace referencia a toda expresión verbal o escrita que utiliza preferentemente un vocabulario neutro, o en su defecto, hace evidente lo masculino y lo femenino, evitando las generalizaciones de lo masculino que se aplican a diversas situaciones o actividades donde participan hombres y mujeres.

Algunas recomendaciones para incorporar lenguaje inclusivo:

- Utilizar palabras que permiten expresiones neutras

Ejemplo:

- “persona”: personas que trabajan
- “personal”: el personal fiscalizador, el personal de salud

- No utilizar el término hombre con valor genérico, es decir, distinguir cuando usa la palabra hombre para referirse a un varón o para referirse a hombres y mujeres. En el segundo caso, genera frecuentes ambigüedades y oculta a las mujeres. Usar la palabra “hombre solo cuando atañe al sexo masculino, en cuyo caso es menos confuso utilizar “varón” o sustituirlo por sustantivos colectivos (ser humano, género humano, humanidad). Es así como en lugar de decir:

Ejemplo:

- “Los ciudadanos” - se puede utilizar La ciudadanía
- “Los indígenas” - Población indígena
- “El refugiado” - La persona refugiada

- Para mayor información, revisar los siguientes enlaces:

- https://kitdigital.gob.cl/archivos/160302_ManualPpctvaGeneroTRAZADO_baja.pdf
- https://www.suseso.cl/601/articles-578130_recurso_005.pdf

Alcance y uso

Esta pauta puede ser utilizada por los profesionales que constituyen el equipo Gestor e Intersectorial a cargo de la planificación de las intervenciones programadas en los Planes de Promoción de la Salud para Municipios, Comunas y Comunidades Saludables. También, se puede apoyar su utilización a través de la inducción y/o seguimiento de los referentes de género de la Seremi en coordinación con los equipos regionales de promoción de salud.

La pauta debe ser aplicada desde el momento de la detección de las necesidades en las comunidades que se quiere abordar a través del Plan, para lo cual el diagnóstico participativo puede complementarse con la revisión de información primaria y/o secundaria durante el proceso de planificación.

También se puede utilizar para el monitoreo o evaluación de las actividades. Se recomienda su utilización para el diseño, construcción de material gráfico y audiovisual, como: afiches, folletos, videos y contenido de página web.

Pauta para la incorporación del enfoque de género en las actividades de los Planes de Promoción de la Salud para Municipios, Comunas y Comunidades Saludables

Se debe marcar con una X si al menos una de las actividades programadas por componente cumple con el criterio

Actividades del Componente Regulaciones Locales Saludables				
	Criterio	Cumple	No Cumple	No aplica
1	Se ha desarrollado un análisis para identificar inequidades, brechas o barreras de género respecto a la temática que aborda la regulación local.			
2	El documento declara la equidad de género como parte del enfoque con el que se diseña e implementa la política local para contribuir a la calidad de vida y bienestar de la población de la comuna. Propone mecanismos de abordaje pertinentes a todo el continuo de género (hombre, mujeres, LGBTIQ+) a lo largo del curso de vida.			

Actividades del Componente Habilitación y Optimización de espacios públicos para la vida saludable				
	Criterio	Cumple	No Cumple	No aplica
1	Se identifican inequidades, brechas o barreras de género a nivel de disponibilidad y/o acceso de infraestructura, en hombres, mujeres y comunidad LGBTIQ+ para el uso efectivo de la infraestructura, equipamiento y espacios públicos intervenidos anteriormente por los Planes de Promoción de la Salud para Municipios, Comunas y Comunidades Saludables o nuevos programados para el actual Plan de Promoción.			
2	Se incorpora un plan de uso para el espacio saludable que incorpora estrategias que fomentan el uso equitativo e inclusivo para todas las personas a lo largo de todo el curso de vida.			
3	La actividad o intervención se relaciona y contribuye con proyectos que promuevan y faciliten la sociabilidad, la interacción y la vida en común, con equipamiento para el ocio, el descanso y el deporte con especial atención a la accesibilidad universal.			

Actividades del Componente Participación comunitaria para el empoderamiento en salud.

	Criterio	Cumple	No Cumple	No aplica
1	Las actividades de participación consideran estrategias de convocatoria y horarios de realización que contribuyen a eliminar barreras de acceso por género.			
2	En las actividades de participación (escuela de líderes, diálogos ciudadanos u otros) se presentan datos sanitarios y/o epidemiológicos diferenciados por sexo y en función de variables como (demográficos, territoriales, socioeconómicos, etnia, nacionalidad, uso del tiempo y del espacio, entre otros).			
3	En las actividades de participación se ha planificado contenidos en Promoción de la Salud, y sus enfoques. Con énfasis en temáticas como Corresponsabilidad Social del Cuidado, Determinantes Sociales de la Salud, entre otros temas de Calidad de Vida y Bienestar con perspectiva de Género.			

Actividades del Componente Comunicación Social.				
	Criterio	Cumple	No cumple	No aplica
1	Las estrategias comunicacionales contienen perspectiva de género en algunos de los siguientes temas: - Promoción de Buen Trato y Sana Convivencia - Corresponsabilidad Parental en Labores domésticas y de cuidado. - Promoción de la Participación Masculina en Trabajos y Labores de cuidado.			
2	Las estrategias comunicacionales utilizan equitativamente imágenes de mujeres y hombres y de la comunidad LGBTQ+ eliminando estereotipos de género. Por ejemplo: Imágenes gráficas refuerzan estereotipos de género, como el hombre activo, creativo, imaginativo, con poder de decisión y a la mujer en labores domésticas, pasivas, sedentes, y sólo en asociación con labores asociadas a la crianza.			
3	Las estrategias comunicacionales utilizan un lenguaje neutro en términos de identidad de género y grupos objetivos, evitando el uso del falso genérico masculino.			

Actividades del Componente Educación para la Salud				
	Criterio	Cumple	No cumple	No aplica
1	Los materiales que acompañan el desarrollo del documento utilizan una redacción neutra en términos de identidad de género. Los materiales educativos utilizan lenguaje inclusivo, no utiliza ejemplos sexistas, ni homofóbicos.			
2	Los contenidos de las actividades educativas no refuerzan estereotipos de género asociados a comportamientos, ocupaciones, aspecto físico, u otros. Ejemplo: la mujer cocinando, hombre reparando auto.			

3	En las actividades de educación para la salud se incorporan temáticas como Corresponsabilidad Social del Cuidado, Determinantes Sociales de la Salud, entre otros temas de Calidad de Vida y Bienestar con perspectiva de Género.			
---	---	--	--	--

BORRADOR

Glosario

Género: Conjunto de atributos simbólicos, sociales, políticos, económicos, jurídicos y culturales, asignados socialmente al ser hombre o ser mujer que establecen roles y estereotipos a partir de los cuales las personas construyen sus identidades. Establece relaciones sociales de poder entre mujeres y hombres que generan inequidades en el ámbito de la salud y de la vida en general. Es relacional, jerárquico, cambiante a través del tiempo, contextualmente específico e institucionalmente estructurado.

Sexo: Diferencias que existen entre mujeres y hombres, dadas por su condición biológica y fisiológica. Son congénitas, se nace con ellas y son universales.

Enfoque de género: Se refiere a tener en consideración el lugar y el significado que las sociedades dan al hombre y a la mujer en su carácter de seres masculinos o femeninos, reconociendo que un tema es la diferencia sexual y otras las atribuciones, ideas, representaciones y prescripciones sociales que se construyen tomando como referencia esa diferencia sexual.

Enfoque de género en salud: Reconocer que más allá de las diferencias biológicas de sexo, existen distinciones de género socialmente construidas entre mujeres y hombres que afectan diferencialmente la salud de unas y otros y su respectiva posición dentro del sistema de salud.

Barreras de género: Factores que impiden o limitan el acceso de las mujeres o de los hombres a ciertos beneficios, programas y/o políticas institucionales. Las barreras pueden ser legales/normativas/reglamentarias; condiciones de acceso; entre otras. Ejemplos: El horario de atención en los establecimientos de atención primaria no facilita condiciones para que las personas que trabajan puedan asistir.

Brechas de género: Cuantificación de diferencias entre hombres y mujeres que constituyen inequidades de género. Desde una perspectiva estricta, puede entenderse por brechas de género “la diferencia cuantitativa observada entre mujeres y hombres en cuanto a valores, actitudes, y variables de acceso a los recursos, a los beneficios de la producción, a la educación, a la participación política, al acceso al poder y la toma de decisiones, entre otros”. Ejemplos: Brecha Salarial según la Encuesta Casen es de 23,6%, es decir por cada 4 pesos que gana un hombre, la mujer sólo gana 3 pesos.

Discriminación por género: Se presenta al atribuir mayor importancia a uno de los dos géneros en detrimento del otro reproduciendo las relaciones de poder desiguales que condicionan la capacidad de autonomía de las personas, presentándose comúnmente hacia las mujeres debido al sistema de género que coloca en un nivel jerárquico de inferioridad a lo femenino.

Inequidades de género: Situaciones injustas por razones de género. En algunos casos estas inequidades pueden ser medidas cuantitativamente, pero en otros no. Ejemplo: las mujeres pagan más que los hombres por un mismo plan de salud privado.

Estereotipos de género: Imágenes y representaciones preconcebidas y prejuiciosas sobre la mujer y el hombre que se comparten y reproducen en una sociedad. Dichos estereotipos no siempre se cumplen, pero sirven de patrón o modelo que influye en el juicio y valoración social que se hace de un hombre o una mujer, y también influyen en la propia imagen y autoestima, limitando las potencialidades de las personas al estimular un comportamiento y reprimir otros, en función de su sexo. Ejemplos: Se tienen asociados a las mujeres expresiones de debilidad, dependencia, sensibilidad, obediencia, afectividad o inseguridad. Mientras que a los hombres se les relaciona con rasgos instrumentales como la fortaleza, independencia, espíritu emprendedor o dominación.

Roles de género: Actividades, conductas, prácticas y costumbres que históricamente se han establecido como las que debe cumplir una mujer o un hombre. No obstante, éstos no necesariamente se cumplen ni son exclusivos de unas y de otros, sino que se realizan de acuerdo con las condiciones en que vive cada persona, sus necesidades, deseos y contextos socioculturales y económicos. Ejemplos: papel de ama de casa relegado a la mujer, mientras que los hombres son los responsables del ingreso económico en el hogar.

Homofobia: Expresión del sistema tradicional de género y de discriminación hacia lo femenino, que se dirige hacia los homosexuales, más común y directamente hacia los hombres que luzcan afeminados, es decir, que se muestren cercanos o reproduciendo los estereotipos y roles de género femeninos. En el caso de las mujeres homosexuales, se manifiesta contra aquellas que no asumen sus roles y estereotipos tradicionales de género.

Determinantes Sociales de la Salud: Son las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud. Esas circunstancias son el resultado de la distribución del dinero, el poder y los recursos a nivel mundial, nacional y local, que depende a su vez de las políticas adoptadas.

Ciudades Cuidadoras: Modelo de ciudad que enfatiza la proximidad entre la vivienda, los equipamientos, los servicios, el comercio, entre otros, de manera que permitan y faciliten la vida cotidiana, los cuidados y la integración social (Bofill, 2008). Es pensar en territorios mixtos y en distancias cortas, que permitan resolver las distintas necesidades de manera cercana, priorizando la movilidad activa y el transporte público y/o colectivo frecuente y accesible. De esta manera trasciende la distinción convencional que hace el urbanismo entre lugares de residencia, de trabajo, de ocio, educación, salud, o comercio. Por ejemplo, los lugares de ocio y los equipamientos son también lugares de trabajo no remunerado y de empleo remunerado para una población mayoritariamente femenina. Si en la ciudad la estructura espacial y la organización del tiempo limita las opciones vitales de las mujeres, ellas tendrán restringida sus posibilidades de autonomía y desarrollo.

La Organización Social del Cuidado se refiere a la configuración que surge del cruce entre las instituciones que regulan y proveen servicios de cuidado, y los modos en que los hogares de distintos

niveles socioeconómicos y sus miembros se benefician de los mismos (Esquivelet al., 2012, p. 27). Considera, al menos, cuatro agentes: las familias, el Estado, el mercado y las redes sociales y comunitarias, develando cómo éstos interactúan y se distribuyen el cuidado de manera interrelacionada, con responsabilidades y niveles de participación diferentes. Aquella configuración no es menor ni se remite al mero reflejo de decisiones individuales o de negociaciones interpersonales; es parte de la división sexual del trabajo, y de un sistema económico y político con marcos normativos y relaciones de poder determinadas (CEPAL, 2022a).

BORRADOR

ANEXO Nº 3 Pauta de evaluación de coherencia de Planes de Promoción de la Salud para Municipios, Comunas y Comunidades Saludables

Aspecto a verificar sobre las actividades	Respuesta: Si / No	¿Por qué? Explique brevemente
Se ha verificado si las actividades seleccionadas para cada componente:		
¿Son coherentes con un cierre de brecha levantado en el diagnóstico?		
¿Las actividades son coherentes y sinérgicas entre sí para lograr un resultado integral?		
¿Son pertinentes al/los entorno/s priorizados?		
¿El diseño de cada actividad tiene la característica de aceptabilidad para el mundo social y cultural en el cual van a ser aplicadas?		
Las actividades seleccionadas para cada componente han sido evaluadas en cuanto a su enfoque multinivel en términos de considerar:		
La incorporación de actividades relacionadas con las personas		
La incorporación de actividades relacionadas con las organizaciones		
La incorporación de actividades relacionadas con la comunidad		
La incorporación de actividades relacionadas con la generación de políticas públicas		
¿Los medios de verificación propuestos en cada actividad permiten mostrar el resultado de cada una?		

ANEXO Nº 4 Instructivo cuestionario de evaluación de efectividad y calidad de actividades de Planes de Promoción de la Salud para Municipios, Comunas y Comunidades Saludables

INSTRUCTIVO

Implementación del cuestionario de calidad y efectividad de las actividades de los Planes de Promoción de la Salud 2025

ANTECEDENTES

El convenio de Promoción de la Salud 2025, establece que una de las metas es la aplicación de instrumentos de calidad y efectividad de las actividades ejecutadas. Se construyó para ello, un cuestionario en línea que recogerá la información necesaria. Se enviará el link del cuestionario el cual estará disponible hasta fines de cada año.

El cuestionario comienza con 3 consultas de antecedentes generales:

- **Región:** Al pinchar el cuadro se despliega un listado para que la persona pueda elegir entre las regiones del país (debe marcar la región en la cual reside)
- **Comuna:** Al pinchar se despliega una lista con las comunas correspondientes a la región elegida. (Marcando la comuna en la cual vive)
- **Fecha:** Al pinchar aparece por defecto el mes actual, y marcado el día en el cual se realiza el cuestionario. En la esquina superior izquierda hay una flecha para desplazarse hacia meses anteriores y seleccionar la fecha en que se realizó la actividad.

Posteriormente en el cuestionario se consulta sobre la actividad en que la persona participó, "**Nombre de la Actividad**" y dado que actualmente los Planes de Promoción de la Salud cuentan con un pool de actividades, se agruparon las actividades para facilitar la elección de las mismas en una lista desplegable.

Continuando hay 3 preguntas en relación con la actividad en la cual la persona participó, siendo éstas las siguientes:

1. **¿Considera que esta actividad contribuye a fomentar el bienestar personal, social y familiar de la población?:** La respuesta tiene 4 alternativas que la persona puede elegir, estas son Mucho, Algo, Poco, Nada.
2. **En general ¿cuál es su nivel de satisfacción con la actividad realizada?:** La respuesta tiene 4 alternativas que la persona puede elegir, estas son Alto, Medio, Bajo, Nada.
3. **¿Recomendaría esta actividad?:** La respuesta tiene 4 alternativas que la persona puede elegir, estas son Mucho, Algo, Poco, Nada.

La 4ta pregunta marca el paso a la segunda parte de cuestionario, la cual está enfocada en las actividades de los Planes de Promoción de la Salud que apuntan a la infraestructura de la comuna. Así, las 3 corresponden a:

4. **¿Conoce infraestructura instalada durante los 2 últimos años en los espacios públicos de su comuna, que ayuden a facilitar la práctica de actividad física o llevar una vida más saludable?:** Las alternativas para esta pregunta son 2, SI y NO.

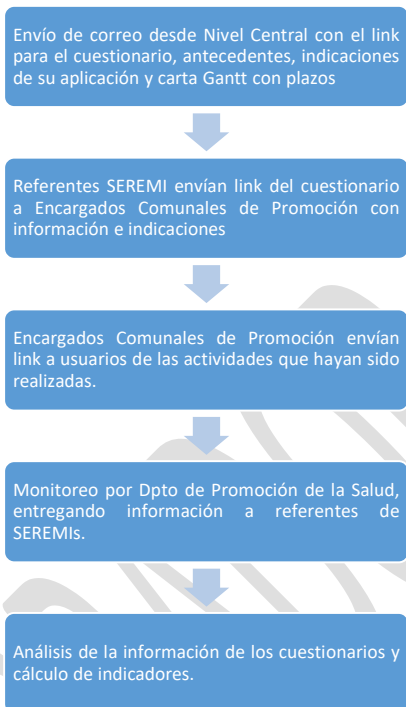
5. **¿Cuál/Cuáles?:** Para esta pregunta las respuestas se muestran en un listado en el cual la persona puede escoger múltiples alternativas. Al igual que en la pregunta de la elección de la actividad, existen muchas actividades que implican infraestructura, por lo cual se agruparon. En el caso de que la alternativa no se encuentre en el listado, la persona puede rellenar el cuadro de “Otro” que se encuentra al final de las alternativas.
6. **¿Cuál es su opinión general sobre este tipo de infraestructura?:** Las alternativas para esta pregunta son 2, Positiva o Negativa.

IMPLEMENTACIÓN

El cuestionario sobre las actividades se implementa en la plataforma SurveyMonkey, y la manera de poder llegar a los y las beneficiarios/as de las actividades de la manera más certera y eficiente, es a través de las/los encargadas/os de Promoción de la Salud de las comunas con Plan MCCS, dado su conocimiento de las actividades desarrolladas, quiénes deberán enviar el link a las personas participantes de las actividades que se hayan realizado durante el año, procurando obtener la mayor cantidad de respuestas posible, y prestar asesoría en el caso de que aparezcan dudas por parte de las personas que responderán el cuestionario.

Durante el período de tiempo establecido para responder el cuestionario, desde nivel central se monitoreará el avance de las respuestas a nivel comunal.

En el siguiente esquema se resumen los pasos para la implementación del cuestionario:



INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO

El cuestionario estará disponible en un enlace proporcionado por el Nivel Central a la SEREMI hasta Diciembre de cada año.

La persona que reciba el link se encontrará inicialmente con el nombre de la encuesta y algunas indicaciones acotadas, entre ellas se destaca que el cuestionario debe ser contestado **solo** por personas que hayan participado de las actividades de Planes Trienales. También se señala que, de haber participado en más de una actividad, debe responder en base **a la última actividad de la cual participó**.

Se debe también insistir en que las respuestas a este cuestionario son de carácter anónimo, dado que no permite individualizar a quienes responden y las respuestas serán analizadas agregadamente y nunca de manera individual.

Se deben llenar los primeros 3 antecedentes: **región, comuna y fecha** (de cuando participó en la actividad). Posterior a eso debe elegir entre una lista desplegable, la **actividad** en la cual participó (al agrupar las actividades, es probable que el nombre exacto de la actividad que realizó no esté como tal en el listado), es por eso que, junto con el link de la encuesta, **se le debe comunicar a la persona que responderá, el nombre al cual corresponde la actividad realizada**.

Por ejemplo, si la persona participó de la actividad “Taller de huertos Saludables en Entorno Comunal”, le corresponderá elegir dentro de la lista desplegable la alternativa “Capacitaciones y Talleres sobre vida saludable”.

Una vez elegida la actividad, las personas deberán responder 3 preguntas simples sobre la actividad seleccionada. Todas las preguntas del cuestionario tienen condición de obligatorias, por lo que no podrá terminar el cuestionario si alguna no tiene respuesta.

En las preguntas 4 a la 6, no se consulta sobre la actividad en la cual participó, si no que sobre la infraestructura que actualmente tiene la comuna, tal como se indica en un párrafo al comienzo de la pregunta N°4. La persona entonces deberá responder si conoce nueva infraestructura instalada en la comuna durante **el año anterior o el actual**, en caso de responder “Si” habilita la siguiente pregunta N°5 cuál o cuáles, donde deberá seleccionar desde una lista desplegable todas las opciones que considere pertinente, para finalmente indicar su opinión con respecto a la misma (positiva o negativa). De no encontrar en la lista desplegable la alternativa de infraestructura, deberá rellenar la casilla “Otro” de la pregunta N°5.

BORRADOR

ANEXO Nº 5 Análisis de contexto para los Planes de Promoción de la Salud para Municipios, Comunas y Comunidades Saludables

En el marco de las orientaciones programáticas para la promoción de salud para el periodo 2025 – 2028, se han establecido como prioridades la selección de un “Entorno” que corresponde a un polígono o área geográfica dentro de la comuna donde centrar las acciones de promoción, las que se sugieren sean enfrentados desde una acción multisectorial. La identificación de estos entornos o polígonos, sus fortalezas, así como las inequidades que se expresan a nivel comunal, las desigualdades, la priorización social y la oferta pública presente a nivel local, son posibles de abordar a través de un ejercicio analítico denominado **Análisis de Contexto**, lo que permitirá seleccionar el o los Entornos (polígonos) donde concentrar las acciones.

Este ejercicio participativo, se requiere sea realizado previo a la programación de actividades del periodo, por lo cual se hace necesario, facilitar orientaciones y sugerencias que permitan la concreción de esta actividad.

Si bien las sugerencias contenidas en este documento están enfocadas a los pasos metodológicos que se deben realizar para un análisis de contexto, se hace presente que no son las únicas herramientas y metodologías que se pueden emplear, para ello recurrimos a las capacidades y experiencias de los equipos de comunales y equipos intersectoriales.

I. DEFINICIÓN:

El análisis de contexto se define como un ejercicio analítico de una situación o conjunto de situaciones, a través del cual, se logra generar conocimiento de una realidad determinada con el fin de articular un cambio.

El ejercicio “permite capturar la interacción entre numerosas variables, impactadas por cambios en procesos altamente dinámicos, como los que tienen lugar en las organizaciones y en las relaciones interpersonales. El caso puede estar representado por un fenómeno, situación o acontecimiento social de interés ubicado en una organización, colectivo, comunidad o país claramente delimitados y puede tratarse de un caso único, representativo o excepcional o casos múltiples (Yin citado en Shakir 2002)” (Colás & Buendía, 1994).

Se debe tomar en cuenta que, al ser un ejercicio analítico, dependerá de las habilidades del o los facilitadores para hacerlo dinámico, así como, la convocatoria de los actores relevantes para lograr un conocimiento y visión más amplia del problema.

El conocimiento generado debe servir como línea base para las acciones que son susceptibles de programar, centrado en los Entornos o polígonos que ofrezcan mayor fortaleza; entendiendo estas como la capacidad de los equipos de promoción de la salud de generar trabajo intersectorial, como la identificación de las dinámicas sociales y liderazgo que se dan al interior de entorno o polígono, la presencia de otros actores institucionales, con los cuales generar alianzas todo estas fortalezas con el fin de abordar las inequidades en forma multisectorial los determinantes sociales relevantes con énfasis en la intersectorialidad.

II. OBJETIVOS:

Como ejercicio, el análisis de contexto es un instrumento que nos permite generar el conocimiento necesario para articular un cambio, desde esta función es posible establecer como fenómeno a analizar la **situación de la comuna en términos de calidad de vida y bienestar** y los elementos objetivos que dan cuenta de esta situación, como son las inequidades presentes, las desigualdades y la oferta pública social, a fin de seleccionar el o los Entornos (área geográfica o polígonos) donde se realizará el plan.

Este ejercicio no puede ser confundido con un diagnóstico participativo, se parte desde un estadio superior, no se requiere salir a recolectar la información como ocurre en un diagnóstico, sino, se debe hacer una reflexión analítica, de los datos existentes; es pararse, detenerse y mirar el contexto, tomar en cuenta otras variables presentes en la comuna, más allá de salud, otras acciones, otros esfuerzos y desde ahí generar acciones conjuntas.

Se han establecido como objetivos del análisis de contexto:

- **Conocer las brechas de inequidades en salud y bienestar existente al interior de la comuna.**
- **Determinar los factores principales que generan las inequidades de salud y bienestar en la población.**
- **Identificar la oferta pública de protección social y aporte a la calidad de vida ejecutándose en la comuna**
- **Seleccionar el o los Entornos (área geográfica o polígonos) donde priorizar las intervenciones del Plan de promoción de la salud**

Se hace presente, que es posible que a nivel local se establezca otro objetivo adicional como la articulación de red intersectorial, u otro.

III. FUENTE DE INFORMACIÓN:

El ejercicio de análisis de contexto requiere de reunir la información que sirve de insumo. Aquí es validar la información cuantitativa que se encuentra disponible tanto a nivel local como regional y nacional, que da cuenta de las condiciones de vida, los índices que miden diferentes aspectos desde habitabilidad, prioridad social, estadísticas de empleo, escolarización, programas de inversión social, etc.

El acceder a esta información y disponer de ella al momento del análisis de contexto favorece el resultado del ejercicio

La validez de la información cuantitativa debe ser confrontada con la información cualitativa, ésta es indispensable de extraer a través de socializar el ejercicio, por lo cual se recomienda hacer partícipe de este ejercicio al intersector presente en la comuna y a las y los representantes de las organizaciones sociales (se recomienda un grupo de 20 a 25 personas)

IV. PARTICIPANTES.

El número de participantes puede ser variable y dependerá del manejo de la metodología, pero lo que se sugiere que no ocurra es realizarlo en grupos muy pequeños, o entre cuatro paredes.

Al momento de convocar al intersector se requiere seducirlos, entusiasmarlos e involucrarlos en el ejercicio. Desde el punto de vista de los determinantes sociales de la salud, debemos abordar el ejercicio más allá de los indicadores de salud, sino desde la calidad de vida, la vivienda, la participación, el empleo, la educación, la seguridad pública, la atención de menores, adultos mayores; por lo tanto nuestro intersector es todo aquel que interviene en el desarrollo de la comuna, desde el municipio, bomberos, carabineros, instituciones sectoriales, educativas, de fomento productivo y empleo entre otros.

Es deseable, para la realización del ejercicio de Análisis de contexto y para la elaboración del plan comunal de promoción la existencia de un comité intersectorial comunal de promoción de la salud donde los participantes sociales deben, en lo posible, ser representativos de las organizaciones territoriales y funcionales, desde las organizaciones estudiantiles y juveniles, hasta los adultos mayores, sindicatos, centros de padres y madres etc.

La validez y confiabilidad del aporte cualitativo, está dado por el nivel de compromiso, la experiencia y representatividad del/la dirigente convocado/a, manteniendo las dinámicas y realidades locales.

V. METODOLOGÍA:

La metodología propuesta es participativa, centrada en un trabajo grupal, con una guía técnica anticipatoria y preguntas facilitadoras que permitan una reflexión colectiva.

Con el fin de desarrollar este análisis de contexto, se requiere convocar a los participantes a un encuentro jornada que puede extenderse de 6 a 8 horas o dividirse en dos minijornadas de 4 horas (no muy distanciadas una de la otra).

Se recomienda preparar el encuentro con el equipo gestor de promoción de la salud, que presente los datos disponibles, oriente la reflexión, facilite la discusión y redacte las conclusiones.

Al momento del trabajo grupal, se deberá procurar que los grupos sean diversos en el rol de los participantes, la función y jerarquía. Es importante permitir la democratización de la discusión y la regulación de ésta por los propios participantes, nombrando secretario/a y moderador/a entre estos.

Se propone una secuencia de la reflexión grupal, con el fin de ir organizando los productos y estableciendo el nuevo contexto.

Luego de convocar a los diferentes actores, se sugiere como base el comité intersectorial de promoción, procure un lugar cómodo y explique la finalidad y los objetivos del trabajo.

Paso 1:

Orientar la reflexión hacia el análisis de la situación de la comuna en términos de calidad de vida.

Preguntas facilitadoras:

- ¿Cuál es la situación de calidad de vida de su comuna?
- ¿Cuáles son los principales factores o condiciones sociales y medio –ambientales que influyen en la calidad de vida?

- ¿A quiénes afecta más (grupos específicos como niños, mujeres, jóvenes, personas mayores, migrantes, pueblos indígenas, entre otros)?
- ¿Qué sector es más afectado (villa, barrio, población)?

Producto:

Confeccionar un listado de problemas que afectan la calidad de vida, a quienes afecta y que lugares son los más afectados:

Factores o condiciones	Grupo más afectados	Sector geográfico

Se recomienda destinar 1.5 horas en este paso

Paso 2:

Con los insumos del paso 1.

Orientar la reflexión hacia las causas de esta situación.
Pregunta facilitadora:

¿Cuáles son los factores o condiciones individuales, sociales y medio - ambientales que promueven esta situación?

Producto:

Construir un listado de factores o causas

- 1.
- 2.
3. ...

Se recomienda destinar 1 hora para este paso

Paso 3:

Disponer de uno o más planos o mapas comunales. (son los mismos mapas que se utilizan en la gestión del centro de salud para sectorizar)

Identificar en un mapa las inequidades presentes en la comuna, a partir de los productos del paso 1 y 2.

Orientar el trabajo hacia:

- Identificar diferencias entre barrios, villas, poblaciones y localidades de acuerdo a la información disponible.
- Identificar acceso a servicios básicos
- Deserción escolar; años de escolarización
- Situación laboral, cesantía, mujeres jefas de hogar
- Acceso a los servicios de salud

Se recomienda destinar 1.5 horas para este paso

Paso 5:

Identificar la oferta pública presente en su comuna y actores relevantes

Preguntas facilitadoras:

- ¿Conoce los programas sociales que se ejecutan en su comuna? (entendiendo como programa social: aquella acción de una institución del estado, que destina o moviliza recursos de cualquier tipo, a fin de favorecer a un grupo determinado, en un territorio determinado).
- ¿Conoce los organismos responsables de ejecutarlos?
- ¿Identifica a los beneficiarios de estos programas?
- Identifique las zonas, áreas o sectores, donde se ejecutan mayoritariamente o vive la población beneficiaria.

Producto:

- Cuadro de programas, sectores y tipo de población beneficiaria
- Listado de actores relevantes (organizaciones y/o individuos)
- Confección de matriz de acción intersectorial (se anexa matriz)

Matriz paso 4						
Nombre Programa Social	Tipo de intervención	Población Beneficiaria	Sector donde está presente	Institución responsable	Años de Duración	Año de ejecución
EJ: Programa 4 a 7	proporciona a mujeres responsables de niños y niñas, de 6 a 13 años, acceso al servicio de cuidado, en apoyo a su participación en el mercado laboral	Mujeres trabajadoras con niños de 6 a 13 años a su cuidado	Sector Barrio Oriente, Sede Social; Villa Santa Berta y Santa Julia	Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género	3 años	segundo año

Se recomienda destinar 1.5 horas para este paso.

Cerrar la actividad agradeciendo la participación, es trascendental comprometerse a socializar los resultados una vez que el equipo gestor redacte el informe final.

Si es propicio, articule una nueva reunión intersectorial con el fin de ir compartiendo experiencias, tareas y esfuerzos

La presente secuencia metodológica, pretende ser una contribución a la tarea de análisis de contexto, ejercicio que permitirá marcar la línea base de la información para enfrentar la promoción de salud, desde la mirada de Determinantes Sociales. La habilidad de los equipos de promoción permitirá integrar este ejercicio y los dos determinantes seleccionados en los planes comunales de promoción.

BORRADOR

ANEXO Nº 6 Indicadores

La frecuencia de medición de estos indicadores es anual.

N°	Enunciado	Fórmula de cálculo	Unidad de medida	Nivel	Fuente
1	Personas que acceden a entornos saludables para la alimentación saludable	N° habitantes del entorno (polígono) que cumple con acciones o recursos comunitarios para la alimentación saludable	Personas	Comunal	MIDAS
2	Personas que acceden a entornos saludables para la actividad física	N° habitantes del entorno (polígono) que cumple acciones o recursos comunitarios para la actividad física	Personas	Comunal	MIDAS
3	Personas que acceden a entornos saludables para la cohesión social	N° habitantes del entorno (polígono) que cumple acciones o recursos comunitarios para la cohesión social	Personas	Comunal	MIDAS
4	Personas que acceden a entornos saludables	N° habitantes del entorno (polígono) que cumple acciones o recursos comunitarios en alimentación saludable, actividad física y cohesión social	Personas	Comunal	MIDAS
5	Entornos que cuentan con recursos comunitarios que promueven alimentación saludable, actividad física y cohesión social	N° de Entornos que cuentan con acciones y/o recursos comunitarios que promueven alimentación saludable, actividad física y cohesión social	Polígonos/ Entornos	Comunal	MIDAS
6	Porcentaje de entornos (polígonos) que cumplen con contar con acciones y/o recursos comunitarios en las 3 dimensiones	N° de entornos (polígonos) que cumplen con contar con acciones y/o recursos comunitarios en las 3 dimensiones/N° total de entornos (polígonos) identificados*100	Polígonos/ Entornos	Comunal	MIDAS
7	Porcentaje de población de las comunas con Planes de Promoción de la Salud que ejecutan actividades en los 4 componentes respecto del total de población de comunas con Planes MCCA	Población del/los entornos (polígonos) de las comunas con Planes de Promoción de la Salud que ejecuten actividades en los 4 componentes en el año t/ Total de Población de comunas con Planes MCCA en año t *100	Polígonos/ Entornos	Comunal	MIDAS

8	Proporción de activos comunitarios en salud	N° de recursos comunitarios identificados como activos comunitarios/N° total de recursos comunitarios	Recursos comunitarios	Comunal	MIDAS
9	Comunas que cuentan con entornos (polígonos) saludables	N° de Comunas que cuentan con entornos (polígonos) saludables (cumplen con contar con acciones y/o recursos comunitarios en las 3 dimensiones)	Comunas	Comunal y Regional	MIDAS
10	Porcentaje anual de comunas que incorporan las dimensiones de alimentación saludable actividad física y cohesión social en sus Planes MCCS (total y desglosado por cada una de las tres dimensiones)	N° de comunas que incorporan las dimensiones de alimentación saludable y actividad física y cohesión social en sus Planes en año t/ N° total de comunas con "Planes en año t" *100	Comunas	Comunal y Regional	MIDAS
11	Porcentaje de comunas con Planes de Promoción de la Salud con cumplimiento de actividades mayor al 90% respecto del total de Planes (meta 1)	N° de comunas con Planes de Promoción de la Salud con cumplimiento técnico de actividades mayor al 90% en año t/ N° Total de Planes formulados en año t *100	Comunas	Comunal y Regional	MIDAS
12	Porcentaje de comunas con Planes de Promoción de la Salud con cumplimiento financiero mayor al 90% respecto del total de Planes (meta 2)	N° de comunas con Planes de Promoción de la Salud con cumplimiento de ejecución financiera mayor al 90% en año t/ N° Total de Planes formulados en año t *100	Comunas	Comunal y Regional	MIDAS
13	N° de comunas con actividades ejecutadas (en total y desglosado por cada componente)	N° de comunas con actividades ejecutadas (en total y desglosado por cada componente)	Comunas	Comunal y Regional	MIDAS
14	N° de comunas que registra la ejecución en MIDAS (meta 3)	N° de comunas que registra la ejecución en MIDAS	Comunas	Comunal y Regional	MIDAS
15	Número de comunas que cumple con Equipo gestor y comité intersectorial conformado y/o actualizado, oficializados por acto administrativo correspondiente. (meta 5)	Número de comunas que cumple con Equipo gestor y comité intersectorial conformado y/o actualizado, oficializados por acto administrativo correspondiente.	Comunas	Comunal y Regional	MIDAS

16	N° de comunas que cumple con al menos el 50% del cronograma planificado para todas las actividades (meta 7)	N° de comunas que cumple con al menos el 50% del cronograma planificado para todas las actividades.	Comunas	Comunal y Regional	MIDAS
17	N° de comunas que aplica instrumentos de evaluación de actividades (meta 4)	N° de comunas que aplica instrumentos de evaluación de actividades especificados por el Ministerio de Salud	Comunas	Comunal y Regional	Informe SEREMI
18	N° de comunas con envío de rendiciones financieras mensuales dentro de los plazos establecidos en el convenio (meta 6)	N° de comunas con envío de rendiciones financieras mensuales dentro de los plazos establecidos en el convenio	Comunas	Comunal y Regional	SISREC
19	Porcentaje de comunas que vinculan los Planes de Promoción de la Salud MCCA con sus instrumentos de planificación local (PLADECO, PADEM, Planos reguladores, etc.)	N° de comunas que vinculan los Planes MCCA con sus instrumentos de planificación local en año t/ N° total de comunas con Planes MCCA en año t *100	Comunas	Comunal y Regional	MIDAS
20	Porcentaje de comunas con regulaciones municipales saludables publicadas en el año t	N° de comunas que cuentan con regulaciones municipales saludables en año t/ N° total de comunas con Planes de Promoción de la Salud MCCA en año t *100	Comunas	Comunal y Regional	MIDAS

ANEXO N°7 Matriz de actividades de Planes de Promoción de la salud para Municipios, Comunas y Comunidades saludables

NOMBRE y N° ID	OBJETIVO	DEFINICIÓN	RECOMENDACIONES	COMPONENTE	AGRUPACIÓN/ NIVEL PRINCIPAL
Regulaciones locales de Promoción de la Salud mediante un proceso participativo. ID_1	Elaborar participativamente regulaciones locales saludables para acceder y/o incentivar el acceso a entornos saludables	Consiste en un proceso participativo en que se incluye a la comunidad en la fase de formulación, difusión y de aplicación de la regulación en promoción de la salud (Ordenanza, Decreto o Reglamento) Ejemplos: Autorización de nuevos espacios para ferias libres. Aumento de puntos de venta de alimentos frescos y naturales (verdulerías, pescaderías, mercados, kioscos de frutas o similares). Regulaciones para la disminución en un 50% de patentes de locales especializados en alimentos “altos en”. Regulaciones para la prohibición de venta de alimentos “altos en” en el entorno escolar y establecimientos de salud. Regulaciones para que las instalaciones de venta de alimentos, cuenten con al menos un 20% de oferta de alimentos saludables. Normativas educacionales para aumentar la práctica regular de actividad física, resguardando un mínimo de 60 minutos diarios al día para toda la población escolar. Regulaciones de publicidad de alimentos no saludables en espacios de uso público (escuelas, plazas, plazoletas, costaneras, senderos, estadios, etc.) Regulaciones que prohíban el consumo de tabaco en parques, plazas saludables y lugares de recreación destinados a niños y niñas. Formulación e implementación de regulaciones locales de Promoción de la Salud mediante un proceso participativo. Consiste en un proceso participativo en que se incluye a la comunidad en la fase de formulación, difusión y de aplicación de la regulación en promoción de la salud (Ordenanza, Decreto o Reglamento) Ejemplos: Regulaciones para la disminución en un 50% de patentes de locales especializados en alimentos “altos en”. Regulaciones para la prohibición de venta de alimentos “altos en” en el entorno escolar y establecimientos de salud. Regulaciones para que las instalaciones de venta de alimentos cuenten con al menos un 20% de oferta de alimentos saludables. Normativas educacionales para aumentar la práctica regular de actividad física,	La participación de la comunidad en todo el proceso de formulación y aplicación de la Regulación Municipal permite que sea ésta quien proponga ideas y sugerencias y, además, controle y vigile la aplicación de la Regulación. Para la construcción de la Regulación el Equipo Gestor debe ser el responsable de realizar la abogacía correspondiente con Concejales, Alcalde y el intersector, además de diseñar un plan de trabajo con los actores comunitarios para el diseño de la regulación y su posterior implementación.	Regulaciones y políticas	Regular participativamente para disponibilidad y/o acceso Nivel Políticas públicas

NOMBRE y N° ID	OBJETIVO	DEFINICIÓN	RECOMENDACIONES	COMPONENTE	AGRUPACIÓN/ NIVEL PRINCIPAL
		resguardando un mínimo de 60 minutos diarios al día para toda la población escolar. Regulaciones de publicidad de alimentos no saludables en espacios de uso público (escuelas, plazas, plazoletas, costaneras, senderos, estadios, etc.) Regulaciones que prohíban el consumo de tabaco en parques, plazas saludables y lugares de recreación destinados a niños y niñas. Regular autorizaciones o permisos para la construcción de ciclo-vías y sendas peatonales, espacios públicos, plazas y parques, senderos, miradores, etc. Regular autorizaciones o permisos para la realización de actividades masivas que necesiten cierre temporal de calles, plazas, desplazamientos masivos, entre otros.			

NOMBRE Y N° ID	OBJETIVO	DEFINICIÓN	RECOMENDACIONES	COMPONENTE	AGRUPACIÓN/ NIVEL PRINCIPAL
Plan de gestión y uso de espacios públicos y recursos comunitarios para la Promoción de la Salud y el bienestar con foco en equidad. ID_115	Elaborar regulaciones locales saludables para acceder y/o incentivar el acceso a entornos saludables.	Elaboración de un Plan de gestión y uso de espacios públicos y recursos comunitarios, que se traduce en un plan, aprobado por acto administrativo, que señala cómo se utilizarán ciertos espacios públicos mediante acciones de actividad física, alimentación saludable, salud mental y/o cohesión social financiadas por el Programa, el Municipio o por el intersector. Ejemplos: Oficializar la oferta de programas permanentes asociadas a espacios públicos e incluir un calendario de uso de aquellos recintos. Implementar programas que fomenten la facilitación y sostenimiento de la caminata, uso de bicicleta y uso de transporte público para viajes a los EE.(por ejemplo ruta segura) Implementación de programa de cierre de vía pública para el aumento de la práctica deportiva a través del juego incorporando a la comunidad y al municipio.	Para la elaboración del plan de gestión y uso de espacios públicos, se recomienda partir con la elaboración de un catastro de espacios públicos y recursos comunitarios para actividades de promoción de salud y bienestar a nivel comunal o del entorno/s (polígono/s) que será intervenido, incluir la identificación de barreras de acceso para determinados grupos de la población y en base a aquello plantear soluciones para aumentar acceso, y disponibilidad del grupo de la población identificado y priorizado. Es importante que este plan se formalice administrativamente de la forma que estime conveniente cada Municipalidad, puede ser a través de un Decreto Alcaldicio, una Ordenanza Municipal u otra forma como un Oficio. Se destaca que es necesario que se realice una amplia difusión del plan de uso de espacios públicos. Es recomendable establecer el período de vigencia del plan.	Regulaciones y políticas	Regular para disponibilidad y/o acceso Nivel Políticas públicas
Oficializar Sala de Promoción de la Salud. ID_136	Elaborar regulaciones locales saludables para acceder y/o incentivar el acceso a entornos saludables	Consiste en realizar un acto administrativo que permita identificar la sala de promoción de la salud como un espacio oficial donde se realizan gestiones para coordinar intervenciones de promoción de la salud ya sea de forma intersectorial y/o con la comunidad. (No corresponde a la implementación de la sala)	Se recomienda incluir en actividades de tipo comunicacional la difusión y visibilización de este espacio.	Regulaciones y políticas	Regular para disponibilidad y/o acceso Nivel Políticas públicas

NOMBRE Y N° ID	OBJETIVO	DEFINICIÓN	RECOMENDACIONES	COMPONENTE	AGRUPACIÓN/ NIVEL PRINCIPAL
Instalación de equipamiento para la actividad física de niños, niñas y adolescentes en espacios de uso público. ID_54	Habilitar nuevos espacios de juego en espacios públicos existentes para incentivar su uso en entorno comunal	Instalar equipamiento con diseño inclusivo como juegos infantiles, circuitos de máquinas de ejercicios infantiles, pumpruck, circuitos bicicleta, skatepark, u otros en espacios públicos como plazas, parques, establecimientos educacionales públicos municipales. En el caso de los juegos infantiles se busca que sea un área de juego que estimule la formación motora, la participación social, la vinculación con el medio y la promoción del juego autónomo. En el caso de espacios como plazas o parques el diseño del área de juego debe asegurar que se promueva el desarrollo motor (columpios, barras, trepadoras, etc.), la interacción social y el juego autónomo. En el caso de establecimientos educacionales públicos, en el diseño es importante incluir juegos que requieran la colaboración de varios niños, incentivando la socialización y el compañerismo en el espacio educativo.	Se recomienda efectuar la actividad en base al diagnóstico y en coordinación con el área de desarrollo social, DIDECO, SECPLAC, deportes, medio ambiente y otros. Asimismo, desde el inicio se recomienda incorporar aportaciones comunitarias que pueden ser recursos de distinta índole o responsabilidades para la instalación o el mantenimiento a largo plazo. Considerar un plan de seguimiento de la instalación de juegos infantiles, es decir, establecer un plan para monitorear el uso y el estado de los juegos instalados, realizando evaluaciones periódicas de los resultados en la comunidad como uso y aceptabilidad. Es importante determinar responsables del espacio que velen por su mantenimiento y dinamización. Para la instalación de juegos infantiles en establecimientos educacionales públicos, se recomienda efectuar la actividad en base al diagnóstico y en coordinación con el área de educación. Realizar consulta con la comunidad educativa: Describir cómo se involucrará a la comunidad escolar (padres, profesores, estudiantes) en la selección y planificación de los juegos, por ejemplo, a través de talleres y reuniones con los docentes y los padres para integrar sus opiniones y sugerencias sobre el diseño del área de juegos. En esta instancia es importante explicar cómo los juegos fomentarán la interacción social, promoviendo la cooperación, el trabajo en equipo y el desarrollo de habilidades sociales.	Instalación de espacios	Habilitar para disponibilizar Nivel Comunitario

NOMBRE Y N° ID	OBJETIVO	DEFINICIÓN	RECOMENDACIONES	COMPONENTE	AGRUPACIÓN/ NIVEL PRINCIPAL
Implementar Centro/Sala de Promoción de la Salud. ID_1005	Habilitar un espacio físico existente que permita al equipo gestor e intersectorial, analizar e interpretar información de promoción de la salud de forma permanente. Además de generar un espacio de intercambio con la comunidad.	Consiste en la adaptación de un espacio físico en el que se gestiona, se analizan y se interpretan de forma permanente y sistemática datos de salud y calidad de vida. Asimismo, la sala se considera como un espacio físico de intercambio con la comunidad, en la que se realizan actividades de participación u otras acciones de promoción de la salud como talleres permanentes de actividad física, entre otros.	Se sugiere coordinar la actividad con la oficialización del espacio (Actividad ID 136) y asegurar su visibilización a través de estrategias comunicacionales. Identificar las necesidades técnicas para análisis de datos, con apoyo de TIC municipales y colaboración de SECPLA o DESAM. Detallar cómo se coordinará el trabajo entre sectores municipales e intersector (salud, educación, deporte, etc.) para un análisis de datos integral. Implementar un sistema de seguimiento para evaluar los resultados del espacio y los indicadores de impacto. Documentar los recursos asignados, incluyendo tecnología y mantenimiento, y definir responsables de la operación y sostenibilidad. Registrar las contribuciones de la comunidad o instituciones locales para la gestión del espacio.	Instalación de espacios	Habilitar para participar, diagnosticar y evaluar Nivel Comunitario

NOMBRE Y N° ID	OBJETIVO	DEFINICIÓN	RECOMENDACIONES	COMPONENTE	AGRUPACIÓN/ NIVEL PRINCIPAL
Mejoramiento de espacios para la actividad física. ID_49	Optimizar espacios públicos existentes en la comuna para incentivar su uso por parte de la población	Realizar mejoras a espacios públicos ya creados para la actividad física y recreación, y que cuentan con infraestructura básica para ello, por ejemplo instalar techumbre o toldos, casilleros para facilitar la seguridad de pertenencias, instalación de mejores luminarias, instalación de basureros, reparación o la instalación de pisos o áreas verdes (Instalación de pasto sintético, piso de caucho u otro, suministro e instalación de maicillo compactado, desmalezado, paisajismo), instalar señalética que oriente sobre el uso correcto de máquinas de ejercicios o infraestructura instalada por el programa que mejore el acceso, pintura, cierre perimetral, adaptaciones para acceso universal, reparaciones de arcos en canchas u otros, entre otros.	Dado que esta actividad no considera la instalación de bebederos, puede ser complementada con la actividad ID 53 de Bebederos. En los casos que se contemplan intervenciones integrales en el espacio, se recomienda complementar con otras actividades del componente como la actividad ID 74, Respecto de la señalética, se recomienda incorporar diseño inclusivo, por ejemplo recomienda considerar una protección a la exposición solar y climática (mica y/o toldo), también, idealmente utilizar más gráficos y/o ilustraciones que palabras, en este caso se requiere que sus letras y altura sean visibles para todos los grupos. El cartel debe tener nombre del ejercicio y los músculos trabajados	Instalación de espacios	Optimizar para disponibilizar Nivel Comunitario

NOMBRE Y N° ID	OBJETIVO	DEFINICIÓN	RECOMENDACIONES	COMPONENTE	AGRUPACIÓN/ NIVEL PRINCIPAL
Puntos de venta de alimentos frescos y naturales (por ejemplo, ferias libres). ID 11.	Optimizar espacios públicos existentes para mejorar el acceso a la alimentación saludable en el entorno comunal.	Instalación y mejoramiento de equipamiento y/o mobiliario permanente para la venta de frutas, verduras, legumbres, pescados y otros alimentos recomendados por las Guías Alimentarias en el entorno comunal. Por ejemplo, autorizando nuevos espacios y mejorando la infraestructura de ferias libres instaladas en calles o en instituciones públicas. Por ejemplo: - Instalación de nuevos espacios para ferias libres. - Instalación de puntos de venta de alimentos frescos y naturales (verdulerías, pescaderías, mercados, kioscos de frutas o similares). - Reemplazo de fierros u otros materiales para a estructura de toldos y carpas. - Mobiliario para la exposición de productos, letreros para la presentación de precios y señaléticas para expendedores de alimentos naturales. - Contenedores de basura, entre otros. - Organización de ferias y mercados de pequeños productores de canal alimentario agro pesquero tradicional (al menos 4 eventos anuales), para el expendio de alimentos.	Se recomienda conversar con la comunidad de feriantes para instalar puestos de feria en espacios públicos con alta afluencia de público, para eventos comunales o en las afueras de instituciones públicas para aumentar la disponibilidad de la venta de alimentación saludable.	Instalación de espacios	Optimizar para acceso Nivel Comunitario

NOMBRE Y N° ID	OBJETIVO	DEFINICIÓN	RECOMENDACIONES	COMPONENTE	AGRUPACIÓN/ NIVEL PRINCIPAL
Puntos de hidratación en espacios públicos. ID_53	Habilitar espacios públicos existentes para mejorar el acceso al consumo de agua en el entorno comunal.	Instalar puntos de hidratación con diseño inclusivo que sean de libre consumo, de fácil acceso y visibles, como por ejemplo bebederos de agua potable.	Se recomienda que el diseño inclusivo considere doble altura adultos y niños y personas con movilidad reducida. Se recomienda la instalación de bebederos que permitan la recarga de botellas de uso individual.	Instalación de espacios	Habilitar para disponibilidad Nivel Comunitario
Habilitación de Salas de lactancia materna en espacios públicos. ID_28	Habilitación de espacios públicos existentes para incentivar su uso en cuanto a lactancia materna en entorno educacional	Habilitación de un espacio existente como sala de lactancia materna en espacios públicos (servicios públicos, dependencias municipales, centros de salud municipales, entre otros municipales). Considera la adquisición de mobiliario.	Se recomienda la adquisición de bienes según la Guía de Implementación de Salas de Lactancia Materna a Nivel Local Chile Crece Contigo. (http://www.crececontigo.gob.cl/wp-content/uploads/2018/01/Guia-de-implementacion-sala-de-lactancia-2017.pdf)	Instalación de espacios	Habilitar para disponibilidad Nivel Comunitario
Estacionamientos de bicicletas en espacios públicos. ID_50	Habilitación de espacios públicos existentes para incentivar el transporte activo en el entorno comunal	Instalar estacionamiento para bicicletas que permitan implementar o recuperar espacios públicos para la práctica de la actividad física de la comunidad y el transporte activo.	Se recomienda la utilización del Documento de MINVU "Movilidad Urbana. Vol 1. Biciestacionamientos en el espacio público" disponible en https://www.minvu.cl/wp-content/uploads/MINVU_BICIESTACIONAMIENTOS%20EN%20EL%20ESPACIO%20PUBLICO%20ACBLICO_Libro%20completo_baja_18105758473035656.pdf	Instalación de espacios	Habilitar para disponibilidad Nivel Comunitario

NOMBRE Y N° ID	OBJETIVO	DEFINICIÓN	RECOMENDACIONES	COMPONENTE	AGRUPACIÓN/ NIVEL PRINCIPAL
Instalación de equipamiento y mobiliario para la actividad física para mayores de 18 años en espacios públicos. ID_52	Habilitación de espacios públicos existentes para incentivar su uso en el entorno comunal	Implementar equipamiento y mobiliario para la actividad física de mayores de 18 años con diseño inclusivo, por ejemplo, circuito de máquinas de ejercicios, circuitos de calistenia, muro de escalada, entre otros.	Se recomienda hacer esta actividad en base al diagnóstico y en coordinación con el área de desarrollo social, DIDECO, SECPLAC, deportes, medio ambiente y otros. Pensar en zonas con mayor afluencia de usuarios para mantener un cuidado por parte del municipio.	Instalación de espacios	Habilitar para disponibilidad Nivel Comunitario
Creación de Huertos o invernaderos comunitarios. ID_17	Habilitar nuevos espacios para mejorar el acceso a la alimentación saludable, a actividades de educación para la salud en entorno comunal	Creación de huertos o invernaderos en espacios municipales o públicos para que las personas de la comuna puedan cultivar frutas, verduras y plantas medicinales para su consumo. Se pueden adquirir herramientas para preparación de suelo, estructuras para hacer huerto, semillas, entre otros. La horticultura o cultivo de los huertos, como también la jardinería, y sus beneficios en la salud de las personas han sido objeto de estudio en los últimos años, existiendo evidencia creciente de sus efectos positivos a nivel de la salud física, mental y social. Esta estrategia además conlleva el propósito de vincular a las comunidades, con el fin de generar redes de apoyo y fortalecimiento de vínculos eliminando los riesgos de soledad y aislamiento presente en niños, jóvenes, mujeres y adultos mayores. Se recomienda que los huertos sean reconocidos dentro de la red comunitaria del CESFAM u otros entornos institucionales del territorio de manera permanente para fortalecer el acceso a prestaciones sociales y de salud u otras necesidades.	Para constituirse en una plataforma de generación de lazos y redes de apoyo deben mantenerse de manera permanente, integrándolos a redes comunitarias con apoyo institucional del territorio. Estos espacios se pueden complementar con infraestructura afín como pérgolas, muros verdes, entre otros. Es clave una buena planificación y diseño del huerto/invernadero con la comunidad vinculada a un sector que tenga una JVV. La selección del espacio adecuado en la escuela con acceso a riego y sombra y que no quede muy expuesta a perros, pelotas o pisadas. El diseño del huerto/invernadero debe ser considerando el clima y el suelo local, con una elaboración de un calendario de siembra y cosecha. Es recomendable programar capacitación y para dirigentes y comunidad participante sobre técnicas de jardinería y agricultura.	Instalación de espacios	Habilitar para acceso Nivel Comunitario

NOMBRE y N° ID	OBJETIVO	DEFINICIÓN	RECOMENDACIONES	COMPONENTE	AGRUPACIÓN/ NIVEL PRINCIPAL
			Idealmente charlas sobre la importancia de una alimentación saludable y sostenible. Visitas a huertos comunitarios o granjas locales para aprender de experiencias prácticas.		

NOMBRE Y N° ID	OBJETIVO	DEFINICIÓN	RECOMENDACIONES	COMPONENTE	AGRUPACIÓN/ NIVEL PRINCIPAL
Programas permanentes de actividad física a nivel comunal y/o programa de transporte activo escolar. ID_74	Implementar acciones permanentes que aumenten el acceso a la actividad física en el entorno comunal	Implementar Programas permanentes de actividad física en espacios públicos comunales (plazas, gimnasios municipales, entre otros) considerando la adquisición de implementos deportivos y/o monitores de actividad física. Ejemplos: Instalación de pausas activas permanentes en entornos laborales Implementar Talleres de actividad física con enfoque de curso de vida en entorno comunal de actividad física según grupos etarios en el entorno comunal de acuerdo a los intereses deportivos y recreativos de los participantes locales, resguardando la calidad técnica del mismo. Por ejemplos: liga deportiva de fútbol, basketball, volleyball, handball, atletismo, talleres de baile, acondicionamiento físico, yoga, Oi gong o chi, chi kung, entrenamiento en atención plena (mindfulness) Taichi, baños de naturaleza, biodanza, danzaterapia, trekking, rutas seguras para adultos mayores, TRX, pilates, entre otros. La práctica de la atención plena (mindfulness) es una herramienta para contrarrestar los efectos negativos del estado de hiperconexión digital en el que se encuentran insertos actualmente, niños, jóvenes y adultos. El entrenamiento en atención plena puede disminuir el estrés al enseñar a la mente a prestar atención al presente, generando disminución de los pensamientos rumiativos acerca del pasado y el futuro. La rumiación mental consume recursos atencionales, disminuyendo la capacidad de pensar y de tomar una decisión clara en condiciones estresantes y contribuye a gatillar y mantener activo un sentido de amenaza por la cual diversos tipos de malestar emocional en vez de ser transitorios, persisten. También se considera en esta actividad los programas de transporte activo escolar o rutas seguras o saludables para adultos mayores. Transporte activo escolar se refiere a una iniciativa que promueve el desplazamiento de los estudiantes desde y hacia sus establecimientos educativos mediante modos de transporte activos, como caminar, andar en bicicleta, patinar u otros medios no motorizados. Este programa busca incentivar hábitos saludables, fomentar la actividad física, mejorar la calidad del aire y reducir el tráfico vehicular alrededor de las escuelas. Estos programas son una estrategia integral que combina los esfuerzos en promoción de la salud, planificación urbana, seguridad ciudadana, tránsito y educación para construir comunidades educativas más saludables y sostenibles.	Se recomienda llevar registro de la población beneficiada en el caso de talleres. Importante considerar cómo se ha consultado a la comunidad para identificar los intereses deportivos y recreativos, garantizando la inclusión de distintos grupos etarios (niños, jóvenes, adultos, adultos mayores), a fin de tener buena adherencia en los programas. En el caso de implementos deportivos se recomienda la adquisición de pelotas deportivas (basketball, volleyball, fútbol, handball), petos, conos, aros, mallas, colchonetas. En el caso de implementos para la preparación física se recomienda la adquisición de : bandas elásticas, pesas rusas, mancuernas, soga para saltar, pelotas medicinales, pelotas de pilates, colchonetas, mat de yoga, cono, escalera de coordinación, lentejas, cajones pliométricos, step, bandas elásticas, TRX, aros. El entrenamiento en ejercicio de atención plena (mindfulness) pueden ser incorporados dentro de talleres de actividad física, es decir se deben integrar a talleres orientados a generar movimiento. Pueden incorporarse al inicio, durante o al final de talleres de actividad física. En los casos de transporte activo escolar se recomienda utilizar Guía de Transporte Activo Escolar del MINSAL y es relevante que sea dirigida desde una coordinación municipal con un establecimiento educativo que adhiera a poder implementar la guía, dando todas las facilidades para poder	Instalación de espacios	Implementar para acceso Nivel Comunitario

NOMBRE y N° ID	OBJETIVO	DEFINICIÓN	RECOMENDACIONES	COMPONENTE	AGRUPACIÓN/ NIVEL PRINCIPAL
			generar las acciones correspondientes. Se recomienda que los profesionales a cargo de implementar consideren recursos para contratación de monitores e implementos		

NOMBRE Y N° ID	OBJETIVO	DEFINICIÓN	RECOMENDACIONES	COMPONENTE	AGRUPACIÓN/ NIVEL PRINCIPAL
Planificación participativa plan de promoción. ID_1003	Planificar participativamente las actividades del Plan de promoción de la salud.	Consiste en efectuar la planificación de actividades incluidas en el Plan de Promoción de la Salud de manera participativa una vez priorizado el o los entornos a intervenir. Asimismo, pueden efectuarse ajustes a la planificación de manera participativa. Para este efecto, se realizarán acciones en el marco de la instancia de Comité Intersectorial incorporando a la comunidad, que realice el ejercicio de análisis de contexto y planificación del plan, así como monitoreo y de seguimiento a las actividades planificadas. Corresponde a reuniones en distintos formatos con la comunidad para recoger sus opiniones y necesidades en promoción de la salud.	Realizar la actividad en conjunto con la comunidad de los entornos (polígonos) priorizados del Plan. Se recomienda que una vez priorizados los entornos a intervenir se planifique con la comunidad, perteneciente a los entornos priorizados, las actividades a realizar. Se espera que al momento de haber realizado la planificación se haya basado en distintas fuentes como un diagnóstico participativo, pero no corresponde efectuarlo en esta instancia.	Participación Comunitaria	Participación para involucrar Nivel Comunitario

NOMBRE Y N° ID	OBJETIVO	DEFINICIÓN	RECOMENDACIONES	COMPONENTE	AGRUPACIÓN/ NIVEL PRINCIPAL
Capacitación Líderes Comunitarios . ID_19	Entregar formación a dirigentes y líderes sociales, en participación ciudadana, ejercicio de derechos y promoción de la salud para su empoderamiento en salud.	Consiste en capacitar a personas voluntarias que son reconocidas por su comunidad por promover las prácticas saludables en las familias y el desarrollo de su comunidad, trabajando en coordinación con el personal de salud y con otros actores sociales. En específico se trata de capacitación tipo taller, a través de distintas sesiones educativas, con contenidos asociados a salud y bienestar, condiciones de vida, identificación de inequidades y plan de acción para disminuir brechas de inequidades (el plan puede ser de difusión de información, Revistas, diarios murales, radios comunitarias o puede ser un plan de intervenciones culturales Tocatas, pasacalles, etc. que visibilice las inequidades identificadas en el taller), uso de los espacios públicos y abogacía con gestores sociales del territorio (Intersector local). Asimismo, en las sesiones educativas se pueden implementar “Círculos de escucha”, que corresponden a una estrategia de restauración de la cohesión social cuyo objetivo es promover bienestar y salud en la comunidad perteneciente a un territorio determinado. Esta metodología de trabajo comunitario tiene como propósito construir espacios para la generación de lazos y de redes de apoyo mutuo, compartiendo experiencias y acogiendo las emociones y sentimientos favoreciendo la autodeterminación y el apoyo mutuo.	Se recomienda que la capacitación considere al menos 6 sesiones e incluya la identificación de brechas de inequidades y la elaboración de planes de abordaje barrial o territorial. Se recomienda utilizar guías y materiales MINSAL. Se recomienda efectuar seguimiento a las réplicas de entrega de conocimiento a su comunidad. Si el escenario lo permite, se puede llevar a cabo un proceso de investigación-acción participativa en el que se analiza la realidad para mejorarla en un proceso estrecho de trabajo entre el grupo investigador y la comunidad. En cuanto a los círculos de escucha se recomienda constituir los círculos como espacios de apoyo de índole no clínico, y generando espacios de formación en la metodología con organizaciones u profesionales formados en la metodología.	Participación Comunitaria	Capacitar para aumentar conocimientos y disponibilidad Nivel Comunitario

NOMBRE Y N° ID	OBJETIVO	DEFINICIÓN	RECOMENDACIONES	COMPONENTE	AGRUPACIÓN/ NIVEL PRINCIPAL
Mecanismos de participación . ID_25	Entregar formación a dirigentes y líderes sociales, en participación ciudadana, ejercicio de derechos y promoción de la salud para su empoderamiento en salud.	Los Diálogos y/o Conversatorios, cabildos u otros contenidos en la Ley N°20.500, son un espacio de reflexión y discusión entre la comunidad, con el objetivo de recoger opiniones y propuestas, como también responder a las diversas dudas e inquietudes. Estos mecanismos de participación están abiertos a toda la ciudadanía, especialmente a los grupos históricamente excluidos, por lo que no tiene requisitos para participar. Se realizarán diálogos o conversatorios ciudadanos con la comunidad local sobre distintos temas relacionados con la promoción de salud, el bienestar, la calidad de vida y mejora de los entornos, su población objetivo es organizaciones sociales territoriales y funcionales tales como: Uniones Comunales, Consejos de desarrollo local, Juntas de Vecinos, centros culturales, deportivos y sociales	Se recomienda la realización de Conversatorios para fortalecer la cohesión social, compartiendo experiencias y aprendizajes, fortaleciendo redes de apoyo y fomentando la solidaridad, estos pueden ser conversatorios intergeneracionales entre adolescentes y personas mayores; conversatorios de vida libre de violencia; conversatorio sobre mejoras de entornos. Se recomienda la realización de diálogos en aquellos temas que son importante incorporar a la comunidad y dirigentes sociales en las decisiones locales sobre salud y calidad de vida: dialogo sobre el plan de salud comunal; diálogo sobre políticas de cuidado; diálogo sobre el plan de inversión en el barrio, desde el Estrado o el Municipio. lo importante es que exista el espacio con la metodología adecuada para recoger el aporte de la comunidad	Participación Comunitaria	Participación para involucrar Nivel Comunitario
identificación de activos comunitarios . ID_124	Conocer los recursos comunitarios para su utilización	Localizar y representar gráficamente los elementos positivos de los territorios de manera participativa, aquellos que «mejoran la habilidad de individuos, grupos, comunidades, poblaciones, sistemas sociales y/o instituciones para mantener y sostener la salud y el bienestar y ayudar a reducir las inequidades en salud. Fomenta que las comunidades reorienten su mirada al contexto y se centren en aquello que mejora la salud y el bienestar. Los dirigentes y lideres sociales participan de las actividades metodológicas de identificación, a través de ejercicios guiados como rutas de identificación o mapeos de identificación	Se recomienda utilizar la Orientación técnica para la Acción Comunitaria del Ministerio de Salud.	Participación Comunitaria	Participación para involucrar Nivel Comunitario

NOMBRE Y N° ID	OBJETIVO	DEFINICIÓN	RECOMENDACIONES	COMPONENTE	AGRUPACIÓN/ NIVEL PRINCIPAL
Capacitación en Promoción de la Salud a gestores en lugares de trabajo. ID_123	Sensibilizar a Lugares de trabajo para implementar mejoras que aumenten la disponibilidad de entornos laborales saludables	En lugares de trabajo que estén en los entornos seleccionados (polígonos), capacitar en enfoques de promoción de la salud modos y condiciones de vida, fundamentos de promoción de la salud y herramientas practicas (guía de actividad física laboral, guía de alimentación saludable laboral. etc) tales como actividad física laboral, alimentación laboral, examen de medicina preventiva, sistema de reconocimiento de LPTS, riesgos psicosociales en el trabajo, inclusión y género. Por ejemplo: Realización de capacitación a empleadores, comités paritarios y trabajadores sobre los beneficios de la alimentación laboral saludable tanto para la salud de los trabajadores y la productividad de la institución laboral. Capacitar a empleadores, comités paritarios y trabajadores sobre los beneficios de la práctica regular de actividad física laboral para los trabajadores y para la empresa. Consiste en formar a los actores claves que implementan estrategias de promoción de salud en los lugares de trabajo en aspectos técnicos de actividad física laboral.	Acción complementaria con otros componentes-niveles del Plan y con sistema de reconocimiento vigente. Utilizar pauta de planificación-verificación. Se recomienda que la capacitación sea dirigida a equipos vinculados a las áreas de recursos humanos, bienestar, sindicatos, empleadores, gestores, jefes de área, tomadores de decisión, entre otros.	Educación para la salud	Capacitar para disponibilidad Nivel Comunitario
Taller de huertos Saludables. ID_8	Entregar conocimientos sobre huertos e invernaderos para aumentar la disponibilidad de alimentación saludable.	Implementar talleres prácticos para la creación y mantención de huertos o invernaderos comunitarios.	Acción complementaria con otros componentes-niveles del Plan. Identificar el perfil de las personas que participan de la actividad y buscar la forma de acordar contenidos, responder a la pregunta de por qué se seleccionó este grupo. Se recomienda articular esta actividad con oferta intersectorial que instale huertos o invernaderos comunitarios. Actividad vinculada a actividad de Huertos o invernaderos comunitarios. ID 17.	Educación para la Salud	Capacitar para aumentar conocimientos y disponibilidad. Nivel Individual Comunitario

NOMBRE Y N° ID	OBJETIVO	DEFINICIÓN	RECOMENDACIONES	COMPONENTE	AGRUPACIÓN/ NIVEL PRINCIPAL
Taller educativo en calidad de vida y factores protectores. ID_134	Entregar conocimientos actualizados en calidad de vida y factores protectores de la salud para lograr la autoeficacia.	En el entorno seleccionado (polígono), capacitar en relación a calidad de vida y bienestar, que nazcan del interés de la comunidad, aumentando los conocimientos y habilidades en factores protectores. Por ejemplo: Necesidades de actividad física, alimentación y salud mental en cada etapa del curso de vida, entre otros.	Acción complementaria con otros componentes-niveles del Plan. Se recomienda utilizar guías y materiales elaborados por el Dpto. de Promoción de la Salud y Participación Ciudadana del Ministerio de Salud. Se recomienda recoger los temas de interés para los talleres a través de las actividades del Componente de Participación Comunitaria en el entorno comunal.	Educación para la salud	Capacitar para aumentar conocimientos y disponibilidad Nivel Individual Comunitario
Evento deportivo o campeonatos deportivos. ID_34	Entregar información para motivar y sensibilizar sobre promoción de la salud. Además de generar un espacio de participación comunitaria.	Realizar eventos deportivos masivos que permitan la participación de la comunidad, entregando información, motivación y un espacio de participación comunitaria. Dentro de las actividades a realizar destacan las corridas, caminatas o cicletadas, clases de actividad física, baile entretenido al aire libre, cicletadas, caminatas, entre otras.	Con fines comunicacionales se recomienda potenciar con la actividad Campaña Comunicacional: "Hitos comunicacionales"	Comunicación y Difusión Social	Participación e información para motivar y sensibilizar. Nivel Comunitario

NOMBRE Y N° ID	OBJETIVO	DEFINICIÓN	RECOMENDACIONES	COMPONENTE	AGRUPACIÓN/ NIVEL PRINCIPAL
Materiales de comunicación y plan de medios. ID_125	diseñar y difundir mensajes adaptados a la cultura, idioma y necesidades de la comunidad, que fomenten la participación y comprensión de temas de promoción de salud relevantes, como alimentación saludable y actividad física. Esto se logra mediante la colaboración con medios locales y la evaluación de impacto, promoviendo prácticas de salud efectivas y sostenibles en la población.	Producción creativa, desarrollo de materiales de comunicación y plan de medios Este término abarca todas las acciones relacionadas con la creación de piezas visuales y audiovisuales, como el diseño gráfico, la producción de videos, frases radiales, animaciones y otros materiales que se usarán para la difusión de mensajes comunicacionales. También incluye la creación de diversos formatos y piezas que serán utilizados para transmitir estos mensajes claves, ya sea en formato gráfico, escrito o audiovisual. Y por último, la incorporación de un plan de medios se refiere a la estrategia de distribución de esos materiales a través de distintos canales o soportes (medios tradicionales como TV y radio, y medios digitales como redes sociales, páginas web, etc.). Producción creativa y desarrollo de materiales 1) Creación de infografías, banners, publicaciones para redes sociales. 2) Diseño de logos, boletines, brochures, impresión de folletos, flyers. 3) Producción de contenido audiovisual como videos, documentales, cápsulas informativas, etc. Plan de medios: Utilizar medios de comunicación que sean accesibles, confiables y relevantes para la comunidad local. Con el objetivo de obtener cobertura mediática a través de entrevistas o publireportajes, con temas que nos interesa instalar. 1) Radios comunitarios o regionales: Las radios locales son uno de los medios más efectivos para llegar a comunidades a nivel comunal o regional. Muchos oyentes sintonizan las radios locales por su cercanía, credibilidad y enfoque en temas de interés de la comunidad. Dentro de sus ventajas, existe una alta penetración en áreas rurales o con acceso limitado a internet, capacidad de transmitir en vivo información relevante (alertas sanitarias, campañas de vacunación, etc.), y posibilidad de realizar programas interactivos o entrevistas. Ejemplos: Radios municipales, radios comunitarias, radios educativas o religiosas. 2) Televisión local o regional: Las estaciones de televisión locales suelen tener una audiencia significativa y pueden ser efectivas para transmitir campañas de salud con mayor impacto visual. Dentro de sus ventajas, es que tiene un excelente alcance visual, ideal para campañas educativas con infografías o videos demostrativos, y puede incluir noticieros o programas especiales de salud. Ejemplos: Canales de televisión regionales que cubren eventos locales o se enfocan en temas de interés comunal. 3) Prensa escrita locales y comunales (diarios y revistas): A pesar del auge de los medios digitales, los periódicos impresos siguen siendo un medio importante,	Producción creativa y desarrollo de materiales 1) conocer la audiencia, realizar un análisis del público objetivo, considerando aspectos demográficos, culturales y socioeconómicos. También realizar una segmentación de la comunidad, esto para personalizar los mensajes según sus características. 2) definir el propósito del mensaje, esto identificando los objetivos claros, como establecimiento qué deseos lograr con el mensaje (informar, motivar, educar, etc.) y mensajes específicos, para esto se debe formular mensajes concretos y enfocados que se alineen con esos objetivos. 3) usar un lenguaje accesible, para esto se debe evitar tecnicismos con un lenguaje claro y directo que todos puedan entender. También es recomendable incorporar expresiones y referencias locales para que el mensaje resuene con la comunidad. 4) historias locales como, por ejemplo, utilizar ejemplos o testimonios de personas de la comuna para hacer el mensaje más relatable. 5) Incorporar elementos visuales, para esto se deben ocupar diseños atractivos, utilizando gráficos, imágenes y colores que capten la atención y sean acordes con la identidad local. También, considerar el uso de infografías para resumir información compleja de manera visual y comprensible. Plan de medios Se recomienda priorizar medios más utilizados por la comunidad.	Comunicación y Difusión Social	Diseñar para informar Nivel Comunitario

NOMBRE Y N° ID	OBJETIVO	DEFINICIÓN	RECOMENDACIONES	COMPONENTE	AGRUPACIÓN/ NIVEL PRINCIPAL
		especialmente en comunidades donde el acceso a internet es limitado o la población es mayor. Dentro de sus ventajas, este medio es ideal para publicar artículos educativos, anuncios de salud pública y fechas importantes para eventos de salud, como campañas. Ejemplo: Periódicos comunales, publicaciones de asociaciones vecinales, boletines parroquiales o escolares. 4) Sitios web y portales informativos locales: Los portales digitales comunales y regionales están ganando importancia debido a la expansión del acceso a internet y el uso de dispositivos móviles. Son un canal clave para compartir información de salud, eventos y recursos en línea. Dentro de sus ventajas, Disponibilidad inmediata, capacidad para actualizar la información en tiempo real, y la posibilidad de interactuar con los usuarios a través de comentarios o encuestas. Ejemplos: Páginas web municipales, blogs locales, sitios web de centros de salud comunales o portales informativos independientes. 5) redes sociales locales: Las plataformas como Facebook, Instagram, y WhatsApp son de uso masivo y, a nivel comunal, suelen ser administradas por grupos comunitarios o autoridades locales. Las redes sociales permiten una difusión rápida y con alta interacción. Dentro de las ventajas que tienen es la gran capacidad para viralizar mensajes, facilidad para segmentar a la audiencia, y permiten crear campañas multimedia (texto, imagen, video) de bajo costo. Ejemplos: Páginas de Facebook de municipalidades, grupos vecinales en WhatsApp, y cuentas regionales en Instagram. 6) puntos de difusión física: No todos los medios son digitales o masivos; muchos esfuerzos de comunicación en salud en la comunidad se pueden realizar en puntos físicos estratégicos. Dentro de la visibilidad constante en zonas de alta concurrencia, como centros de salud, mercados, estaciones de transporte público o colegios. Ejemplos: Carteles en centros de salud, flyers distribuidos en mercados, y stands informativos en eventos comunitarios. 7) Buses y transporte público: En áreas urbanas y semiurbanas, los buses o taxis colectivos pueden funcionar como soportes publicitarios móviles muy efectivos. Dentro de las ventajas, se destaca que tiene alcance a una gran cantidad de personas, especialmente en trayectos largos y de alto tráfico.	Implementación de frases radiales privilegiando las radios comunitarias. Difundir e informar a la comunidad la programación de actividades saludables a realizarse en la comuna.		

NOMBRE Y N° ID	OBJETIVO	DEFINICIÓN	RECOMENDACIONES	COMPONENTE	AGRUPACIÓN/ NIVEL PRINCIPAL
Hitos comunicacionales priorizando hábitos saludables, alimentación saludable (GABAS), actividad física y salud mental. ID_129	Motivar cambios positivos en el comportamiento de las personas y comunidades para mejorar su salud y bienestar, mediante la generación de acciones.	Se refiere a un acontecimiento significativo diseñado para transmitir un mensaje específico, promover un tema significativo o generar atención mediática. Estos eventos suelen ser planificados estratégicamente y pueden adoptar diversas formas. Características de esta actividad: 1) Objetivo claro: Cada evento tiene un propósito definido, como un hito, efemérides o crear conciencia sobre un tema relacionado con las líneas del programa. 2) Audiencia específica: Se identifica y se invita a un público objetivo relevante, que puede incluir medios de comunicación, líderes de la comunidad, etc. 3) Mensaje central: Se elabora un mensaje claro y conciso que se desea comunicar durante el evento, alineado con los objetivos del programa. 4) Formatos variados: Puede incluir conferencias de prensa, ferias, Corridas/cicletadas, etc. 5) Interacción: A menudo, estos eventos fomentan la interacción entre los participantes, creando oportunidades para el diálogo y la retroalimentación. 6) Cobertura mediática: Se busca generar atención en los medios de comunicación para amplificar el mensaje y alcanzar a una audiencia más amplia. Aumentar el reconocimiento. Ejemplos: Feria de Salud Comunitaria: Un evento anual o semestral donde se realizan actividades de alimentación saludable, actividad física u otros relacionados con la promoción de salud, Caminatas Comunitarias y Actividades al Aire Libre: Jornadas en las que se organizan caminatas, corridas, cicletadas u otros, en parques locales, incentivando la actividad física gratuita y al aire libre para toda la comunidad. Concursos fotográficos: Se recomienda realizar una Exposición Fotográfica o la recopilación para un catálogo de imágenes. (establecer bases del concurso). Concurso de microcuentos o microrrelatos: Se sugiere realizar difusión de los ganadores. (establecer bases del concurso).	1) Es importante que, al realizar esta actividad, considerar las efemérides en salud 2) Se recomienda que estas actividades deben estar organizadas en conjunto con los equipos de la Seremi de Salud.	Comunicación y Difusión Social	Diseñar para informar Nivel Comunitario

ANEXO Nº 8 Formato de convenio de Planes de Promoción de la Salud para Municipios, Comunas y Comunidades saludables



MINISTERIO DE SALUD
SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
SEREMI DE SALUD XXXXXXXXXXXXX

**CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA EL PROGRAMA PROMOCIÓN DE LA SALUD
ENTRE SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE LA REGIÓN DE XXXXXX
Y LA I. MUNICIPALIDAD DE XXXXXXXXXXXX**

En Santiago de Chile a xxxx de xxxxxxxx de xxxx, entre la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de, representada por su SEREMI don (ña)....., cédula nacional de identidad Nº, ambos domiciliados en calleNº.....de la ciudad de, en adelante **“La Seremi”**, por una parte, y la Ilustre Municipalidad de, persona jurídica de derecho público, R.U.T. Nº....., representada por su Alcalde don(ña), cédula nacional de identidad Nº....., ambos domiciliados en calle Nº....., de la ciudad de, en adelante **“La Municipalidad”**, por la otra, han acordado el convenio de colaboración siguiente:

ANTECEDENTES:

Al Ministerio de Salud, le compete ejercer la función estatal de garantizar el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación de la persona; así como dirigir y orientar todas las acciones del Estado relativas a la provisión de acciones de salud. Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley Nº 2763, de 1979 y de las Leyes Nº 18.933 y Nº 18.469; como en el Decreto Nº 136, de 2004, del Ministerio de Salud que aprobó el Reglamento de la referida Secretaría de Estado.

Alcanzar el más alto nivel de salud posible o el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, es planteado en el año 2000, a través del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Organización de las Naciones Unidas, 2000), ratificando lo planteado en las diferentes cartas de Promoción de la Salud anteriores como en Adelaida de 1988, Sundsvall de 1991, Yakarta de 1997 y Ciudad de México de 2000 y posteriores como Bangkok de 2005, Nairobi de 2009, Helsinki de 2013 y Shanghai de 2016, entendiendo la salud como un derecho humano indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos; proponiendo además ciertas condiciones para el ejercicio de este derecho como la disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la calidad; enfatizando ciertos grupos específicos y en la existencia de condiciones sanitarias mínimas para alcanzar este goce.

El Programa de Promoción de la salud se aprobó mediante la Resolución Exenta Nº 201 de 2012, del Ministerio de Salud, su propósito es contribuir al desarrollo de políticas públicas de nivel nacional, regional y comunal que

construyan oportunidades para que las personas, familias y comunidades accedan a entornos y estilos de vida saludables.

El programa se ejecuta mediante convenios suscritos entre las 16 Secretarías Regionales Ministeriales de Salud (Seremis de salud) con los municipios de su jurisdicción.

El programa se enfoca en la creación y mejoramiento de entornos saludables en el territorio, ya sean físicos, sociales o informativos, contribuyendo al aumento de factores protectores de la salud y favoreciendo la creación de hábitos de vida saludables. Así, se vincula de manera directa con los Objetivos Sanitarios de la década 2021-2030 (Plan y Estrategia Nacional de Salud).

La estrategia apunta a actuar sobre las causas de las causas de los problemas de salud en los territorios, con metodologías ajustadas para trabajar sobre las inequidades e instalar un plan en el espacio local, con un modelo de promoción de la salud, con una visión territorial, pertinente, participativa, integral, sectorial e intersectorial. Además, busca fortalecer el rol del Municipio como un actor estratégico para mejorar los resultados en salud, utilizando una herramienta de gestión que consiste en un plan de Promoción de la Salud.

Los Planes de Promoción de la Salud son elaborados por los municipios utilizando la metodología de marco lógico. Esto requiere que los equipos locales municipales sean capaces de reflexionar sobre el territorio, sobre los determinantes sociales de la salud y sobre la calidad de vida, y traducir las necesidades de las comunas en un Plan único de acción compuesto por actividades que forman parte de opciones establecidas desde nivel central, ajustándose al presupuesto asignado desde las Seremis con criterios de asignación comunal claramente establecidos.

Los Planes de Promoción son parte de la oferta programática del Sistema Elige Vivir Sano (Ley N° 20.670), política pública nacional que tiene por objeto promover hábitos y estilos de vida saludables para mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas, y cuya administración, coordinación y supervisión depende de la Secretaría Ejecutiva Elige Vivir Sano, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

PRIMERO: OBJETIVO

El objetivo del presente convenio es la ejecución del Programa de Promoción de la Salud, en el que se enmarca la estrategia Municipios, Comunas y Comunidades Saludables, cuya finalidad es fortalecer el rol de Municipio, como actor estratégico para mejorar los resultados en salud y la calidad de vida de la población en conjunto con la comunidad e intersector. En este marco se elaboran planes comunales de Promoción de la Salud. El “Plan de Promoción de la Salud”, que se constituye como el instrumento de gestión de la estrategia Municipios, Comunas y Comunidades Saludables, busca implementar medidas que permitan mejorar el acceso de la población a la promoción de la salud a través de entornos saludables.

SEGUNDO: FINANCIAMIENTO

El presente convenio contempla la transferencia de recursos para el cumplimiento de sus objetivos. La Seremi transferirá a la Municipalidad la cantidad de \$ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pesos), que será entregada a contar de la total tramitación del último acto administrativo aprobatorio del presente convenio y que la Municipalidad, se encuentre al día en la presentación de la rendición de cuentas de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N°30 de 2015 de la Contraloría General de la República que fija norma sobre Rendición de cuentas.

Los fondos señalados anteriormente se financian con cargo al Presupuesto de la Subsecretaría de Salud Pública del año xxxx.

Existen recursos suficientes en el presupuesto de la SEREMI para financiar las acciones de salud que establece el Programa de Promoción de la Salud, según da cuenta Certificado de Refrendación Presupuestaria emitido con fecha xxx de xxxxx de xxxx por el jefe del Departamento de Finanzas de la Seremi.

TERCERO: COMPROMISOS DE LAS PARTES

Durante la ejecución del convenio, las partes se comprometen a cumplir las siguientes obligaciones:

A) DE LA MUNICIPALIDAD:

1. Ejecutar el Plan de Promoción de la Salud, incorporado en la planificación contemplada en la plataforma digital que el Ministerio de Salud disponga. Dicho instrumento digital será considerado el único medio oficial para la planificación ejecución, seguimiento, evaluación y comunicación del plan.
2. Contratar a profesional encargado de Promoción de la Salud, en calidad jurídica de planta o a contrata, que cuente con una cantidad suficiente de horas semanales efectivas para el desarrollo del Programa y las horas de recurso humano necesario para las funciones de finanzas que apoyen en los procesos y faciliten el cumplimiento de las actividades. Estas horas serán de costo de la Municipalidad, no formando parte de los recursos entregados por este convenio, a excepción de aquellos casos en que la Subsecretaría de Salud Pública asigne recursos específicos para tal efecto, lo cual se comunicará a través de un oficio a la Seremi correspondiente. Dada la función estratégica que tiene el funcionario encargado de Promoción de la Salud, la Municipalidad deberá tomar las medidas necesarias que resguarden la función, facilitando la continuidad funcionaria y capacitación a quienes realicen estas tareas.
3. Iniciar las gestiones preparatorias para comenzar la ejecución del Plan de Promoción de la Salud a más tardar dentro de los 15 días hábiles, contados desde la transferencia de los recursos.
4. Emitir un comprobante de ingreso de los fondos recibidos por parte de la Seremi dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su recepción. Dichos recursos deben ser ingresados al presupuesto de la Municipalidad.
5. Deberá rendir cuentas de los fondos otorgados, dando estricto cumplimiento a la resolución N° 30 de 2015, de la Contraloría General de la República, que fija las normas de Procedimiento sobre Rendición de Cuentas de entidades públicas y privadas, utilizando el Sistema de Rendiciones Electrónica de Cuentas (SISREC), establecido por la resolución N° 1.858, de 2023, de la Institución Contralora o la normativa que la reemplace.
6. Dicha rendición deberá realizarse mensualmente en SISREC, dentro de los quince (15) primeros días hábiles administrativos del mes siguiente al que se informa y deberá señalar, a lo menos el detalle de los recursos comprometidos, los recursos recibidos en el mes, el monto detallado de la inversión, los pagos y transferencias efectivamente realizados por proyecto o actividad, según corresponda, acumulados al último día de cada mes calendario y el saldo disponible para el mes siguiente.

7. Las rendiciones deberán adjuntar documentación que justifique las operaciones realizadas y que acredite el cumplimiento de las leyes tributarias, de ejecución presupuestaria y de cualquier otro que exijan los reglamentos o leyes especiales sobre la materia. Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de las demás normas sobre rendición de cuentas que los organismos receptores deban cumplir ante la Contraloría General de la República.
8. Deberá custodiar adecuadamente los documentos originales de la rendición, garantizando su autenticidad, integridad y disponibilidad para las revisiones de la Contraloría General de la República, en el marco de la normativa pertinente.
9. Existirá obligación, por parte de la Municipalidad, de reintegrar los fondos transferidos cuando:
 - a) Existan saldos no utilizados, gastos rechazados o gastos no rendidos al momento de vencer el plazo para la ejecución de las actividades del presente convenio o en caso de su término anticipado.
 - b) Los recursos hayan sido destinados a fines distintos a los establecidos en las actividades definidas en el "Plan de Promoción de la Salud" o ellos no hayan sido rendidos con los respectivos documentos de respaldo.
 - c) La Municipalidad no hubiese subsanado las observaciones a la rendición mensual, de acuerdo con lo señalado en el N° 5 de la presente cláusula.
 - d) Finalizado el período de ejecución del presente convenio, junto con la última rendición financiera, la "municipalidad" deberá restituir los recursos observados, no rendidos y/o no ejecutados, conforme al artículo 31 de la Resolución N° 30, de 28 de marzo de 2015, de la Contraloría General de la República de Chile y conforme al artículo xxx° de la Ley de presupuestos N° xxxxxxxx del presente año, sin perjuicio de las normas que rijan al momento de producirse los reintegros.
 - e) De acuerdo con lo establecido por la ley N° 21.722, el Ejecutor se obliga a reintegrar a rentas generales de la Nación cualquier remanente de los recursos aportados y no rendidos, no ejecutados u objetados, deberán hacerlo, a más tardar, dentro del mes siguiente al cierre de la rendición de cuentas del respectivo convenio.
10. Conservar la documentación constitutiva de las rendiciones de cuentas en la forma y lugar señalados por la Resolución N°30, de 2015 de la Contraloría General de la República y demás normas vigentes pertinentes y mantenerla permanentemente a disposición de los supervisores de la Seremi y de la Contraloría General de la República.
11. Incorporar el logo del Ministerio de Salud en todas las actividades y productos relacionados con este convenio, incluyendo las actividades comunicacionales relacionadas.
12. Presentar un "Informe anual de actividades y gastos", dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al plazo de que dispone la Municipalidad para realizar las actividades de las que trata el presente convenio. El Informe deberá detallar el uso y destino de los recursos recibidos y el grado de cumplimiento de los objetivos y actividades señalados en los numerales tercero y cuarto precedentes.

13. Los gastos que se rindan deben estar en el marco de las siguientes consideraciones:

- a) Los recursos para el Plan de Promoción de la Salud sólo pueden destinarse a la contratación de recursos humanos para la coordinación o ejecución del Plan cuando exista aprobación por parte del Ministerio de Salud mediante acto administrativo correspondiente. Se aceptará la contratación a honorarios o compra de servicios para monitores u otro profesional para la realización de actividades específicas, como por ejemplo: talleres contemplados en las actividades del Programa y que son parte de las orientaciones técnicas.
- b) No se aceptarán gastos correspondientes a alcohol, tabaco, alimentos altos en nutrientes críticos (calorías, azúcares, sodio y grasas) u otro ítem nocivo para la salud.
- c) No se pagarán gastos por conceptos de combustibles ni suministros automotrices. No obstante, Sí se autoriza la contratación de buses para el transporte de beneficiarios directos del plan, sin embargo, el traslado de funcionarios se asume como cargo de la municipalidad.
- d) Los bienes inventariables adquiridos deberán quedar registrados en el inventario municipal.
- e) La adquisición de bienes que tengan como beneficiarios a personas que participen de las actividades del Plan de Promoción de la Salud, deben estar contempladas en la planificación validada por la Seremi.
- f) Sólo se aceptarán gastos definidos como autorizados por cada actividad en las Orientaciones Técnicas y que consten en la planificación validada por la Seremi.

B) DE LA SEREMI

- 1. Transferirá a la Municipalidad el monto individualizado precedentemente para la ejecución del Programa y las acciones contempladas en el presente acuerdo y que se incorporará al presupuesto de la Municipalidad.
- 2. Revisará el “Informe anual de actividades y gastos” dentro del plazo de quince (15) días hábiles contados desde su recepción y podrá aprobarlo, rechazarlo, formular observaciones o requerir aclaraciones. En caso de tener observación o requerir aclaraciones respecto del “Informe anual de actividades y gastos”, estas deberán notificarse a la Municipalidad dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al término de su revisión. La Municipalidad tendrá un plazo de quince (15) días hábiles contados desde la recepción de las observaciones o solicitud de aclaraciones, para realizar las correcciones u aclaraciones pertinentes y entregarlas a la Seremi, la que deberá revisarlas dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su recepción.
- 3. Emitirá su conformidad al “Informe anual de actividades y gastos” junto con la aprobación de la rendición de cuentas de la totalidad de los recursos anuales transferidos, comunicando

mediante oficio dicha conformidad y aprobación a la Municipalidad, dentro del mismo plazo señalado precedentemente.

4. Deberá revisar los informes y rendiciones que, en virtud del presente convenio la Municipalidad deba presentar a la Seremi y, cuando corresponda aprobar, observar o rechazar los gastos ejecutados.
5. Deberá apoyar técnicamente a la Municipalidad en el desarrollo de los objetivos y actividades establecidos en el presente convenio.

C) DE AMBAS PARTES

1. Las partes tendrán la obligación de mantener disponible un registro con la documentación técnica que se genere a propósito de la implementación del presente convenio.

CUARTO: MONITOREO

La Seremi realizará un monitoreo técnico trimestral que incluye la evaluación del cumplimiento de las actividades programadas. Este monitoreo estará a cargo del área o unidad encargada de promoción de la salud.

La Seremi realizará un monitoreo financiero mensual que incluye la revisión de la rendición de cuentas de las operaciones, que deberá entregar la Municipalidad mensualmente, verificando el cumplimiento de los gastos informados que corresponden a las actividades comprometidas en el Plan de Promoción de la Salud, quedando facultada para aceptarla, emitir observaciones o bien rechazarla. Este monitoreo estará a cargo del área de desarrollo institucional o finanzas y se realizará dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción de la rendición de cuentas respectiva.

QUINTO: INFORME ANUAL

El día 31 de diciembre de cada año, la Municipalidad enviará a la Seremi el “Informe anual de actividades y gastos”, con sus respectivos verificadores respecto de las actividades realizadas durante el año, el cual deberá contener lo siguiente:

1. Resultado de los indicadores del Programa.
2. Cumplimiento de las metas establecidas en numeral SEXTO.
3. Ejecución financiera.

Asimismo, la Municipalidad informará a la Seremi, de toda circunstancia de que afecte el desarrollo y cumplimiento del Plan de Promoción de la Salud. La Municipalidad se obliga a informar de estos hechos dentro del plazo de 30 días corridos desde su ocurrencia.

SEXTO: CIERRE

La Seremi realizará un cierre anual que contempla una evaluación técnica con base en la rendición financiera anual final. La documentación de respaldo tiene plazo de entrega los primeros 7 días del mes siguiente al cierre cada año y podrá aprobarlo, rechazarlo, formular observaciones o requerir aclaraciones.

SEPTIMO: METAS COMPROMETIDAS POR LA MUNICIPALIDAD

Las metas que se compromete a cumplir la Municipalidad son las siguientes:

1. 90% de cumplimiento de las actividades planificadas anualmente.
2. Ejecución presupuestaria anual de al menos un 90% de los recursos.
3. Cumplir con el registro de la ejecución del Plan en la plataforma dispuesta por el Ministerio de Salud para este fin.
4. Aplicación de instrumentos de evaluación especificados por el Ministerio de Salud.
5. Equipo gestor y comité intersectorial conformado y/o actualizado, oficializados por acto administrativo correspondiente.
6. Envío de rendiciones financieras mensuales dentro de los plazos establecidos en el presente convenio.
7. Cumplimiento de 50% del cronograma planificado para todas las actividades.

OCTAVO: INCUMPLIMIENTO DE CONVENIO

En caso de incumplimiento de cualquiera de las metas estipuladas en la cláusula anterior, la Seremi podrá poner término anticipado al convenio y además solicitar el reintegro de los recursos asignados, en todo o parte dependiendo de lo que se constate como debidamente ejecutado conforme al método de rendición establecido en el presente convenio. En caso de término anticipado del convenio, la Municipalidad deberá presentar el “Informe anual de actividades y gastos” dentro de los quince (15) días hábiles posteriores a la comunicación del término del mismo, en conjunto con el reintegro de los fondos.

NOVENO: MODIFICACIONES

Cualquier modificación al Plan de Promoción de la Salud, deberá quedar registrada en la plataforma dispuesta para ello y validada por la Seremi de Salud. Esta deberá fundarse en una solicitud formalizada por oficio de la Municipalidad respectiva a la Seremi de Salud.

DECIMO: VIGENCIA DEL CONVENIO

El presente convenio comenzará a partir de la total tramitación del último acto administrativo que lo apruebe y hasta el 31 de diciembre del año en curso. Sin perjuicio de lo anterior, la vigencia se extenderá hasta el cumplimiento de todas las obligaciones, incluida la restitución de los recursos no rendidos, observados y/o no ejecutados, hasta el último día hábil del mes de enero del año siguiente.

Las partes acuerdan que el presente convenio se prorrogará en forma automática y sucesiva, en la medida que el Programa de Promoción cuente con la disponibilidad presupuestaria según la Ley de Presupuestos del Sector Público del año respectivo, salvo que el convenio termine anticipadamente como se señala en el numeral Octavo, o que las partes decidan de mutuo acuerdo darle término por motivos fundados.

La prórroga del convenio comenzará a regir desde el 1° de enero del año presupuestario siguiente, y se extenderá hasta el 31 de diciembre de ese mismo año.

Para todos los efectos, la prórroga automática da inicio a un nuevo convenio de transferencia, cuyo monto de financiamiento será informado por la Seremi al Municipio en base a Orientaciones del Nivel Central.

DECIMO PRIMERO: CONTRAPARTES

Para la adecuada implementación, ejecución y seguimiento de este convenio, como asimismo facilitar la coordinación entre las partes, se acuerda la designación de contrapartes técnicas encargadas de la correcta ejecución del presente convenio.

Se designan como contrapartes institucionales de cada parte a:

- Por parte de la SEREMI: Jefe(a) Depto de xxxxxxxxxxxxxxxxx, correo electrónico:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- Por parte de la Municipalidad: la jefatura del Departamento de xxxxxxxxxxxxxxxxx, correo electrónico: xxxxxxxxxxxxxxxxx.

DÉCIMO SEGUNDO: DOMICILIO Y JURISDICCIÓN

Para todos los efectos legales derivados del presente instrumento, las partes fijan su domicilio en la ciudad de Santiago y se someten a la competencia de sus Tribunales Ordinarios de Justicia, sin perjuicio de las atribuciones de la Contraloría General de la República.

DÉCIMO TERCERO: PERSONERÍAS

La Personería del Secretario Regional Ministerial de Salud consta del Decreto N°....., del Ministerio de Salud.

La personería del Alcalde(sa) don(ña)....., para representar a la Ilustre Municipalidad de....., consta en el decreto alcaldicio N°....., de fecha.....

DÉCIMO CUARTO: EJEMPLARES

El presente convenio se suscribe en tres ejemplares de igual tenor y data, quedando uno en poder de la Municipalidad y dos en poder de la Seremi, debiendo remitirse uno de estos últimos al Ministerio de Salud.

SR. (A.).....
SEREMI DE SALUD REGION DE
.....

SR. (A.).....
ALCALDE I. MUNICIPALIDAD
DE.....

BORRADOR